

발 간 등 록 번 호

11-1492000-001012-01

이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구
용역사업의 일환으로 연구되었음

사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 위한
직업재활프로그램 운영수가 개발 및
산재장해인 직업복귀지원 강화 연구

고용노동부
호서대학교 산학협력단

제 출 문

고용노동부장관 귀하

이 보고서를 “사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 위한 직업재활프로그램 운영수가 개발 및 산재장해인 직업복귀지원 강화 연구” 과제의 결과보고서로 제출합니다.

2023. 9.

주관연구기관	호서대학교 산학협력단
책임연구원	이 용 재 (호서대학교 사회복지학부 교수)
공동연구원	임 은 실 (대구보건대학교 간호학과 교수)
보 조 원	김 민 중 (호서대학교 학부생)

※ 본 보고서의 내용은 연구용역과제를 수행한 연구자의 개인적인 의견이므로 고용노동부의 공식적인 견해와는 다를 수 있습니다.

〈제 목 차 례〉

제1장 연구배경 및 목적	1
제1절 연구배경	3
제2절 연구목적 및 기대효과	6
제2장 연구내용 및 수행체계	9
제1절 연구내용	11
제2절 연구수행체계 및 연구방법	13
제3장 사업주 직장복귀계획서 제출제도와 해외사례분석	15
제1절 직장복귀계획서 제출제도	17
1. 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영	17
2. 직장복귀지원 의료기관 지정과 특진	24
3. 사업주 직장복귀계획서 제출 지원	32
제2절 해외사례분석	33
제4장 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영실태와 성과분석	43
제1절 직장복귀계획서 제출현황	45
제2절 근로자와 사업주 만족도	49
1. 근로자 조사	49
2. 사업장 조사	54
제3절 직장복귀계획서 제출제도 운영성과 분석	59
제4절 참여자 의견조사(FGI)	62
1. 근로복지공단 담당직원 면접조사	62

2. 사업주 지원 컨설턴트 면접조사	68
3. 근로자 면접조사	72
4. 직업환경의학과와 재활의학과 전문의 면접조사	73
제5절 운영실태 합의	75

제5장 직장복귀계획서 제출제도 업무 절차분석과 개편방안79

제1절 업무절차의 현황과 문제점	81
1. 요양초기(요양승인 후 3개월 이내)	81
2. 최초상담	83
3. 최초상담 이후 ~ 직업복귀 준비기까지	84
4. 직업복귀지원 기초상담	88
5. 직업복귀준비기	89
6. 직장복귀 자문회의(필요시)	92
7. 사후관리(요양종결 후 6개월 까지)	92
제2절 업무절차 개선방안	94
1. 업무절차 개선방안	94
2. 원직복귀희망자, 소속병원환자 중심 개선방안	99
제3절 업무절차 개선을 위한 과제	103

제6장 직장복귀지원 의료기관 운영현황과 개편방안107

제1절 직장복귀지원 의료기관 운영현황 및 문제점	109
1. 직장복귀지원 직업재활프로그램 개요	109
2. 직업능력 평가	112
3. 직장복귀지원 프로세스 중 직업재활프로그램 운영 과정	113
4. 직장복귀지원의 한계와 개선방향	116
제2절 직업복귀지원 프로그램 운영 개선방안	119

제3절 직업능력 평가방법 및 도구다양화	121
1. 직업능력 평가 장비	121
2. 직업능력 평가시 작업 시뮬레이션 및 직업능력 평가	132
3. 직업능력 평가 방법 다양화	134
제4절 직업능력평가방법 다양화에 따른 수가 개발	144
제5절 직장복귀지원 의료기관 지정기준 변경 방안	155
 제7장 사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화 방안	159
제1절 사업주 및 근로자 지원제도 개선방향	161
1. 사업주 지원제도 개선방향	161
2. 근로자 지원제도 개선방향	164
제2절 사업주 직장복귀계획서 제출제도 의무화 방안	165
제3절 사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화 방안	166
 참고문헌	170
[붙임 1] 직장복귀계획서 제출서식	171
[붙임 2] 직장복귀지원 의료기관 지정기준	173
[붙임 3] 산재관리간호사 재할상담용	174

〈표 차례〉

< 표 4-1 > 사업주 직장복귀계획서 제출현황	45
< 표 4-2 > 사업주 직장복귀계획서 제출의 특성	45
< 표 4-3 > 사업주 대체인력 채용 및 직장복귀예정 여부	46
< 표 4-4 > 사업주 컨설팅 지원현황	46
< 표 4-5 > 특별진찰의뢰현황	46
< 표 4-6 > 직장복귀지원 요양급여 현황	47
< 표 4-7 > 직장복귀계획서 제출제도 만족도 조사결과	47
< 표 4-8 > 직장복귀계획서 제출자와 미제출자 원직복귀율	48
< 표 4-9 > 직장복귀계획서 제출자와 미제출자의 요양기간	48
< 표 4-10 > 제출제도에 대한 인지여부	49
< 표 4-11 > 전반적 만족도	49
< 표 4-12 > 근로자 직장복귀특진 지원 필요성	50
< 표 4-13 > 계획서 제출제도의 직장복귀 도움정도	50
< 표 4-14 > 직장복귀 이후 고용유지를 위한 지원 필요성	50
< 표 4-15 > 계획서 제출제도 인지 경로	51
< 표 4-16 > 제도에 있어서 개선되어야 하는 부분	51
< 표 4-17 > 기타 제출제도에 관한 의견	52
< 표 4-18 > 사업장의 전반적 만족도	54
< 표 4-19 > 사업장에 도움이 된다고 생각하는 정도	54
< 표 4-20 > 제도를 알게 된 경로	55
< 표 4-21 > 지원제도가 계획서 제출에 미치는 영향	55
< 표 4-22 > 사업장에 대한 지원의 충분성	55

<표 4-23> 사업장 작업환경 개선지원 필요정도	56
<표 4-24> 우선적으로 개선되어야 할 부분	56
<표 4-25> 기타 제도 개선을 위한 의견	56
<표 4-26> 직장복귀계획서 제출에 따른 직장복귀율 차이 비교	59
<표 4-27> 직장복귀계획서 제출에 따른 평균 요양일수 차이 비교	60
<표 4-28> 직장복귀계획서 제출에 따른 복귀율 차이비교 성향점수 매칭분석	60
<표 4-29> 직장복귀계획서 제출에 따른 평균 요양일수 차이 비교	61
<표 4-30> 직장복귀계획서 제출과정과 서비스·조직 등 연계	62
<표 4-31> 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안	65
<표 4-32> 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안	67
<표 4-33> 직장복귀계획서 제출과정과 서비스·조직 등 연계	68
<표 4-34> 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안	69
<표 4-35> 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안	70
<표 4-36> 근로자 면접조사 의견	72
<표 4-37> 직업환경의학과 면접조사 결과	73
<표 4-38> 재활의학과 면접조사	73
<표 5-1> 업무절차별 개선내용과 업무주체	95
<표 5-2> 계획서 제출 활성화를 위한 과제	105
<표 7-1> 사업주 지원제도와 개선방향	161

〈그림 차례〉

[그림 1-1] 세부 연구목적	7
[그림 2-1] 세부 연구내용	11
[그림 2-2] 연구수행 체계	13
[그림 3-1] 직장복귀계획서 제출제도 운영절차도	23
[그림 3-2] 특별진찰 업무절차	25
[그림 3-3] 직업복귀소견서 업무 프로세스	31
[그림 5-1] 원직복귀 희망여부와 계획서 제출여부에 따른 통합관리 체계	98
[그림 5-2] 원직복귀 희망근로자 지원 및 의료기관 지원체계	100
[그림 5-3] 직장복귀계획서 제출제도 운영절차 개선(안)	101
[그림 5-4] 직장복귀소견서 발급프로세스 개선(안)	102
[그림 6-1] 소속병원 직장복귀지원 흐름	115
[그림 6-1] 현재 업무 프로세스	120

제 1 장

연구배경 및 목적



연구배경

제1절

- 산재노동자 직업복귀율의 지속 상승에도 불구하고 원직장복귀율은 정체상태로 사업주 협력 등 적극적인 지원방안 마련이 필요하며, 사업주 직장복귀계획서 제출제도의 성공적인 정착을 위한 체계적인 원직장복귀 지원이 요구됨
 - 직업복귀율: (' 17.) 63.5% → (' 18.) 65.3% → (' 19.) 68.5% →(' 20.) 71.5%
 - 원직복귀율: (' 17.) 41.6% → (' 18.) 42.5% → (' 19.) 43.4% →(' 20.) 44.4%
 - － 2022년 최초 요양승인자에 대한 최초상담 2만 1,554명중에 1만 5,257명(70.8%)이 원직복귀를 희망하고 있었음. 반면에 2020년 기준 원직복귀율은 44.4%에 불과하여 원직복귀를 희망하지만 복귀하지 못하는 산재근로자가 다수 있을 것으로 평가됨
- 원직복귀의 중요성
 - 산재근로자가 직업적 능력을 회복하거나 직업으로 복귀하는 것은 주요 재활목표이자, 삶의 만족을 구성하는 중요한 요소임(Johansson & Bernepang, 2003)
 - 산재근로자의 원직복귀는 산재근로자 개인적 측면에서는 본인에게 심리적, 신체적으로 친숙한 직업생활로 돌아가게 됨으로 인해 성공적인 직업복귀가 이루어질 가능성이 매우 높아짐
 - － 이승렬(2004)은 요양종결 후 원직복귀는 주요한 직업복귀 경로로서 고용유지에 결정적으로 작용하며, 퇴직한 산재장애인은 재취업에 어려움을 겪고 있다고 하였고, 전보영 등(2010)의 연구에서도 산재 후 원직복귀 여부는 지속적인 삶의 만족도에 효과를 미친다고 함
 - 그리고 본인의 산재로 인한 기능손실에도 불구하고 타직복귀에 비해 임금보존율이 높아 경제적인 이득도 높은 것으로 파악됨. 2011년 미국 미네소타주 산재보험연례보고서에 의하면 산재당시 고용주(원직장복귀)에게 복귀했을 경우 임금율이 101.6%인데 비해, 상이한 고용주(타직장복귀)에게 복귀했을 경우 임금율이 78.7%로 낮아지는 것으로 보고됨
 - 그 외에도 산재근로자의 조기원직복귀가 주는 혜택은 첫째, 휴업급여의 감소로 인한 산재보험기금 절감, 둘째, 요양기간의 단축과 의료 및 장애 관련 비용의 감소, 셋째, 산재요율의 조정을 통한 보험료 경감, 넷째, 숙련된 노동력의 손실 방지와 이직감소, 다섯째, 노동력의 대체에 필요한 직업배치와 훈련비용 절감, 여섯째, 산재급여보다는 임금지급을 통한 경제성 증대 등임(이달엽 외, 2010)

□ 산재노동자가 보다 원활하게 원래의 직장으로 복귀할 수 있도록 치료과정에서부터 사업주의 참여와 협력을 이끌어내고자 2021년 사업주 직장복귀계획서 제출제도를 법제화하고 2022년 3월부터 부터 시행함(산업재해보상보험법 제75조의2(직장복귀 지원) 개정)

○ 사업주 직장복귀계획서 제출제도로 산재노동자가 다시 일터로 복귀하기 위해서는 치료를 마치고 스스로 사업장을 찾아가서 다시 일할 수 있는지를 본인이 직접 사업주와 상담을 해야 하는 등 여러 가지 어려움이 상당 부분 해소될 것으로 기대됨. 궁극적으로 원직복귀를 위한 ‘사업주와 근로자간 협력의 제도화’로 원직장복귀율 향상을 기대함. 직장복귀계획서 제출제도 운영절차는 다음과 같음

① 원직복귀 의사 확인(산재노동자) → ② 소속 산재노동자 요양정보 제공 및 제도 안내(사업주) → ③ 직장복귀계획서 제출요구(사업주) → ④ 사업주지원제도 연계 및 특진 → ⑤ 직업복귀소견서 제공(요청시, 직장복귀지원 의료기관) → ⑥ 복귀 이행 모니터링

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도는 산재노동자의 이러한 어려움을 해소하기 위해서 업무상 재해가 발생한 사업장의 사업주가 소속 산재노동자에 대한 복귀계획을 작성해 근로복지공단에 제출하는 제도임

○ 산재보험에서는 사업주가 제출한 직장복귀계획이 원활히 이행될 수 있도록 작업 능력과 직장복귀 가능성을 의학적으로 보여주는 직업복귀소견서를 사업주에게 제공하고, 대체 인력지원금, 직장복귀지원금 등 직장복귀에 필요한 각종 지원금을 제공함. 또한, 직무의 원활한 수행을 위해 작업능력 향상이 필요하다고 판단되면 산재노동자의 직무에 맞는 신체기능 향상 훈련, 모의작업 훈련 등 작업능력강화 훈련도 지원함

-
- (대체인력지원금) 산재노동자가 요양으로 취업하지 못한 기간에 대체 인력을 신규로 채용한 사업주에게 월 60만원 범위 내 최대 6개월까지 지원하는 제도
 - (직장복귀지원금 등) 사업주가 산재노동자(장해 12급 이상자/예정자)를 복귀시켜 6개월 이상 고용을 유지한 경우
 - (직장복귀지원금) 월 45~80만원(최대 12개월)까지 지원
 - (직장적응훈련비) 직장적응훈련(직접 또는 위탁훈련)을 실시하는 경우 월 최대 45만원(3개월) 범위 내에서 그 비용을 지원
 - (재활운동비) 신체 능력회복 위한 재활운동비를 월 15만원(3개월) 지원
-

□ 근로복지공단의 전문적인 의학적 지원을 위해 전문성 있는 인력·시설·장비 등을 갖춘 산재보험 의료기관을 “직장복귀지원 의료기관”으로 지정해 운영하며, 전문성을 고려해 현재공단 직영병원 등 10개소에서 민간병원으로 점차 확대할 계획임

○ 직장복귀지원 의료기관은 산재보험 의료기관 중 고용노동부령으로 정하는 재활 관련 인력 및 시설 등을 갖춘 의료기관으로 산재노동자의 직장복귀에 필요한 기본 직무분석, 작업능력평가, 작업능력강화 훈련, 직업복귀소견서 작성을 지원함

○ 「직장복귀지원 의료기관 요양급여 산정기준」신설을 통한 적용수가(기본직무분석, 작업능력강화훈련, 작업능력평가, 직업복귀소견서)를 마련하여 운영하고 있음

- 2022년 10월말 까지 직장복귀계획서를 제출한 산재노동자에 대하여 근로복지공단의 평가 결과 산재노동자가 발생한 사업장에서 사업주가 근로복지공단에 '직장복귀계획서'를 제출하는 경우 산재노동자의 원직장 복귀율이 85.6%로 같은 기간 전체 산재요양종결자의 원직장 복귀율 45.3%보다 2배 가까이 높았음. 따라서 사업주 직장복귀계획서 제출제도의 정착과 활성화가 산재근로자 원직장 복귀의 향상에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대됨
- 특히, 직장복귀계획서를 제출한 사업장 가운데 상시근로자 50인 미만 사업장이 61.2%를 차지하고 있어 소규모 영세사업장 소속 산재노동자의 원직복귀율 제고에 큰 도움이 될 것으로 평가됨

- 그러나, 사업주 직장복귀계획서 제출은 제출대상의 10%미만을 보이는 등 실적이 저조한 상황임. 이는 제도 시행 초기로 홍보·안내가 부족한 것이 주요한 원인으로 판단됨
- 사업주의 계획서 제출이 미진한 것은 '계획서 미제출에 따른 불이익 등 강제수단 부재, 대기업은 노동조합 등 원직 복귀 지원 주체 존재, 사업주와 산재근로자의 좋지 않은 유대관계, 근로자 요양 장기화에 따른 사업주 직장복귀 꺼림 현상' 등도 요인으로 작용한 것으로 판단됨

- 따라서, 사업주 직장복귀계획서 제출이 산재근로자의 원직장 복귀를 높이고 궁극적으로 사회적 복귀하는 데 중요한 역할을 하고 있는 만큼, 다음과 같은 내용에 대한 종합적인 분석을 통해 제도보완방안을 마련할 필요가 있음
- 첫째, 사업주 직장복귀계획서 제출대상과 절차는 적절한가? 구체적으로 제출대상이 적합한지, 대상 사업장과 근로자에 대한 제도안내 등 홍보가 제대로 이루어지고 있는지, 지원인력과 관련 부서간 연계체계가 적절한지, 사회복귀지원 서비스와 잘 연계되고 있는지, 절차에 따라서 산재근로자와 사업주에게 적절한 지원이 이루어지고 있는지 등을 확인해야 함
- 둘째, 직장복귀지원 의료기관의 운영은 적절한가? 구체적으로 의료기관내 전문인력간 협업체계, 제도지원에 대한 합리적인 수가보상이 이루어지고 있는지, 직장복귀특진이 환자특성을 고려하여 효율적으로 운영되는지 등을 확인해야 함
- 셋째, 사업주와 근로자 지원은 적절한가? 구체적으로 사업주와 근로자에 대한 현재 지원제도의 충분성과 적정성을 확인하고 추가적으로 무슨 지원이 필요한지 확인해야함

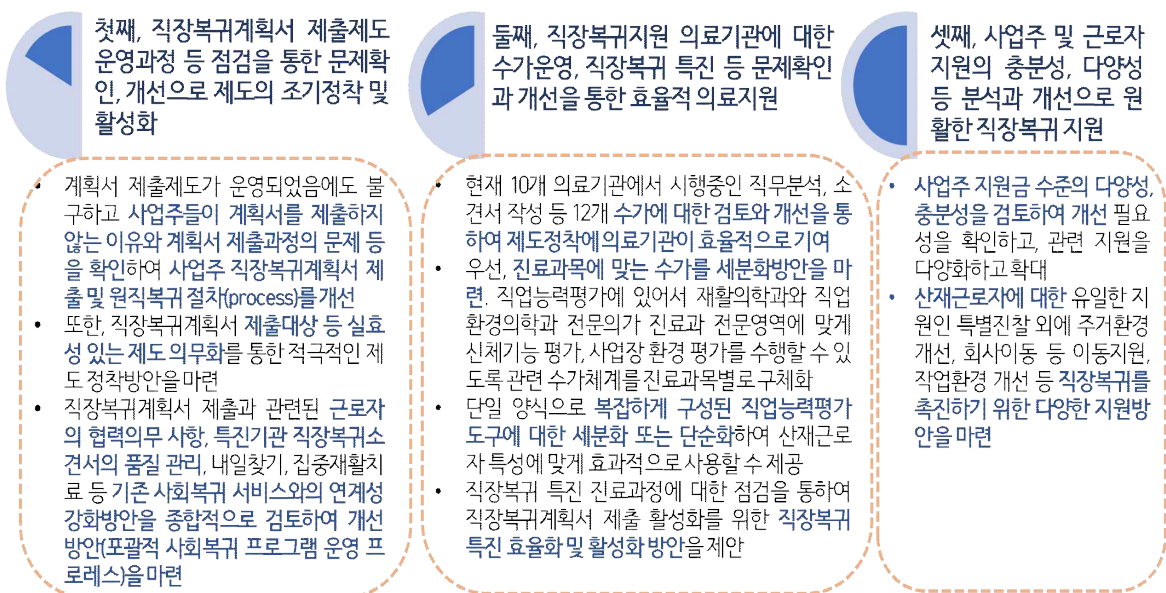
연구목적 및 기대효과

제2절

- 본 연구는 산재장애인의 원직장복귀율을 높이기 위한 사업주 직장복귀지원제도 운영현황과 실태, 문제점 등에 대한 분석과 선진사례에 대한 종합적 검토를 통해 해당 사업의 성과와 한계를 평가하고 사업주 직장복귀계획서 제출제도를 활성화하기 위한 방안을 마련하기 위한 연구임
- 이러한 논의를 통하여 제도 개선방안을 다음 연구영역에서 도출하고자 함. 1) 직장복귀계획서 제출제도 운영과정 영역 2) 직장복귀지원 의료기관 활동 영역 3) 직장복귀계획서 제도 활성화를 위한 사업주와 근로자 지원영역을 등을 중심으로 연구하여 개선방안을 도출하고자 함. 구체적으로 본 연구의 목적은 다음과 같음
- 첫째, 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영현황에 대한 점검을 통하여 문제점을 확인하여 개선함으로써 직장복귀계획서 제출제도의 조기정착 및 활성화에 기여함
 - 구체적으로 지난해 직장복귀계획서 제출제도가 운영되었음에도 불구하고 사업주들이 계획서를 제출하지 않는 이유와 계획서 제출과정의 문제 등을 확인하여 사업주 직장복귀계획서 제출 및 원직복귀 절차(process)를 개선함
 - 직장복귀계획서 제출과 관련된 근로자의 협력의무 사항, 특진기관 직장복귀소견서의 품질 관리, 내일찾기, 집중재활치료 등 기존 사회복지 서비스와의 연계성 강화방안을 종합적으로 검토하여 개선방안을 마련함
 - 직장복귀계획서에 관련되어 있는 의료기관, 소속기관 등 관련 주체와 부서, 업무인력 간 소통과 연계체계가 원활이 이루어지고 있는지를 확인하고 개선방안을 마련함
 - 직장복귀계획서 제출대상 등 실효성 있는 제도 의무화를 통한 적극적인 제도 추진방안을 마련함
- 둘째, 직장복귀지원 의료기관의 업무수행과정과 인력간 협력체계, 업무관련 절차에 대한 확인을 통하여 의료기관에서 직장복귀지원을 효율적으로 수행할 수 있도록 함
 - 진료과목에 맞는 수가 세분화 방안을 마련함. 구체적으로 작업능력평가에 있어서 재활의학과와 직업환경의학과 전문의가 진료과 전문영역에 맞게 신체기능 평가, 작업장 환경 평가를 수행할 수 있도록 관련 수가체계를 진료과목별로 명확히 함
 - 단일 양식으로 복잡하게 구성된 작업능력평가 도구를 세분화 또는 단순화하여 산재근로자 특성에 맞게 효과적으로 사용할 수 있도록 함. 즉, 전체 신체기능을 평가하여야 하는 대상자와 그렇지 않은 대상자를 구분하여 평가할 수 있는 양식을 구분하여 운영

하는 방안을 마련함

- 직장복귀특진 진료과정에 대한 점검을 통하여 직장복귀계획서 제출 활성화를 위한 직장복귀특진 효율화 및 활성화 방안을 제안함
- 셋째, 직장복귀계획서 제출 활성화와 계획서 제출 이후 원활한 산재근로자 직장복귀를 지원하기 위한 사업주 및 근로자 지원방안을 마련함
 - 사업주 지원수준의 적정성을 검토하여 개선 필요성을 확인하고, 관련 지원을 다양화할 수 있는 방안을 마련함
 - 산재근로자에 대한 유일한 지원인 특별진찰 외에 주거환경 개선, 회사이동 등 이동지원, 작업환경 개선 등 직장복귀를 촉진하기 위한 다양한 지원방안을 마련함



[그림 1-1] 세부 연구목적

- 본 연구는 2022년 3월 사업주에게 직장복귀계획서를 제출하도록 한 이후 최초로 관련 제도운영 실태와 문제점을 파악함으로써 제도의 정착과 발전에 기여할 수 있을 것임
- 직장복귀계획서 제출을 촉진하기 위한 직업복귀지원 의료기관의 역할 활성화를 위한 수가개선 및 업무효율화 방안을 마련하여 보다 효과적으로 원직복귀를 지원할 수 있을 것으로 기대함
- 사업주 직장복귀계획서 제출 활성화를 통하여 산재근로자의 원직복귀를 지원하기 위하여 사업주, 산재근로자, 의료기관이 원활하게 협업할 수 있는 제도적 지원체계를 마련할 수 있을 것임
- 이를 통해서 산재근로자가 재활을 통한 원직장 복귀 등 직장복귀율을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨
- 연구결과는 직장복귀계획서 제출 활성화를 위한 법령 및 제도개선과 직장복귀계획서 활성화를 위한 직장복귀지원 요양급여 수가 개선의 근거자료로 활용할 수 있을 것임

제 2 장

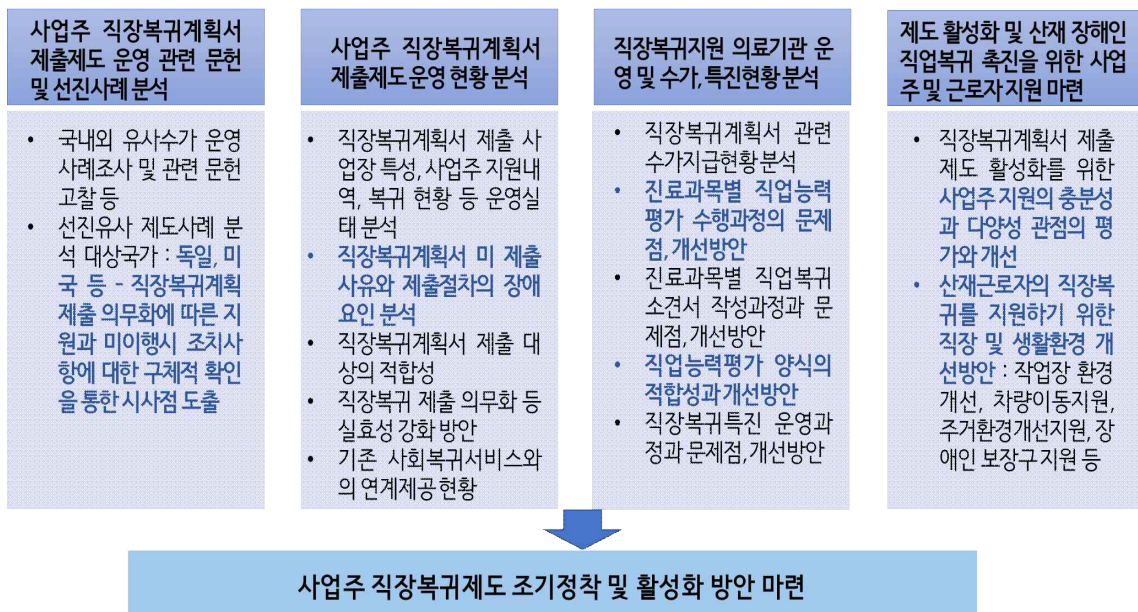
연구내용 및 수행체계



연구내용

제1절

□ 본 연구는 사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 통해서 원직복귀를 활성화하기 위한 목적으로 수행되는 연구로 다음 4가지 영역을 연구내용으로 함



[그림 2-1] 세부 연구내용

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영 관련 문헌 및 선진사례를 분석함
 - 국내외 유사 수가 운영 사례 및 문헌을 고찰하고 독일, 일본, 영미권 등 주요 선진사례를 분석함으로써 직장복귀계획의 절차, 직장복귀 촉진을 위한 사업주 및 근로자 지원정책, 미이행시 조치사항, 장애인 국내외 작업 및 생활환경 개선 지원제도 조사 등의 방향성을 마련함
- 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영현황 분석 및 프로세스 개선방안을 마련함
 - 직장복귀계획서 제출 사업장 특성, 사업주 지원내역, 복귀현황, 고용유지 현황 등 운영실태를 분석하고, 직장복귀계획서 미제출 사유, 직장복귀계획서 제출 프로세스 장애요인을 확인함. 아울러 직장복귀계획서 제출 대상의 적합성을 평가하고 직장복귀 제출의

무화 등 실효성 제도강화 방안을 위한 근거자료를 확보함

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도가 원직장 등 직장복귀에 미친 영향을 확인하기 위하여 계획서를 제출 근로자와 미제출 근로자의 직장복귀율과 요양기간의 차이를 비교함
- 제출제도에 대한 현황분석에 기초하여 사업주 직장복귀계획서 제출 활성화를 위한 프로세스 개선방안을 마련함

□ 직장복귀지원 의료기관 운영 및 수가, 특진현황 분석을 통하여 직장복귀지원 의료기관 역할 활성화 방안을 마련함

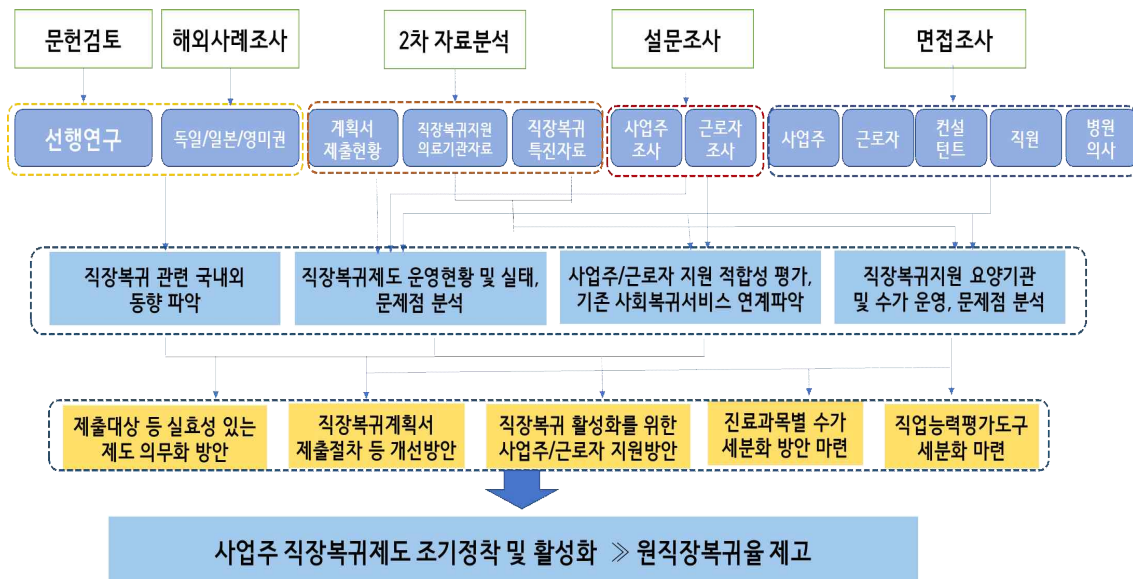
- 직장복귀계획서 관련 수가지급현황 분석, 직장복귀 특진 운영과정과 문제점, 진료과목별 작업능력평가 수행과정과 문제점, 진료과목별 직업복귀소견서 작성과정과 문제점 등을 확인하고 개선방안을 마련함
- 작업능력평가 양식의 적합성을 확인하여 환자특성을 고려한 양식을 개발하고, 진료과목별 전문성을 고려한 평가방법을 마련함

□ 직장복귀계획서 제출제도 활성화 및 산재장해인 직업복귀 촉진을 위한 사업주와 근로자 지원방안을 마련함

- 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 위해 제공되고 있는 사업주와 근로자 지원방안의 충분성과 적합성 등을 확인하고 지원제도의 개선방향을 제시함. 특히, 작업장 환경개선, 차량 이동지원, 주거환경 개선지원, 장애인 보장구 지원 등 필요성을 검토함

제2절 연구수행체계 및 연구방법

- 본 연구의 연구수행체계는 다음 그림과 문헌조사, 해외사례조사, 2차 자료 분석, 설문조사, 면접조사를 통하여 제도운영의 근거와 현황, 문제점을 확인하고 세부적인 개선방안을 마련하는 과정을 거침



[그림 2-2] 연구수행 체계

- 문헌검토와 해외사례 조사, 2차 자료 분석
- 국내 제도운영을 위하여 수행된 연구보고서 등 국내외 관련 문헌을 확인하고 직장복귀 계획 관련 제도를 운영하고 있는 독일, 일본, 영미권 등에 대한 조사를 실시함
 - 공단이 보유하고 있는 직장복귀계획서 제출현황, 직장복귀지원 의료기관 운영 현황, 직장복귀 특진 관련 자료들을 종합적으로 분석함
- 집단면접조사와 설문조사
- 연구수행을 위하여 산재근로자, 사업주를 지원하는 컨설턴트, 근로복지공단 담당직원, 병원에 근무하는 재활의학과 및 직업환경의학과 전문의에 대한 면접조사를 실시함
 - － 직장복귀계획서 제출 시 절차상 장애요인 분석, 직장복귀계획서 제출제도 프로세스

- 개선방향, 직장복귀계획서 제출대상 확대(변경)방향, 직장복귀계획서 의무화 등을 통한 실효성 확보방안, 사업주와 근로자 지원의 충분성과 다양성 수준, 직업복귀를 위해 제공받는 서비스 이용시 문제점 확인, 직장복귀지원 의료기관 지원과정의 문제점 확인 등을 실시함
- 직장복귀계획서 제출 관련 애로사항과 지원 필요사항들을 확인하기 위하여 사업주와 근로자에 대한 설문조사를 실시함
 - － 사업주 직장복귀계획서 제출과정에서 겪는 어려움, 사업주/근로자를 위한 지원정책의 충분성과 다양성 수준, 사업주와 근로자가 원직복귀를 추진하는데 겪는 애로사항, 사업주 또는 근로자 입장에서 직장복귀를 위해서 필요한 지원, 의료기관의 직업복귀 지원에 있어서 어려웠던 점, 의료기관의 직업복귀 특진에 있어서 어려웠던 점 등을 확인함
 - 전문가 자문 및 의견조사
 - 산재재활 관련 분야 전문가, 요양급여 수가 관련 전문가 의견수렴을 통하여 사업주 직업복귀계획서 제출제도 및 의료기관 지원 관련 개선방안을 마련함

제 3 장

사업주 직장복귀계획서 제출제도와 해외사례분석



직장복귀계획서 제출제도

제1절

1. 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영

1) 추진방향 및 근거법령

□ 근거법령

○ 산업재해보상보험법 제75조의2(직장복귀 지원)

- ① 공단은 근로자의 원직복귀를 위해 재해 당시 사업주에게 ‘직장복귀계획서’ 작성·제출 요구
- ② 공단은 사업주의 직장복귀계획서 작성과 내용 이행에 필요한 지원
- ③ 근로자의 직장복귀 지원을 위해 요양기간 중 산재보험 의료기관에 직업능력 평가 등을 의뢰하여 조치
- ④ 공단은 산재보험 의료기관 중 인력 및 시설 등을 갖춘 의료기관을 직장복귀 지원 의료기관으로 지정·운영
- ⑤ 직장복귀지원 의료기관은 요양급여의 산정기준 및 의료기관의 평가 등 우대

○ 시행령·시행규칙

■ 산업재해보상보험법 시행령 제71조의 2(직장복귀지원) 주요 내용 요약

- [대상] 업무상 부상·질병으로 산재장해 또는 6개월 이상 요양이 예상되는 자
- [지원조치] 재활치료 필요여부 판단, 직업능력평가, 작업능력강화 등을 위한 지원, 장해를 고려한 작업환경 개선 또는 직무전환을 위한 지원 등

■ 산업재해보상보험법 시행규칙 제61조의 3(직장복귀지원 의료기관의 지정) 주요 내용 요약

- 지원조치 관련 요양급여 범위·비용 : 고용부장관 승인에 의한 산재보험 요양급여기준 별도 적용
- 직장복귀계획서 제출기한(30일) 및 계획서에 포함될 기본 사항
- 공단의 직장복귀 자문회의 구성·운영에 관한 사항 위임
- 직장복귀지원 의료기관 지정기준 및 제출서류에 관한 사항
- 공단의 직장복귀지원 의료기관 평가 및 취소에 관한 사항 위임

2) 업무절차별 운영계획

□ 업무절차 개요

구분	내용	주체
125 요양초기 (요양승인후 3개월 이내)	● 사업 직장귀계획서 지원대상 선정 ① (요양승인 후 21일 이내) 산재노동자 대상 최초상담 진행 및 안내 모바일 발송(복귀의사확인) ※ 대상:상용노동자(노동보험 종사상지위 기준)중 중증도지수 경미이상이거나, 요양급여신청서(최초요양급여신청서)상 소견서의 입통원 등 예상기간이 6개월 이상인 자 ② 사업주 안내 DM발송 ※ 대상: 원직복직 의사확인 및 개인정보동의로 회신된 산재노동자의 사업주 ● 집중재활치료 대상 조기 재활특진 안내 ※ 대상 : 집중재활치료 대상자(근골격계, 중추신경계) 등	소속기관
↓		
245 사업주 및 산재노동자 지원(요양중)	● 사업주 직장복귀 지원 - 직장복귀계획서 제출제도 및 사업주지원제도 안내 (직장복귀지원금, 대체인력지원금 등) - 산재노동자 요양기간 결정 정보 등 (요양·보험급여결정통지서(사업주용) 제공 ● 근로자 재활상담 지원 - 재활특진 등 재활상담 진행(대상 : 산재노동자) (산재관리간호사, 잡코디네이터)	소속기관 소속기관 소속병원
↓		
36 직업복귀 준비기 (최초상담 직후~요양 종결 3개월 전까지)	● 사업주 직장복귀계획서 제출 요구 및 작성 지원 ● 직장복귀지원 특별진찰 의뢰 : 제출된 직장복귀계획서에 직업복귀 소견서 요청시 ● 직장복귀지원 특별진찰 진행 (직업복귀소견) : 기본직무분석 + 작업능력평가 + (필요시 진행) 작업능력강화훈련[전원필요]	소속기관 직장복귀 지원의료 기관
↓		
7 직장복귀자문 회의(필요시)	● 직장복귀계획서 전문가 자문 - 제출된 직장복귀계획서의 변경 검토가 필요한 경우 - 직업복귀소견서에 대한 전문가 자문이 필요한 경우 등	지역본부
↓		
8 사후관리 (요양종결후 6개월까지)	● 직장복귀계획서 이행 관련 고용유지 모니터링 - 직장복귀지원금 및 대체인력지원금 등 지급	소속기관

(1) 적용 대상

- (산재노동자) 요양 중인 산재노동자로 요양 종결 후 장애가 남거나 6월 이상 장기요양 예상, 직장복귀 지원이 필요한 자
 - － 사업주에게 예상치료기간 등 산재 요양정보 제공을 동의하고, 사업주 직장복귀계획서 제출제도 참여를 희망하는 산재노동자(원직복귀 비희망자, 사실상 원직복귀가 어려운 자는 적용 제외)
- (사업주) 적용대상 산재노동자의 재해당시 사업주

(2) 산재노동자 및 사업주 최초상담

- (산재노동자 상담) 요양승인 후 21일 이내 최초상담 진행, 원직장 복귀 의사 및 직장복귀계획서 제출제도 관련 정보제공 동의 확인
 - － 요양급여신청서(최초요양신청서) 및 중증도 지수를 근거로 대상자 선정
 - － 복귀의사, 제출제도 개인정보 동의는 유선 안내 및 모바일 동의 회신 활용
 - － 사업주 직장복귀계획서 제출제도 사업취지 설명을 통한 개인정보 동의 안내
- (사업주 상담) 산재노동자 원직복귀 욕구 파악 후 대상 사업주에게 DM안내문 발송, 필요시 유선상담 진행
 - － 직장복귀계획서 제출제도 취지 설명, 소속 산재노동자 원직복귀 의지 전달, 대체인력 지원제도 등 사업주 지원사업 정보 제공
- (개인정보 동의) 최초상담 등 서비스 담당자(또는 직장복귀계획서 처리담당자)가 산재노동자의 복귀의사 확인 및 개인정보 동의절차 진행
 - － (사업주 협조) 직장복귀계획서를 통해 ‘직업복귀소견서’ 제출을 요구하는 사업주는 계획서 제출시 정보제공에 관한 근로자 본인 확인 협조 요청
- (내일찾기서비스 대상) 산재노동자가 내일찾기서비스 대상인 경우, 직장복귀계획서 제출 및 지원사항을 재할계획 수립시 반영·진행

(3) 직장복귀계획서 제출

- (업무처리) 사업주에게 직장복귀계획서 제출제도 취지 설명 후 계획서 제출 요구
 - － 제출서식에 따라 소속근로자의 직장복귀 가능 여부 및 수행 예정 직무, 사업주 지원사업 안내 희망 여부 등을 작성·제출
- (요구시기) 산재노동자 최초상담 진행 후 1개월 이내(요양 승인 후 2개월 이내) 제출 요구 진행, 다만, 6개월 이상 요양자는 회복상태를 감안, 요양종결 3개월 이전까지는 계획서 제출·처리 완료(제출기간 30일)
- (계획서 처리) 제출된 계획서 접수처리 후, 사업주 요구사항 파악, 사업주 지원사업 연계 및 직장복귀 지원 특별진찰 진행
 - － 직업복귀소견서 요청이 있는 경우 소속 근로자 및 주치의 상담을 통해 특진 일정협

의, 가급적 요양종결 3개월 이전 특진 의뢰

(4) 사업주 직장복귀지원

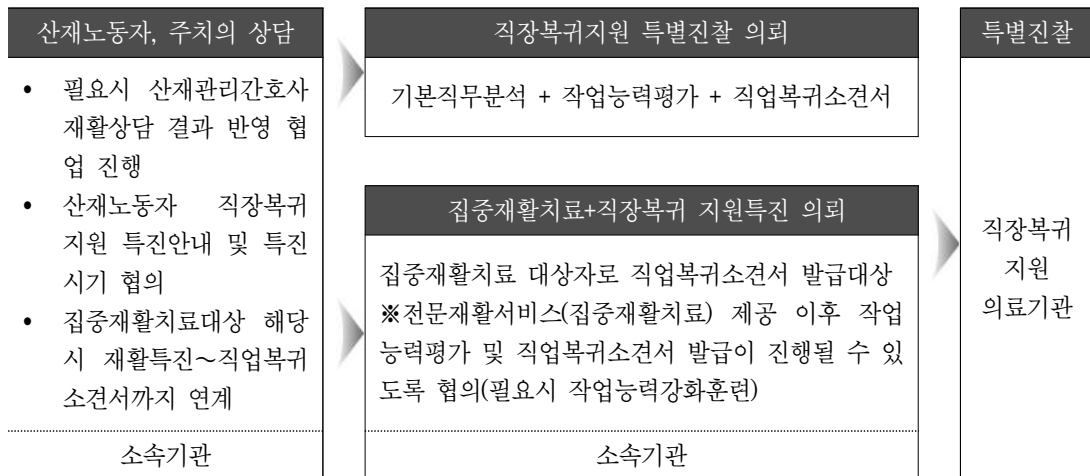
- (지원업무) 사업주의 소속 산재노동자에 대한 직장복귀계획서 작성 및 이행을 지원
- 제출된 직장복귀계획서에 따라 사업주 대상 맞춤지원
 - － 사업주의 지원 요청 사항, 산재노동자 요양종결 후 사업주지원사업 연계를 통한 지원금 지급 등
 - － 직장복귀계획서에 따라 요양 중 직장적응훈련, 직장동료화합프로그램 등 사업장 지원, 요양 종결 후 대체인력지원금, 직장복귀지원금 등 지급

(5) 재활특진 연계

- (재활특진 조기의뢰) 직장복귀계획서상 직업복귀소견서 제출요구가 확인된 산재노동자로 집중재활치료 대상 승인 상병이 있는 경우, 재활특진 적극 안내 및 상담
- (특진시기) 근골격계질환자는 재해일 또는 수술일로부터 6주~8주 이내, 중추신경계 질환자는 주치의 소견에 따라 결정
- (산재관리간호사 재활상담) 사업주 직장복귀계획서에 직업복귀소견서 제출을 요구한 사업장의 산재노동자 대상 상담 진행
 - － 재활상담(유선)을 통한 상병 등 요양단계 파악, 재활효과 및 필요성 등 재활특진 제도 안내 및 연계업무 진행
 - － 산재환자 조기 재활진입 필요성 및 효과를 의료적 관점에서 설명, ‘재활특진’ 또는 ‘집중재활치료’ 정보 제공
- (잡코디네이터 재활상담) 최초상담 이후 주치의 상담을 통한 상병상태 파악, 필요시 재활특진 제도 안내 및 특진 시기·필요성 협의
 - － 산재관리간호사 재활상담 입력내용 적극 활용, 재활특진으로 진행될 수 있도록 동시 지원상담 진행
 - － 직장복귀계획서가 제출된 내일찾기서비스 대상자는 요양초기 재활특진 적극 안내

(6) 직장복귀 지원 특별진찰

- (지원대상) 직장복귀계획서를 통해 직업복귀소견서 발급이 요청된 산재노동자
 - － 제출된 직장복귀계획서에 직업복귀소견서 ‘희망’ 표시된 경우 해당
- (처리절차) 직장복귀계획서 처리 담당자는 산재노동자 및 주치의 상담 등을 통해 진료계획 확인 및 특진일정 협의(소견서 제공에 관한 동의 여부 재확인)



- (특진의뢰) 협의된 특진일정에 따라 직장복귀지원 의료기관 특진 진행, 가급적 요양종결 예정일 3개월 이전 관련 절차 진행
- (전원처리) 직장복귀지원 특진 진행시 산재노동자가 특진의료기관 전원을 희망하고, 작업능력강화 훈련에 대한 특진의 소견이 있는 경우
 - ‘원직복귀 어려움’ 예상 등 작업능력강화 훈련 필요에 대한 특진의 소견
 - 작업능력강화훈련 종료 후 직업복귀소견서 발급을 위한 특진(소견조회) 진행
- (결과제공) 특진 의료기관에서 회신된 직업복귀소견서는 소속기관에서 사업주·산재노동자에게 제공, 필요시 계획서 변경 제출 요구

(7) 직장복귀 자문회의

- (자문대상) 직장복귀계획서 제출이후 원직복귀 이행과정에 이견이 있는 사업주 또는 산재노동자
 - 특별한 사유없이 원직복귀 이행을 거부하는 사업주 또는 직장복귀지원 의료기관의 ‘직업복귀소견서’에 이견이 있는 경우 해당
- (자문진행) 소속기관 자문건을 취합, 지역본부에서 월 1회 이상 회의
- (자문내용) 제출된 직장복귀계획서 변경사유 타당성 및 직업복귀소견서 결과에 관한 전문가 자문
- (회의구성) 의사(재활의, 직환의), 변호사, 공인 노무사, 근로감독관 등 5인 이상 내·외부 자문위원으로 구성

(8) 고용유지 모니터링 등 사후관리

- 산재노동자 요양종결 이후 6개월 동안 2회(종결 후 2~3개월 시점 1회, 종결 후 6개월 1회) 진행
 - 산재노동자 고용보험 피보험 자격유지 사실 등 개발된 전산조회를 통한 고용유지 모니터링

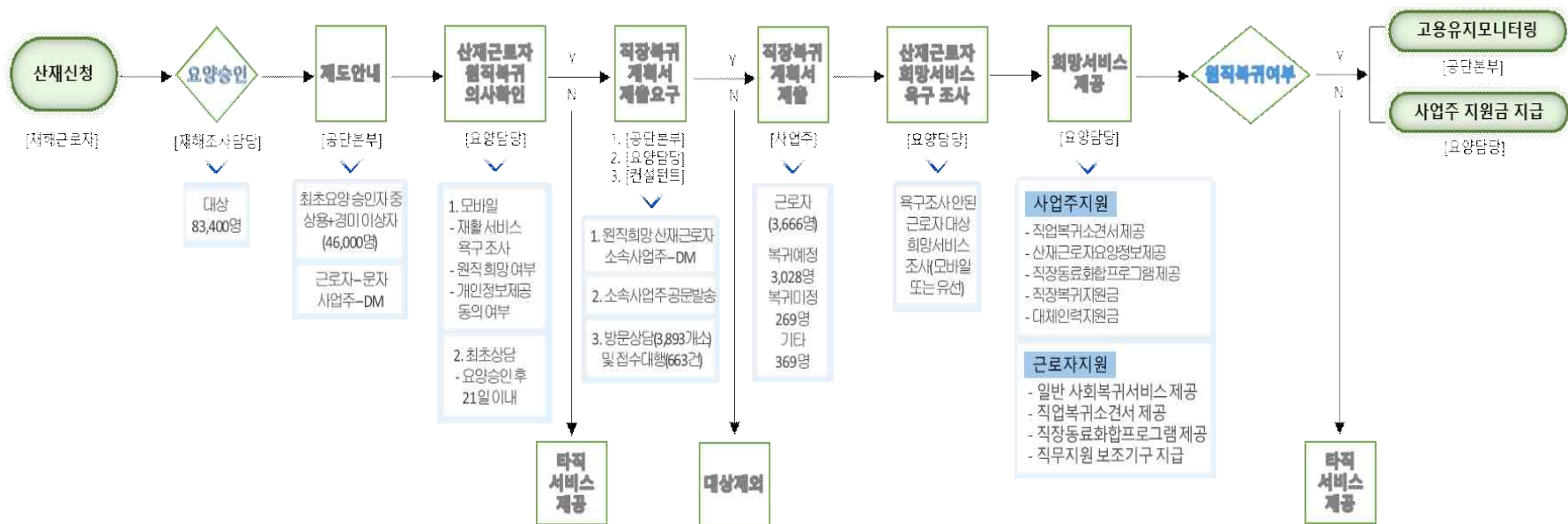
- 직장복귀지원금 및 대체인력지급이 지급된 경우 해당업무 자격확인 등 고용유지 모니터링과 연계하여 동시 진행
- 그 외 사업주 대상 1:1 컨설팅을 통한 고용유지 지원 등 사후관리 강화

(9) 업무처리 관할

- 제출된 직장복귀계획서 접수처리는 특진 의뢰업무 고려, 산재노동자의 요양중 의료기관 관할 소속 재활업무(직장복귀계획서) 담당자 처리. 사업주 직장복귀계획서 제출 편의를 위해 사업장 관할 소속기관도 예외적 접수 및 처리가능
- 내일찾기서비스 대상자의 직장복귀계획서 제출 및 관리는 요양중 의료기관 관할 중심으로 업무처리 일원화, 내일찾기 대상에 대한 사례관리 집중

3) 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영절차도

- 사업주 직장복귀계획서 제출은 원직복귀를 향상시키기 위하여 공단본부와 소속지사 요양담당의 안내와 지원으로 이루어지고 있음. 계획서 제출을 활성화하기 위하여 사업주와 근로자에 대한 지원제도를 함께 안내하고 있음



[그림 3-1] 직장복귀계획서 제출제도 운영절차도(2023년 7월 말 기준)

2. 직장복귀지원 의료기관 지정과 특진

(1) 운영목적 및 방향

- (운영목적) 직장복귀지원을 집중할 수 있는 전문 의료기관 운영을 통해 직업복귀 및 직무능력 회복을 위한 질 높은 재활 프로그램 제공
 - － 요양초기부터 재활개입, 재활효과를 높여 업무능력 회복 → 직장복귀 도모
- (운영방향) 산재보험 의료기관까지 직업재활 프로그램 보급·운영 확대
 - － 산재보험 지정 의료기관 중 전문 인력·시설을 갖추고 특화된 직업재활 프로그램 운영이 가능한 전문 의료기관 양성 확대

(2) 의료기관 기능

- (역할) 직장복귀를 희망하는 산재노동자의 신체기능 및 직무능력 회복을 위한 직업재활 프로그램 실시
- (기본기능) 작업능력평가 실시 및 직업복귀소견서 제공
 - － 직장복귀를 위하여 ‘직업복귀소견서’ 제출이 필요한 요양중인 산재노동자 대상 작업능력평가 실시 및 관련 소견서 작성·제공
 - － 작업능력평가는 산재노동자 상병을 고려, 특진 전문의 판단에 따라 선택 진행
- (전문기능) 작업능력강화 훈련 제공
 - － 직무분석 후 작업능력강화훈련 필요시 특진 주치의 소견 및 소속기관의 전원 절차 승인 후 작업능력강화 훈련 진행
 - － 직무분석 결과, 원직무 수행이 어려워 작업능력강화 훈련 필요시 진행
 - － 작업능력강화 훈련은 산재노동자의 요양기간이 3개월 이상 남은 경우 진행
 - － 작업능력강화훈련 이후 직업복귀소견서 작성

(3) 직장복귀지원 의료기관 지정기준

- (대상) 재활치료 및 작업능력평가에 필요한 인력·시설·장비를 갖추고 직장복귀지원 의료기관 지정을 희망하는 산재보험 의료기관

- ① 산재보험 의료기관으로 지정되었을 것
 - ② 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직환의 또는 재활의가 2인이상 재직
 - ③ 물리·운동·작업치료실을 갖추고 재활치료 및 작업능력평가 장비를 구비할 것

- (전문성 판단) 작업능력평가 및 작업능력강화 훈련이 가능한 인력, 시설·장비 구비 여부 판단 기준 마련
 - － (전문인력) 직장복귀지원 의료기관의 기본 및 전문기능의 정상 수행을 위해 재활의학과 및 직업환경의학과 전문의 모두 필요 → 전문의 고른 배치 권장을 위해 기준점수에 우대점수로 차등

- (시설) 재활치료실 필수 구비 (물리·운동·작업치료실)
- (장비) 작업능력평가 관련 필수 장비로 평가실 및 작업능력평가 장비, 신체기능 평가 장비 구비 필요, 기본 및 전문재활장비 장비 목록 제시
- (의료기관 지정업무)공단본부에서 지정업무 직접 수행
 - 직장복귀지원 의료기관 지정기준 정착 후 소속기관으로 지정업무 위임

(4) 전문의 대상 교육 제공

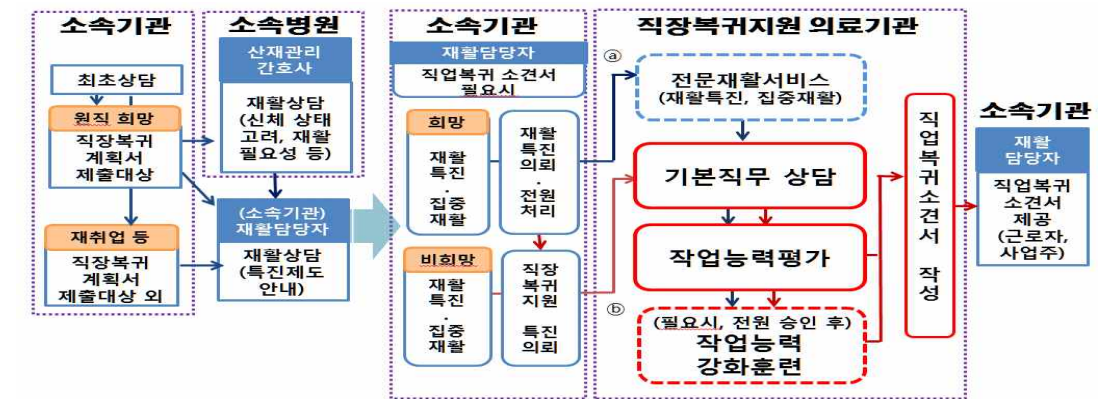
- (교육대상) 직장복귀지원 의료기관 지정신청을 준비하는 의료기관 소속 재활의학과·직업환경의학과 전문의 대상
- (교육내용) 직장복귀지원 의료기관 전문의 교육
 - 직장복귀지원 의료기관 역할, 직업복귀소견서 작성 등을 영상강의로 제작
 - 산재관리의사 자격이수 교육 중 일부 공통 강좌 포함

(5) 특진절차 및 적용수가

① 특별진찰 절차

- (목적) 산재환자의 조기 재활진입 유도, 작업능력평가 적기 진행
 - 산재승인 후 아급성기 도과(수술후 4주) 환자 대상 조기 재활 진행
 - 전문재활치료 및 직업재활 프로그램의 연계 → 빠른 직무능력 회복

직장복귀지원 의료기관 특진업무 절차



※ 재활특진 및 집중재활치료 진행자로 직업복귀소견서가 필요한 경우: 파란색 실선

※ 재활특진 등 비진행자로 직장복귀 소견서가 필요한 경우: 붉은선 실선

[그림 3-2] 특별진찰 업무절차

○ 재활특진 및 직장복귀 지원 특진

- (재활특진) 산재관리간호사는 직장복귀계획서상 직업복귀소견서 제공이 필요한 산재 노동자에게 재활상담을 통한 재활특진 안내
 - 신체상태에 따른 조기 재활의 필요성 및 재활치료 정보 제공

- 재활특진 및 집중재활치료 등 재활치료 안내
- 전원 희망시 직업복귀소견서 대상자는 소견서 발급까지 연계
- (직장복귀지원특진) 직업복귀소견서 제공이 필요한 경우
 - (일반) 기본직무분석, 작업능력평가 후 직업복귀소견서 발급
 - (전원) 작업능력강화 훈련 필요시, 훈련진행 후 평가 및 직업복귀소견서 발급
- 특진의 판단, 상병상태 고려 '원직복귀 어려움' 예상되어 작업능력강화 훈련 필요시(산재노동자 전원 동의)

② 의료기관 적용수가

- (요양급여의 범위) 직장복귀지원 의료기관 지정 후 공단의 직장복귀지원 조치 의뢰로 발생하는 행위에 대해 별도 수가 적용(시행규칙 개정(안) 제10조 제3항)
 - 직무분석, 작업능력평가, 작업능력강화 훈련 및 직업복귀소견서 발급에 관한 직장복귀지원 의료기관 적용 수가 신설
- 「직장복귀지원 특별진찰」의 경우 진료구분은 '통원' 처리
 - (기준) 직장복귀지원 특별진찰 시 실시 행위에 대해 정액지급
 - (수가정비) 소속병원 외 직장복귀지원 의료기관 확대 고려, 적용수가 및 횟수 하향 등 표준 기준 정비 및 검토 필요

추진 체계	세부절차	시기	주요 수행인력	대상 및 세부실행내용 등	수가		비고
					서식	비용	
초기 상담	재활상담 (유선)	내원전	산재관리 간호사	-(산재환자) 기본정보/상병 및 재활상태 등에 관한 재활 코디네이팅(코칭)	○	○	신규 (소속병원)
직무 파악	기본직무 분석	특진 내원 시 또는 요양 중	재활의학의(물리·작업치료사) 또는 직업환경의 (산업위생사)	-(대상) 직무 수행시 기능적 약화가 예상되는 자 -(세부) 재해경위, 재해자 직무기술, 작업환경, 직무관련 신체요구도, 종합분석 -(필요시) 근로자상담 및 서면조사, 사업장 방문조사	○	○	직장복귀지원 의료기관
직업 재활 프로그램	작업능력 평가	특진 내원 시 또는 요양 중	재활의학의(작업치료사) 또는 직업환경의	-직장복귀 여부 판단이 필요한 경우	○	○	
	작업능력 강화 훈련	요양 중	재활의학의(물리·작업치료사)	-(필요시) 신체기능회복, 모의작업 훈련, 사업장 훈련지도	○	○	
의학 소견	직업복귀 소견서	특진내원 시 또는 요양 중	재활의학의 또는 직업환경의	-산재환자 원직장복귀(원직무, 직무전환) 가능여부 등에 대한 의학 적 소견	○	○	

(6) 직장복지지원 요양급여범위 및 비용 산정기준

1. 일반원칙

1. 업무상 재해를 입은 산재근로자의 직업재활과 직장복지 지원을 위하여 다음의 인력 및 시설을 모두 갖춘 의료기관에서 실시할 수 있다.

가. 근로복지공단이 인정하는 산재보험 직장복지지원 교육을 이수한 직업환경의학과 전문의 또는 재활의학과 전문의 2인 이상이 상근하여야 한다.

나. 근로복지공단이 인정하는 직장복지지원 운영 전문가 기본교육을 이수한 물리치료사, 작업치료사, 산업위생관리산업기사(또는 인간공학기사)가 각각 1인 이상 해당 의료기관에 상근하여야 한다.

다. 위 “나” 호에 따른 기본교육을 이수한 물리치료사 또는 작업치료사가 1인 이상이 작업능력 강화 훈련을 담당하여야 한다.

라. 직업능력 평가, 신체기능 향상 및 모의 작업훈련을 실시할 수 있는 평가실·치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있어야 한다.

2. 직장복지 지원 세부 항목에 대해서는 의료기관 종별가산율을 적용하지 아니한다.

코드	한글명칭 및 기준	금액 (원)
	제1절 기본진료료	
VR0101	[산정지침] 주: 직장복지 지원을 목적으로 직업환경의학과(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)의 처방에 따라 물리치료사, 작업치료사, 산업위생관리 산업기사(또는 인간공학기사)가 실시한 경우에 산정한다.	44,550
VR0102	[기본 직무분석] 복귀가 필요한 산재 근로자에 대하여 직무 수행 시 제한이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제1호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정한다. [재활보조기구 교육·상담료] 1. 국민건강보험공단에 장애인 보조기기 제작업소로 등록되어 있고, 재활의학과 전문의 2인 이상과 의지보조기 기사가 상근하는 의료기관에서 재활의학과 전문의 처방에 따라 의지보조기 기사가 환자별 신체상태에 맞는 보조기구의 선택, 올바른 사용법 및 작동원리 등에 대한 교육·상담을 30분 이상 실시하고 일정한 서식(별지 제4호 서식)에 따라 그 결과를 작성·비치한 경우에 산정한다. 2. 요양기간 중 회 이내 실시를 원칙으로 하되, 보조기구의 변형, 피부 손상 등으로 추가적인 교육·상담이 필요하다는 재활의학과 전문의 소견이 있을 경우에는 10회까지 인정할 수 있다.	45,180
VR0103	[작업환경 평가] 1. 장애상태를 고려한 작업환경 개선 또는 직무전환 지도를 위한 현장평가가 필요한 경우 직업환경의학과 전문의 처방에 따라 인간공학기사, 산업위생관리산업기사가 사업장을 방문하여 작업환경에 대한 평가를 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제5호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정한다. 2. 요양기간 중 최대 2회까지 인정한다. 3. 2개 이상의 직무별 평가를 실시한 경우에는 소정금액의 100분의 50을 가산하여 산정하되 최대 200% 이내로 산정한다. 4. 의사가 사업장을 직접 방문하여 작업환경 평가를 실시한 경우 소정금액의 100분의 100을 가산하여 산정하고 서로 다른 직종 2인 이상이 사업장을 방문한 경우에는 2인 부터는 소정금액의 100분의 50을 가산하여 산정한다.	150,370
VR0104	[작업환경 개선 현장 지도료] 1. 직업환경의학과 전문의 처방에 따라 인간공학기사, 산업위생관리산업기사가 사업장을 방문하여 작업환경에 대한 개선·지도를 실시하고 일정한 서식(별지 제6호 서식)에 그 결과를 작성·비치한 경우에 산정한다. 2. 1회 실시를 원칙으로 하되 개선사항 점검 등으로 추가 방문지도가 필요하다는 직업환경의학과 의사의 소견이 있을 경우 1회를 추가로 인정한다. 3. 서로 다른 직종 2인 이상이 사업장을 방문한 경우 2인 부터는 소정금액의 100분의 50을 가산하여 산정한다. 4. 의사가 사업장을 직접 방문하여 작업환경 개선을 위한 현장지도를 실시한 경우 소정금액의 100분의 100을 가산하여 산정하고 서로 다른 직종 2인 이상이 사업장을 방문한 경우 2인 부터는 소정금액의 100분의 50을 가산하여 산정한다.	59,330

코드	한글명칭 및 기준	금액 (원)
	[사업장 방문료(1일당)] 1. 산재근로자의 작업환경에 대한 현장평가나 개선 지도 등을 위해 인간공학 기사 또는 산업위생관리산업기사가 사업장을 직접 방문한 경우에 산정한다. 2. 서로 다른 직종 2인 이상이 사업장을 방문한 경우 2인 부터는 소정금액의 100분의 50을 가산하여 산정한다. 3. 의료기관과 사업장의 거리는 순로에 따라 실제 이동한 거리로 산정한다.	
VR0105	가. 50km 이내	57,330
VR0106	나. 50km 초과 1Km 당	740
VR0107	[집중 상담] 1. 기초 심리검사 결과, 외상 후 스트레스 진단 척도 21점 이상, 백 우울 평가 14점 이상, 백 불안 척도 8점 이상 중 하나에 해당하거나 심리적 안정 및 정신기능·관계 회복을 위한 집중 상담이 필요하다는 의사의 소견이 있는 경우 정신건강의학과 전문의 또는 재활의학과 전문의 처방에 따라 임상심리사, 정신보건임상심리사, 사회복지사가 별도의 공간에서 30분 이상의 상담을 실시하고 결과를 일정한 서식(별지 제8호 서식)에 작성한 경우에 산정한다. 2. 주 2회 이내로 최대 8주간 인정하되 개인정신치료(아-1)와는 같은 날 동시 산정할 수 없다. 제2절 검사료	45,180
VR0201	[직업능력 평가] 1. 직장복귀 여부 판단 또는 직무수행을 위한 직업능력 평가가 필요한 산재근로자에 대하여 재활의학과 전문의(전공의) 또는 직업환경의학과 전문의(전공의) 처방에 따라 해당 의료기관에 상근하는 작업치료사가 실시한 경우 산정한다. 2. 직무수행 능력(모의작업 동작, 작업 자세 및 작업장 이동) 등에 대한 평가가 가능한 장비를 이용하여 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제2호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정한다. 3. 직업능력 강화 훈련 참여자는 전·후 평가를 실시할 수 있다.	460,000
VR0202	[기초 심리검사] 1. 직장복귀 대상자 중 심리적 안정 및 정신기능 회복 지원이 필요한 산재환자에 대해 의사의 처방에 따라 심리검사를 실시하고 결과지(별지 제7호 서식)를 작성·비치한 경우에 산정한다. 2. 심리상태 평가를 위한 1회 검사를 원칙으로 하되 심리 변화 등에 대한 경과 관찰이 필요하다는 의사의 소견이 있는 경우 1회 추가 인정 3. 동일 목적의 다차원심리검사와는 동시 산정할 수 없다. 제3절 이학요법료	38,970
	[작업능력 강화 훈련] 1. 재활의학과전문의(전공의) 처방에 따라 해당 분야 전담치료사(신체기능 향상 훈련은 물리치료사, 모의작업 훈련은 작업치료사)가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에 산정한다. 2. 작업능력 향상의 효과가 기대되는 산재근로자에게 30분 단위로 1일 2시간 이내로 산정하되 의학적 소견에 따라 최대 4시간 이내까지 산정 할 수 있으며, 모의작업훈련을 50% 이상 구성하여 치료기간은 12주 이내로 적용한다. 3. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제7장 제1절 기본물리치료와 같은 날 실시하더라도 실시자 및 치료방법이 다르므로 각각 산정한다.	
VR0301	가. 신체기능 향상 훈련(30분당)	29,280
VR0302	나. 모의작업 훈련(30분당)	29,280
	제4절 확인수수료	
VR0401	[직업복귀소견서] 1. 직무분석 및 직업능력 평가 결과를 반영하여 직업복귀 소견을 일정한 서식(별지 제3호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정하되, 그 결과를 공단에 제출하여야 한다. 2. 서로 다른 전문과목 전문의가 협의진료를 통해 소견서를 작성한 경우에는 전문과목별로 수수료를 각각 산정할 수 있다. 3. 직업능력 강화 훈련에 참여한 경우 직업복귀소견서 작성은 최대 2회까지 산정할 수 있다.	100,000

□ 근로복지공단의 전문적인 의학적 지원을 위해 전문성 있는 인력, 시설, 장비 등을 갖춘 산재보험 의료기관을 “직장복귀지원 의료기관”으로 지정해 운영하며, 전문성을 고려해 현재 공단 직영병원 등 10개소에서 민간병원으로 점차 확대 계획

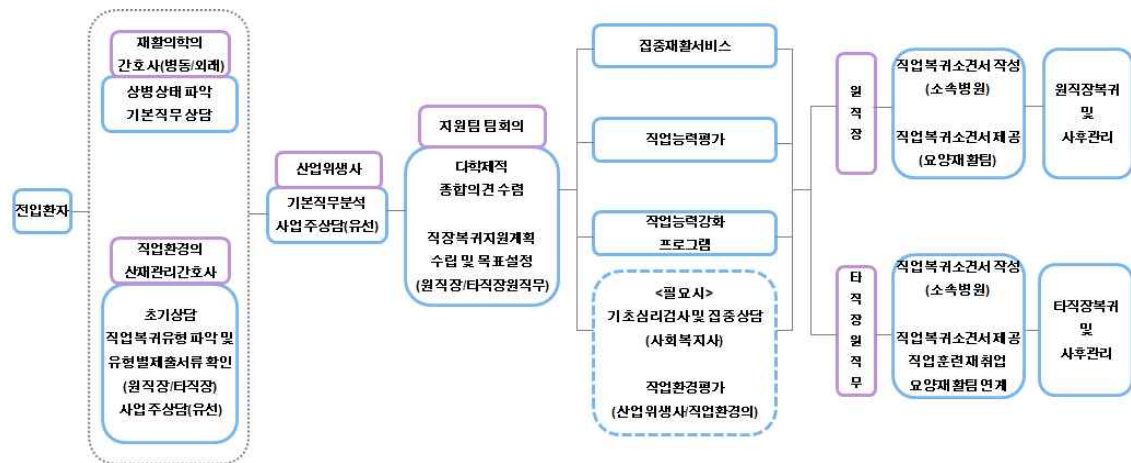
○ 직장복귀지원 의료기관은 산재보험 의료기관 중 고용노동부령으로 정하는 재활 관련 인력 및 시설 등을 갖춘 의료기관으로 산재노동자의 직장복귀에 필요한 기본 직무분석,

직업능력평가, 작업능력강화 훈련, 직업복귀소견서 작성을 지원

- 직장복귀지원 의료기관 요양급여 산정기준 신설을 통한 적용수가 마련(기본직무분석, 작업능력강화훈련, 직업능력평가, 직업복귀소견서)

(7) 소속병원 직장복귀프로세스(종합)

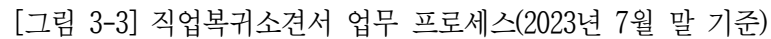
- 직장복귀지원 의료기관의 직장복귀지원 프로세스는 재활의학과, 직업환경의학과가 관여하여 진행되며 구체적인 과정은 다음과 같음



구분	주요 내용
1. 대상자 선정절차	① 상병상태 및 직업력 파악 (재활의학의) 상병상태 및 신체적 손상 정도 파악 등 (병동, 외래 간호사) 기본직무 상담 -> 추가상담 필요시 산재관리간호사 연계 ② 초기상담 및 대상자 선정 * 직장복귀 지원 필요대상자일 경우 진료 후 즉시(당일) 직업환경의학과 진료접수 (직업환경의/산재관리간호사) 초기상담, 추가 직무정보 파악 후 대상자 선정 (사업주 상담) 산재관리간호사--유선 등으로 사업주에게 원직복귀 가능여부 및 장애요인 등 파악 업주와 갈등관계, 지원금 안내 등 필요한 경우 요양재활팀에 연계 산업위생사--보험가입자측의 의견 청취 및 재해자와 면담내용을 토대로 원직장-원직무, 원직장- 타직무 등 부서전환 및 요양종결 후 업무조정 등에 대한 회사 측 의견청취 및 전달. (대상자 선정) 원직장/타직장 복귀 선정
2. 직장복귀 지원계획 수립 (전입 1개월 이내)	① 직장복귀지원팀 회의 (다학제적 접근) 선정 대상자에 대한 재활의학의· 직업환경의 등이 참여 (산업위생사) 기본직무분석 실시 후 팀회의 시 정보 제공 ② 지원계획 수립 (직업환경의) 전입 후 1개월 이내 ‘직장복귀 지원계획’ 수립 및 작성 ③ 원직장↔타직장 복귀 목표 변경 (목표변경) 목표가 변경되는 경우 즉시 직장복귀지원 계획 변경 후 서비스 제공 ④ 사업주 정보제공 (원직복귀 대상 협조관계 유지) (주요내용) 산재노동자 상병상태 및 예상 치료기간, 지원 사항에 대한 정보 제공

	(산재관리간호사) 유선 등으로 사업주에게 정보제공 (지사 요양재활팀) - 원직장 - 사업주 직장복귀계획서 제출 요청 타직장 원직무 - 직업복귀소견서 발급 신청서 안내 및 제출				
3. 원직장 복귀 지원	① 전문재활서비스 : (재활의학의) ‘재활종합계획’ 수립 후 집중재활프로그램 제공, 맞춤형 스포츠 재활, 직무지원 보조기구제공 ② 직업능력 평가 및 강화 프로그램 (작업능력평가) 대상자 선정시 실시, 작업능력강화, 프로그램 중 중간평가 실시 가능 (작업능력 강화 프로그램) 재활의학의 및 직업환경의 협진을 통해 프로그램 운영				
	신체기능 향상 훈련(재활의학의)	+	모의 작업 훈련(재활의학의)	+	사업장 훈련지도(직업환경의)
	③ (재활의학의/직업환경의) 직업복귀소견서 작성 (산재관리간호사) 지사요양재활팀에게 직업복귀소견서 회신 ④ 사업주 등 집중 지원 (소속병원) 정밀 직무분석, 직무지원 보조기구, 갈등해소 및 직무전환을 위한 사업주 상담, 소속기관 및 타 기관 사업주 지원 안내 및 연계 (요양재활팀) 대체인력지원금, 직장복귀지원금, 직장적응훈련비, 직장동료화합프로그램 등 ⑤ 작업환경 평가(필요시) (직업환경의/산업위생사) 장애상태를 고려한 작업환경 개선 또는 직무전환 지도를 위한 현장평가가 필요한 경우 등 ⑥ 기초심리검사(필요시) : (사회복지사) 심리적 어려움이 있는 경우				
4. 타직장 원직무 복귀 지원	① 전문재활서비스 ② 직업능력 평가 및 강화 프로그램 ③ (재활의학의/직업환경의) 직업복귀소견서 작성 (산재관리간호사) 지사요양재활팀에게 직업복귀소견서 회신, 직업훈련 및 재취업지원 서비스 연계 안내 (직업환경의) 수행가능한 직업훈련 및 타직무 직종 범위에 대한 상담 ④ 타직장 타직무 (요양재활팀 연계) 산재관리간호사는 타직장복귀 위한 직업훈련 및 재취업 지원 희망자 연계				
5. 직장복귀 및 사후관리 (직장복귀 후 3개월까지)	① 원직장복귀 사후관리 (직업환경의) 최소 2회(1개월 및 3개월 시점) 이상 유선 및 방문 상담 등 모니터링 통해 고용유지 및 직무전환 필요성 등 확인 (업무적합성 평가) 타직무 전환을 필요로 하는 경우 사업장 방문				

☐ 직업복귀소견서 발급은 소속병원 영양담당, 산재관리간호사 상담과 지원, 재활의학과와 직업환경의학과(산업위생사)의 진단과 관련 활동을 거쳐서 이루어짐. 최종 소속병원 영양담당이 직업복귀소견서를 사업주와 근로자에게 제공함



3. 사업주 직장복귀계획서 제출 지원

□ 사업주 지원제도

- 산재보험에서는 사업주가 제출한 직장복귀계획이 원활히 이행될 수 있도록 작업 능력과 직장복귀 가능성을 의학적으로 보여주는 직업복귀소견서를 사업주에게 제공하고, 대체 인력지원금, 직장복귀지원금 등 직장복귀에 필요한 각종 지원금을 제공함. 또한, 직무의 원활한 수행을 위해 작업능력 향상이 필요하다고 판단되면 산재노동자의 직무에 맞는 신체기능 향상 훈련, 모의작업 훈련 등 작업능력강화 훈련도 지원함

- (대체인력지원금) 산재노동자가 요양으로 취업하지 못한 기간에 대체 인력을 신규로 채용한 사업주에게 월 60만원 범위 내 최대 6개월까지 지원하는 제도
- (직장복귀지원금 등) 사업주가 산재노동자(장해 12급 이상자/예정자)를 복귀시켜 6개월 이상 고용을 유지한 경우
 - (직장복귀지원금) 월 45~80만원(최대 12개월)까지 지원
 - (직장적응훈련비) 직장적응훈련(직접 또는 위탁훈련)을 실시하는 경우 월 최대 45만원(3개월) 범위 내에서 그 비용을 지원
 - (재활운동비) 신체 능력회복 위한 재활운동비를 월 15만원(3개월) 지원

□ 사업주 컨설턴트 지원 및 맞춤형 지원

- 사업주의 소속 산재노동자에 대한 직장복귀계획서 작성 및 이행을 지원

지원항목	지원내용
직장복귀계획서 작성지원	• 사업주 상담 → 직장복귀계획서 안내 및 작성지원
산재노동자 요양정보 제공	• 소속 산재노동자의 산재요양 승인기간, 직업복귀소견서 등
이행지원 컨설팅	• 직장복귀지원 컨설팅 제공
사업주 지원제도 안내 및 연계	• 대체인력지원금, 직장복귀지원금, 직장적응훈련비, 재활운동비 지원 등

- 제출된 직장복귀계획서에 따라 사업주 대상 맞춤지원(제출 장애요인에 따른 지원)

장애요인	사업주 지원(예시)
직무수행 어려움	정밀 직무분석, 직장적응훈련, 직무지원 보조기구 등
환경개선 필요	작업환경 개선비용지원(안전보건공단 연계) 등
갈등관계 지속	재활상담지원, 직장동료화합프로그램 등
원직복귀권고 미행 시	지역본부 중심으로 전문가 자문회의 등을 활용 복귀 권고

해외사례분석¹⁾

제2절

- 외국의 산재근로자 원직복귀제도는 원직복귀의무제도와 원직복귀지원을 통해 이루어지고 있는데, 대표적으로 독일, 호주, 캐나다, 프랑스 같은 경우 원직복귀의무제도를 시행하고 있고, 미국은 주별로 원직복귀의무제도와 지원제도를 발달시켜 운영하고 있음

- 독일 산재노동자의 직장복귀 지원사업

- 독일은 사회법전 제 9권(장애인재활법) 제84조 제2항에 의거 모든 사업주는 6주 이상 업무능력을 상실한 피고용자에게 사업장 내 업무복귀 관리서비스를 제공할 의무를 가지도록 하고 있음

- 동법 제33조 직업재활급여와 사회법전 제7권(산재보험법) 제35조 직업재활급여를 통해 산재근로자와 사업주에게 직업복귀에 필요한 지원서비스를 제공함. 이는 업무능력을 상실하고 평생 사회급여에 의존해야 하는 사례를 방지하는 구조를 마련하는 것을 목표로 하는 것으로 산재근로자의 수용과 사업주 지지를 기반으로 함

- 독일 산재보험의 재해자 원직복귀율 사례

-
- 업무상사고 후 원직복귀(Return-to-work after Work-related Accidents)

1. 의료재활 개입없이 원직복귀 90% 이상 가능(More than 90% could return to work without medical rehabilitation intervention)
2. 의료재활이 필요했고 그리고 의료재활급여를 수급한 사람의 90% 이상이 (늘어난) 직업재활 없이 원직복귀 가능(재활관리)(More than 90% of the persons who needed and received medical rehabilitation benefits could return to work without (extended) vocational rehabilitation(RM!))
3. 늘어난/특별 직업재활을 받은 사람의 거의 90%가 직업생활에 복귀 가능 (재활관리)(nearly 90% of the persons who received extended/special vocational rehabilitation could be reintegrated in the working life (RM))

⇒ 1.과 2.을 합하여 의료재활 없이 또는 의료재활 후 원직복귀율 90% 이상

⇒ 1.과 2.와 3.을 합하여 의료재활 없이 또는 의료재활 후 그리고 직업재활 후 직업복귀율 98%

자료: DGUV(2018), Guidelines in Case Management of Work Accidents and Occupational Diseases/ Rehabilitation Management in the German Social Accident Insurance, p. 40.

(필자가 독일 산재보험 독일 북동부 지역본부 방문시(2018.06.26.) Mr. Jan Dierchen 의 독일 산재보험 재활관리 설명자료 p. 40 의 내용임)

1) 윤조덕 · 이현주 · 이상진(2021), 사업주 직장복귀계획서 제추제도 운영방안 연구, (사)한국사회정책연구원 · 고용노동부의 내용의 일부를 보완하여 작성함

- 독일 산재노동자 직장복귀계획에 대한 사업주의 의무 관련하여 사업주는 2004년부터 사회법전 제9권(SGB IX, 장애인의 재활과 참여) 제167조(예방) 제2항에 의하여 취업자가 질병으로 이전 1년 동안에 계속하여 또는 단속적으로 6주(42일)를 초과하여 노동불능(병가)이면 그의 취업자에 대하여 사업장 직장복귀관리(BEM)를 하여야 함
 - 이 사업주의 사업장 직장복귀관리 의무는 민간부문 및 공공부문 사업주, 대기업과 중소기업 모두에 적용되며
 - 사업주는 지난 12개월간 질병으로 인해 6주(42일)를 초과하여 노동불능(병가) 상태인 노동자(산재노동자 포함)에 대해 직장복귀관리 팀을 구성·운영하여 필요한 절차를 실행해야 할 의무가 있으며, 이를 위반한 경우 노동법원(Arbeitsgericht)에 당사자, 사업장정업원평의회(Betriebsrat) 또는 사업장 내 이해관계 대변인(Interessenvertretung)으로부터 제소될 수 있음

- 사업주가 직장복귀관리 가능성에 대한 선언(사회법전 제9권 제167조 제2항 제1문)에 대한 이해관계대변인의 참여와 관련하여 활동하지 않는 경우(태만한 경우, 직무유기를 하는 경우), 이해관계대변인은 사업주의 선언 의무와 예방조치 의무뿐만 아니라 이해관계 대변인의 정보권과 토론권에 대해 노동법원에 소송을 제기할 수 있고(노동법원법 제2a 조 제1항 제1호, 제3a호) 사업주가 당해/특정 노동자에게 사업장복귀관리(BEM)를 제공 하도록 의무 지워지도록 요청할 수 있음
 - 노동법원법 제85조(강제집행) 제2항에 따라 임시 금지명령 과정에서 토론권을 확보할 수 있음. 즉, 노동법원(Arbeitsgericht)에 제소하여 재해자 당사자의 해고 보호를 위한 법적 절차를 진행할 수 있음

- 독일 노동법원의 판결 사례들에 따른 사업장 직장복귀관리(BEM)를 위한 최소기준으로 준수해야 할 사항들은 다음과 같음
 - 사업주는 노동자가 실행에 대한 동의를 선언하기 전에 해당 노동자에게 이러한 목적을 위해 수집 및 사용되는 데이터의 유형 및 범위뿐만 아니라 직장복귀관리(BEM)의 목적을 알릴²⁾
 - 조치계획의 초점은 작업장 조정 및 변경, 다른 직업 찾기 및 이동을 통한 계속 고용에 있음³⁾
 - 기술지원의 투입, 작업도구의 조정, 작업장 재설계 및 근무시간 조정과 같은 낮은

2) BAG - 10.12.2009 - 2 AZR 198/09, NZA 2010, 398; BAG 24.03.2011 - 2 AZR 170/10.

3) BAG - 10.12.2009 - 2 AZR 400/08, NZA 2010, 398; BAG - 12.07.2007 - 2 AZR 716/06, NZA 2008, 173.

임계값의 사전 조치는 고용관계를 안정화하는 데 유용한 조치임⁴⁾

- 직장복귀관리(BEM) 참가자는 프로세스에서 합리적인 조정 및 변경 가능성이 제외되지 않도록 함
 - 직장복귀관리(BEM)의 모든 참가자는 문제해결을 위한 제안을 함. 또한, 모든 제안은 객관적으로 논의되어야 함
 - 법적 외부기관, 관청 및 개인이 적절한 조치를 명확히 하는 데 참여해야 함
 - 사업주는 질병으로 인한 해고를 통보하기 전에 (직장복귀관리(BEM)가)권장하는 재할 조치를 고려하고 시행을 안내해야 함⁵⁾
 - 프로세스에서 합의되고 노동자에게 유익한 설계 솔루션이 더 길고 예측가능하게 신뢰할 수 있는 기간 동안 실행되어야 함⁶⁾

○ 사회법전 제9권 제167조 제2항은 건강상의 이유로 업무에 기인한 장애가 발생할 경우 추가 예방조치를 포함함

- 건강 또는 건강의 결핍은 대부분 모든 사람의 사적 영역 또는 사생활 영역의 일부임. 따라서 사업장 직장복귀관리(BEM)은 당사자의 동의와 참여를 전제로함. 또한 정보보호법시행령(DSG-VO) 제7조의 의미 내에서 필요한 정보교환에 대한 동의를 포함함. 당사자의 명시적 동의 없이는 어떠한 기관도 정보를 제공하거나 관련될 수 없음
- 사업장 직장복귀관리(BEM) 도입에 따른 해당 기업 및 재해자에 대한 장려금(Prämien)은 사회법전 제7권(SGB VII, 산재보험) 제162조 제2항에 근거하여 지금까지 개별 산재보험조합들에 의해 회원 기업에 도입됨. 예를 들면, 채석업 산재보험조합의 경우 ‘부상으로부터의 직장복귀관리제도 도입 및 실시’ 시 다음과 같은 일정한 조건을 충족시키면 1) 제도 도입 시 기본 지원금(2,000유로), 2) 복귀한 노동자별 지원금(500유로), 3) 조치별 지원금 상한액(30,000유로)이 제공됨
 - ① 산재보험조합이 실시하는 세미나 참여(동 제도에 대한 상세한 내용 소개)
 - ② 동 제도 도입에 대하여 사업장과 노동자간의 합의서 제출
 - ③ 동 제도 실시를 위한 추가 조건 충족 증명서
 - ④ 경우에 따라 장기환자 복귀 증명서
- 독일 사회법전 제7권(SGB VII, 산재보험) 제162조 제2항 제2문은 사업장 직장복귀관리(BEM) 도입에 따른 해당 기업 및 재해자에 대한 장려금(Prämien) 지원을 규정하고 있음

4) BVerwG - 05.06.2014 - 2 C 22/13; BAG - 20.11.2014 - 2 AZR 755/13.

5) BAG - 10.12.2009 - 2 AZR 400/08.

6) LAG Hamm

- 사업장 직장복귀계획서 작성절차 및 관련 서식(매뉴얼)은 산재보험조합에서 마련하여 사업주에게 자문 및 안내를 함
 - － 예를 들면, 보건복지업산재보험조합(BGW)의 ‘사업장 직장복귀 실무지침서’ (본문 제 3장 2. 마. 참조)
- 독일 산재보험의 재활관리 진행지침에 따른 사례선정 기준은 크게 두 가지로 분류됨
 - － 첫째, 지표 ‘노동불능 상태의 기간’에 따른 사례 선정. 즉, 노동불능기간의 예측이 지난 12개월 동안 6주(42일) 또는 그 이상이 된다면, 이것은 직업복귀 및 사회복귀가 위태롭게 된다는 지표임
 - － 둘째, 그 외 지표들에 의한 사례선정. 예를 들면, ① 의학적 위험요인, ② 심리적 위험요인, ③ 사회적 위험요인, ④ 직업적 위험요인 임

□ 일본 산재노동자의 직장복귀지원사업

- 부상이나 질병에 의한 휴업 후 직장복귀 및 해고 관련 노동관계법
 - － 일본의 노동기준법 및 산재보험법에는 업무상 재해로 인한 휴업 후 노동자의 원직장 복귀에 대한 사업주의 의무규정이 없음
 - － 노동자가 업무상 재해 여부와 관계없이 부상이나 질병으로 휴직 후 복직할 수 있는지 여부 판단의 주체는 사업주임
 - － 업무상 재해로 인한 후유증으로 노동능력이 부족에 따른 해고는 허용되지 않으며 노동자의 복직 시 배치전환이나 취업조건 정비 등 사업주 노력에 의한 해고 회피 노력이 요구됨
 - － 사업주는 진단서, 직장복귀가능진단서 등 주치의와 산업의 등의 의견을 들어 복직가능 여부를 객관적으로 판정해야 함
- 치료와 취업의 양립 지원
 - － 질병을 가지고 있으면서 일할 의욕이나 능력이 있는 노동자가 일을 이유로 치료기간을 놓치지 않고 직업생활을 계속 유지할 수 있도록 치료와 취업 양립지원 사업 시범 실시중임
 - － 업무상 재해 여부와 관계없이 노동자들에게 주로 나타나는 암, 당뇨, 뇌졸중, 정신건강 4개의 다빈도 상병을 중심으로 통원 중인 노동자를 조기에 직장에 복귀하여 질병 치료와 직장생활을 병행할 수 있도록 지원함
 - － 직업복귀를 위한 기본적인 전제는 노동자가 취업으로 인해 질병이 악화되거나 재발이나 산업재해가 발생하지 않도록 사업장의 적절한 조치가 선행되어야 함

- 노동자의 자발적인 신청을 전제로 직업복귀프로그램이 이루어지며, 사업주가 노동자 본인의 동의 없이 노동자의 건강상태와 치료상황 등 질병관련 정보를 취득할 수 없음
- 치료와 일을 병행할 수 있도록 사업장 관계자, 의료기관 관계자, 지역 관련 기관 등 팀 접근을 통하여 프로그램 실시

○ 양립지원 코디네이터 양성

- 코디네이터는 직장복귀 단계에 따라 산업의, 산업간호사, 보건사, 보건컨설턴트, 사회 보험노무사 등의 전문가가 복직 노동자에게 요구되는 지원의 방향성을 정립함
- 코디네이터는 질병으로 인한 휴직자의 불안과 고민 해소, 신속하고 무리 없게 복직을 목표로 지원함
- 노동자건강안전기구 소속 산재병원 및 산업보건종합지원센터에서 양립지원 코디네이터 양성교육을 실시 중임

○ 직장복귀 지원 절차

- 직장복귀 지원을 위한 최초단계는 질병휴직부터 치료과정 동안 치료에 전념하도록 노동자를 지원하는 것으로 시작하며 회복을 보이는 노동자에 대한 관계자의 합동면담 및 정보공유가 이루어짐
- 2단계는 주치의에 의한 직장복귀 가능성을 판단하고 3단계는 직장복귀 여부를 판단하여 직장복귀가 가능한 노동자에 대하여 직장복귀 지원계획을 수립함
- 4단계인 최종 직장복귀가 결정되면 5단계인 직장복귀 후 추후관리를 통해 성공적인 직장복귀가 이루어지도록 함

○ 중증장애인 직업재활 지원

- 중증장애인이 직장에 고용되기 위해서는 의료재활이 선행되어 하며 일본은 노동자건강안전기구 소속의 의료재활센터에서 의료재활을 실시함
- 의료재활은 고령장애구직고용지원기구 소속의 직업재활선테와 연계하여 직업재활을 실시함
- 중증장애인의 고용 및 직업재활은 신체장애자복지법에서 규정한 장애유형 중 장애등급 1급, 2급, 3급 장애를 2개 이상 중복된 자를 대상으로 함
- 중증장애인 고용촉진을 위해 공공직업안정소, 장애자직업센터, 장애자직업능력개발교, 위탁훈련기관을 활용하여 직업재활 및 직업훈련이 이루어짐

□ 미국 산재노동자 직장복귀지원사업

- 미국의 경우 주별로 원직복귀의무제도와 원직복귀지원제도를 복합적으로 운영하고 있음. 워싱턴주는 원직장복귀의무를 강조하고 있는데, 핵심직무(essential task) 수행기능을 잃은 경우에만 해고가 가능하도록 하고 있음
 - － 핵심직무 수행여부는 주치의의 소견에 의해 결정이 되는데, 사업주는 의사에게 직무 분석 결과를 제공해야하며, 의사는 이를 기초로 신체적 제한점을 기술함
 - － 직업복귀시 산재근로자는 시간손실급여와 의료혜택을 지속적으로 받으면서 복귀가능하고, 사업주는 3년간 산재보험료와 건강보험료가 면제되며, 작업환경개조 및 직무수정시 드는 비용지원, 기타 금전적 인센티브가 제공됨
 - － 캘리포니아주는 원직복귀지원제도에 가깝게 운영하고 있는데, 사업주가 요양종결 후 60일 이내 직무를 제공하지 않으면 이후 산재장애인에게 지급되는 장애급여는 15% 인상지급하며, 산재장애인의 경우 사업주가 60일 이내 직무를 제공했음에도 직장에 복귀하지 않는 경우 장애급여 15%를 삭감지급함
 - － 복귀시 사업주는 주정부로부터 작업환경개조 비용지원을 지원받을 수 있으며, 직업유지수당으로 산재당시 임금의 2/3를 최대 52주간 지원받음

- 미국 New York State Workers' Compensation Board Return to Work Program Handbook에는 업무상 재해가 발생하면, 지정된 직업복귀 프로그램 담당자, 지정된 노동자 대표 혹은 노조 대표, 산재노동자, 산재노동자의 수퍼바이저를 포함하는 직업복귀위원회를 원직장복귀 코디네이터(재활 사례관리자)가 구성하고 산재노동자의 직무에서 요구하는 신체적 요구도를 평가한 직무분석지를 치료를 담당하고 있는 의사에게 제공하여 산재노동자가 현재 직무 혹은 전이 직무를 수행할 능력이 있는지에 대한 치료 담당 의사 소견 리뷰에 기초해 산재노동자의 직무에 대한 조정을 하거나 필요하다면 전이직무를 제안하고 개별직업복귀계획서를 작성하도록 하고 있음
 - － 또한 개별직업복귀계획서에는 산재노동자가 원직무로 복귀할 수 있도록 개별직업복귀계획의 목적과 시간표가 계획서에 제시되어야 하며, 영구장애의 경우 직무조정 내용도 포함되어야 하며
 - － 사후관리가 종료되는 시점에 재활서비스(직장복귀프로그램)가 직업복귀와 직업유지에 도움이 되었는지 사업주와 산재노동자를 대상으로 만족도 조사와 직업복귀 프로그램에 대한 평가를 실시
 - － 평가 내용은 재해일로부터 직업복귀일까지 걸린 시간, 개별직업복귀계획, 직무조정 비용, 산재보상 비용, 의료재활 비용, 휴업기간, 원직복귀 후 유지율, 직업복귀 프로그램에 대한 산재노동자 만족도 등에 대한 자세하고 양적인 데이터를 얻을 수 있도록 고안 되어야 함

- 산재노동자 원직복귀를 위한 지원방안으로 선호 근로자 프로그램을 두어
 - 고용주가 산재노동자에게 임시직이나 가벼운 업무를 제공하고 24개월 연속 고용할 경우 최대 66일까지 노동자의 기본급여의 절반(최대 \$10,000)을 고용주에게 보상해주거나,
 - 가벼운 일이나 전환기 작업을 하는데 필요한 훈련(등록금, 교재, 교구)에 소요되는 비용의 경우 최대 \$1,000, 도구나 장비(특별한 도구, 키보드, 높이조절 책상, 바퀴달린 5갤론 버킷)의 경우 최대 \$2,500, 피복(금속덮개 작업 안전화, 작업복)의 경우 최대 \$400까지 경비를 지원하고 있음
- 워싱턴 주 ‘소득력 상실 급여’ 제도는 산재노동자가 의사가 제안한 수정업무로 복귀하고 재해 당시 급여보다 5%이상 적은 급여를 받을 경우 소득력 상실급여를 제공
 - 소득력 상실급여는 재해 당시 급여와 현재 급여의 차이의 80%를 지급하도록 하고 있음
- 캘리포니아주의 직업복귀 인센티브제도(Return to Work Incentives) 는 직업복귀 컨설턴트(Return to Work Consultant)가 원직복귀를 지원하며, 50인 미만 사업장의 고용주가 현재 사업장이나 도구 등을 개조하지 않으면 수정직무나 전환직무 제공이 어려운 경우 일시장애(temporary disability)는 \$1,250, 영구장애(permanent disability)는 \$2,500까지 사업장 개선 지원자금을 제공함. 이 비용에는 장애상태에 적합한 도구 수정이나 도구 구입, 작업대 개조, 작업대 위치 변경, 직무과업 수정, 작업시간 변경 등 포함
 - 또한 인체공학적 서비스도 제공해서 가장 좋은 환경에서 일할 수 있도록 지원
 - 50인 이상 사업주는 노동자 원직복귀시 영구장애 연금을 15% 줄여서 줄 수 있도록 하여 보험요율 감면 혜택을 받게 되며
 - 이외에도 장애편의 공제제도, 장벽제거 세금공제제도, 노동기회 공제제도, 직업기회 및 복지에서 직업으로의 세금감면 제도 등 사업주의 장애인 근로자 채용을 촉진할 수 있는 다양한 지원제도를 두고 있음

□ 호주

- 호주는 사업장재해관리 및 산재보험법(Workplace Injury Management and Workers Compensation Act) 제52조에 의거 사업주는 사업신고 이후 12개월 이내 산재근로자에 대한 직업복귀 프로그램을 문서로 작성하여 보관하여야 하고, 위반 시 범칙금을 사업주에게 부과하도록 하고 있음
- 호주는 직업복귀법(Return to Work Act)를 제정하여 산재노동자가 4주 이상 직업에 복귀할 수 없는 것으로 예측되면 사업주는 회복/직업복귀 계획을 준비하고

- 사업주와 산재노동자에 대한 컨설팅
- 사업주가 채용한 직업복귀 코디네이터/계획에 따른 서비스 제공자로부터 지원
- 산재노동자의 의학적 상태에 대한 내용을 담도록 하고 있음

□ 캐나다

- 캐나다 온타리오주는 사업장 안전과 보험에 관한 법률(Workplace Safety and Insurance Act)에 의해 산재근로자의 원직복귀를 제도화하고 있는데 이 제도는 사업주와 재해근로자에게 주어진 기본적인 의무임
- 제41조(재고용에 대한 의무)에는 직업복귀를 위한 구체화된 노력으로 사업주가 재해 발생 전 1년간 계속하여 근로자를 고용한 경우라면 동 조항에 의하여 근로자를 재고용하도록 하고 있고, 의학적으로 근로자가 재해발생 이전 업무를 수행할 수 있다고 하는 경우에는 사업주는 재해발생 이전 직책으로 근로자를 재고용하거나, 재해발생 이전 직무에 상응하는 임금과 내용을 가지는 직무를 제공하도록 하고 있음
- 또한 근로자가 재해발생 전 직무를 수행할 수 없지만 의학적으로 충분한 업무를 수행할 수 있는 경우에는 우선적으로 업무수행의 기회를 제공해야 함. 산재근로자를 재고용한 후 6개월 이내에 해고하는 경우에는 이 법에 의한 재고용의 의무를 행하지 않은 것으로 보고, 위반사항이 발생한 경우 사업주는 벌과금을 내야하고, 산재근로자는 최대 1년 동안 휴업급여를 지급할 수 있도록 하고 있음

□ 프랑스

- 프랑스는 1981년 개정 노동법에 의해 기업은 산업재해를 입은 근로자들을 법에서 제한하는 경우를 제외하고는 해고를 할 수 없게 하고 있음. 노동법에 의하면
- ① 노동중단 기간 동안 그리고 고용계약의 일시적 중지 상태를 활용한 피재근로자의 재교육 기간 동안에는 시간의 제약도 없고 어떠한 권리의 상실도 없이 피재근로자의 고용은 보호되어야 함
- ② 피재근로자가 기존 직무를 수행하기에 적절하다고 판정될 경우, 고용계약의 중지 상태를 마치고 기존의 직장내 직무에 복귀할 수 있는 권리를 피재근로자에게 보장해야 함
- ③ 피재근로자가 기존 직무를 수행하기에 적절하지 않다고 판정이 될 경우, 그에게 기존 직무를 수행하거나 직장 내에서 재배치되어 고용상태를 유지할 수 있는 권리를 보장해야 함
- 사업주는 피재근로자의 직업복귀에 대한 산재담당의사의 권고를 받아들여야 하고, 만

약 거부한다면 그 사유를 산재담당의사에게 밝혀야 할 의무가 있음. 그리고 피재근로자와 고용주 간 합의가 이루어지지 않을 경우 산재담당의사의 소견을 참조하여 근로감독관이 최종결정함

□ 해외사례 합의

○ 산재근로자의 원직복귀의무화를 전제로 법과 제도를 운영하고 있음

- 독일은 사회법전 제9권(장애인의 재활과 참여) 제167조 제2항에 의거하여 취업자가 질병으로 이전 12개월 동안 계속하여 또는 단속적으로 6주(42일)를 초과하여 노동불능(병가)이면 그의 취업자에 대하여 사업장 직장복귀관리를 하여야 함
 - 원직복귀율은 의료재활 없이 또는 의료재활 후 원직복귀율 90% 이상 가능함. 이는 신속하고 전문적인 요양 및 재활치료, 재해자 가족, 병원 및 사업주를 연결하는 재활관리자의 폭 넓고 밀도 높은 서비스, 의무화 규정 및 이해당사자들(사업주, 재해자, 산재보험 등)의 상호협력임. 한편, 중증장애인 해고보호(장애인종합서비스관청 사전 허락) 규정 위반 시 노동법원에 소송이 제기됨
- 덴마크는 노동자가 유병결근 시작 4주 이내 직장복귀에 대해 논의하고, 8주후에는 재활을 시작하도록 하고 있으며. 노르웨이와 스웨덴은 노동자가 유병결근 시작 4주 후 직장복귀계획을 세우도록 하고 있음. 네덜란드도 8주 이내 직장복귀계획을 세우도록 하고 있음.

○ 원직복귀를 위한 지원 또는 비협조시 페널티를 주는 국가들이 있음

- 미국은 지원정책으로 임금보조, 비용환급, 세금공제 등이 있으며 페널티로는 재해노동자가 정당한 사유없이 재활프로그램 비협조 시 보험급여 중단, 중지, 감액 등 재활프로그램을 종료할 수 있음
- 캐나다도 재해노동자가 원직장 복귀를 거부하거나 실패할 경우 모든 급여감액, 중지, 종료, 사업주가 원직장 복귀를 거부하거나 실패할 경우 보험급여 총액에 거부기간 동안 발생한 비용을 사업주에게 부담시킴

○ 근로자의 원직복귀를 위한 사업주와 근로자, 공공주체의 지속적인 관리 노력이 있음

- 캐나다 온타리오주는 사업장 안전과 보험에 관한 법률 제40조에 의거하여 사업주 의무, 근로자 의무, 정부의 의무를 규정함으로써 산재근로자 직업복귀를 위한 사업주, 근로자, 정부의 협력을 강조하고 있음
- 일본은 직장복귀지원을 위하여 치료와 일을 병행할 수 있는 양립지원 코디네이터를 운영하고 있으며, 호주는 산재근로자에 대한 직업복귀 프로그램을 문서로 작성하여

보관하도록 하고 있음. 독일은 취업자가 노동불능으로 복귀가 어려운 경우에도 직장 복귀관리(BEM)을 통하여 지속적인 작업장 변경이나 이동을 통한 계속 고용을 위해 노력하도록 하고 있음

○ 원직복귀를 위한 직무기능 수행은 주치의 소견에 의해 결정함

- 외국의 산재근로자 원직복귀의무제도 및 지원제도에서 중요한 역할을 하는 것은 해당 산재근로자가 재할 이후 직무핵심기능을 수행할 수 있는가의 여부인데, 이 판단은 주치의 소견에 의해 결정이 된다는 것임
- 이 주치의 소견에 의해 사업주는 산재근로자의 작업능력을 판단하게 되고, 산재근로자 역시 본인의 작업능력을 객관적으로 판단할 수 있게 되는 정보의 대칭성이 이루어질 수 있게 되는 것임. 주치의가 산재근로자의 제한점들을 명확하게 진단하고, 그 제한점들이 직무 본질에 최소한의 영향을 준다고 진단이 되어진다면, 이 주치의 진단소견은 산재근로자가 직업에 복귀하는데 매우 중요한 지원을 할 수 있게 됨(Harder & Scott, 2005)(이승욱·김선규, 2014).

○ 따라서, 우리나라 사업주 직장복귀계획서 제출제도를 활성화하기 위해서는 ① 직장복귀 계획서 제출의무화 등 제도의 실효성 강화하고 미 이행시 사업주와 근로자에 대한 조치 ② 사업주와 근로자에 대한 지원의 종류와 충분성에 대한 검토와 개선 ③ 직장복귀를 위한 사업주와 근로자의 지속적인 노력이 필요함

제 4 장

사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영실태와 성과분석



직장복귀계획서 제출현황

제1절

- 2022년 1월부터 9월까지 직장복귀계획서 제출 목표를 달성하였으나 실제 제출율은 8.2%수준으로 크게 높지 않았음
- 2022년 목표 3,214건 대비 3,381건 제출로 105.2% 달성. 그러나, 2022년 직장복귀계획서 제출대상 41,314건 중 3,381건 제출하여 실제 제출율은 8.2%수준에 그침

< 표 4-1 > 사업주 직장복귀계획서 제출현황

목표(건)	제출(건)	직장복귀계획(건, %)		
		복귀예정	복귀미정	기타
3,214	3,381	2,955 (87.4)	230 (6.8)	196 (5.8)

- 연령별로는 4-50대, 성별로는 남성, 업종별로는 제조업, 규모별로는 5인 이상 30인 미만, 300인 이상, 장애등급별로는 13급-14급, 무장해인 경우에 계획서 제출율이 높았음
 - 연령별로는 50대 33.3%, 40대 22.1% 순이며, 남성이 74.5%, 여성이 25.5%로 나타남.
 - 업종별로는 제조업 58.2%, 기타의 사업 34.8%의 순이었음
 - 규모별로는 5인 이상 30인 미만 사업장이 35.2%, 300인 이상 사업장이 24.7%. 50인 미만 사업장이 전체 61%, 50인 이상 사업장은 39%로 나타남
 - 장애등급별 현황으로는 제출자 중 요양종결자는 1,735건(51.3%)이고, 이 중 장해판정자는 1,108건(32.8%), 무장해자는 627건(18.5%)이었음

< 표 4-2 > 사업주 직장복귀계획서 제출의 특성

구분(건, %)		제출건수	20대 이하	30대	40대	50대	60대	70대 이상
합계		3,381	204(6.1)	450(13.3)	748(22.1)	1,126(33.3)	737(21.8)	116(3.4)
성별	남성	2,518(74.5)	172(6.8)	407(16.2)	659(26.2)	738(29.3)	469(18.6)	73(2.9)
	여성	863(25.5)	32(3.7)	43(5.0)	89(10.3)	388(45.0)	268(31.0)	43(5.0)
업종별	광업	10(0.3)						
	제조업	1,969(58.2)	1(0.0)	67(2.0)	134(4.0)	14(0.4)	1,175(34.8)	11(0.3)
규모별	5인 미만		~30인 미만	~50인 미만	~100인 미만	~300인 미만		300인 이상
		550(16.3)	1,189(35.2)	323(9.5)	243(7.2)	241(7.1)		835(24.7)
장애등급별	요양종결자						요양중	
	소계	1~3급	4~9급	10~12급	13~14급	무장해		
	1,735(51.3)	0(0.0)	70(2.1)	399(11.8)	639(18.9)	627(18.5)	1,646(48.7)	

- 사업주 지원사업 대상 발굴에 있어서 대체인력지원을 희망하는 경우가 가장 많았으며, 대체로 산재노동자 복귀를 예정하고 있었음
- 직장복귀계획서 제출 건 중 대체인력을 채용 중이거나 채용 예정으로 기재한 건은 1,348건(39.9%), 대체인력지원금 상담 희망은 2,329건(68.9%)이었음
- 직장복귀계획서 제출 건 중 산재노동자 복귀예정으로 기재한 건은 2,955건(87.4%), 직장복귀지원금 상담 희망은 1,242건(36.7%)이었음

<표 4-3> 사업주 대체인력 채용 및 직장복귀예정 여부

구분(건, %)	제출건수	대체인력 채용 여부		
		채용 중	채용 예정	미정
합계	3,381	977(28.9)	371(11.0)	2,033(60.1)
상담지원 희망	2,329(68.9)	395(17.0)	184(7.9)	1750(75.1)
상담지원 비희망	1,052(31.1)	582(55.3)	187(17.8)	283(26.9)
구분(건, %)	제출건수	산재노동자 복귀예정 여부		
		복귀예정	복귀미정	기타
계	3,381	2,955(87.4)	230(6.8)	196(5.8)
상담지원 희망	1,242(36.7)	1,137(91.5)	68(5.5)	37(3.0)
상담지원 비희망	2,139(63.3)	1,818(85.0)	162(7.6)	159(7.4)

- 사업주 컨설팅 지원 현황을 살펴보면, 사업장 8,519개소에 방문하여 1:1컨설팅 제공, 직장복귀계획서 및 지원금 신청서 1,129건 작성을 지원함

<표 4-4> 사업주 컨설팅 지원현황

신청서류 작성 지원(건)			
소계	직장복귀계획서	대체인력지원금	직장복귀지원금
1,129	759	247	123

- 사업주의 직업복귀소견서 발급 희망에 따른 특별진찰 의뢰대상은 971건, 이중 799건 특진 의뢰됨. 한편 의료기관 지급 직장복귀지원 특별진찰 요양급여는 7,017,287천원으로 나타남. 특히, 요양급여의 대부분은 작업능력강화훈련에 압도적으로 많은 비용이 투입되고 있었음

<표 4-5> 특별진찰의뢰현황

합계	특진의뢰(건)											기타*
	소계	인천	안산	대구	대전	창원	동해	순천	광주	서울	부산	
971	799	135	75	78	106	107	39	100	73	33	53	172

* (기타) 특진 의뢰 전, 산재노동자 비희망 등

< 표 4-6 > 직장복귀지원 요양급여 현황

구분	항목	수가코드	건수(건)	요양급여(천원)
직장 복귀 지원 요양 급여	기본직무분석	91520(기준), VR0101(신규)	1,242	58,113
	직업능력평가	91169(기준), VR0201(신규)	1,764	811,490
	작업능력강화	91215, 91216(기준), VR0301, VR0302(신규)	201,277	5,999,008
	직업복귀소견서	91802(기준), VR0401(신규)	1,129	116,825
	기타	VR0102~0107, VR0202(신규)	5,270	31,850
합계			210,682	7,017,287

- 사업주와 근로자의 만족도는 높은 수준으로 나타났으며 사업주는 지원금 확대, 요양정보 제공 등을 필요로 하였고, 산재노동자는 재활상담 및 서비스 확대, 원직복귀 촉진수당, 환경개선 비용 등을 필요로 하였음
- 직장복귀계획서 만족도 조사결과 2022년 5월 1일 ~ 11월 30일 기간 동안 제출된 직장복귀계획서(2,562건) 대상 사업주 및 산재노동자 만족도 조사결과 사업주는 만족이 82.2%, 산재노동자는 만족이 77.4%로 나타남

< 표 4-7 > 직장복귀계획서 제출제도 만족도 조사결과

구분	사업주(185명 응답)(%)			산재노동자(468명 응답)(%)		
전반적 만족도	만족 82.2	보통 14.6	불만족 3.2	만족 77.4	보통 18.7	불만족 3.9
도움정도	도움 79.0	보통 18.4	도움 안 됨 2.6	도움 66.6	보통 23.1	도움 안 됨 10.3
개선요구	사업주 지원금(기간) 확대 신청서식 간편 개정 산재근로자 요양정보 제공 산재보험료 경감 작업환경개선 비용 지원			재활상담 및 재활서비스 지원 확대 직장복귀지원 의료기관 확대 원직장복귀 촉진 수당 신설 사업주 지원제도(지원금) 확대 작업환경개선 비용 지원		

- 사업주 직장복귀계획서 제출자와 미제출자의 특성을 비교한 결과 직장복귀계획서 제출자의 요양기간이 미제출자 보다 짧고 원직복귀율도 높았음
- 직장복귀계획서 제출자(1,325명)의 평균요양기간이 미제출자(31,110명) 보다 100일이 짧게 나타났으며, 원직복귀율도 44.2%p높게 나타남
- 직장복귀계획서 제출자 원직복귀율은 전체요양종결자 보다 31.5%p높았음. 사업장 규모별로는 300인 이상 사업장의 원직복귀율이 90.4%를 차지함
- 장애등급별로는 직장복귀계획서를 제출한 10~12급 원직복귀율이 77.9%, 무장애 원직복귀율이 77.5%로 제출하지 않은 경우 보다 40%이상 높은 것으로 나타남

< 표 4-8 > 직장복귀계획서 제출자와 미제출자 원직복귀율

구 분		계	5인 미만	5-30인 미만	30-50인 미만	50-100인 미만	100-300인 미만	300인 이상	
전체 요양 종결자	종결자	85,787	20,931	24,315	6,547	6,555	7,163	20,276	
	원직복귀자	39,336	6,777	11,106	3,100	3,089	3,854	11,410	
	원직복귀율	45.9	32.4	45.7	47.3	47.1	53.8	56.3	
대상군 전체	종결자	32,435	7,986	9,694	2,632	2,729	2,739	6,655	
	원직복귀자	11,350	1,802	3,561	1,032	1,016	1,142	2,797	
	원직복귀율	35.0	22.6	36.7	39.2	37.2	41.7	42.0	
	제출 자	종결자	1,325	218	485	134	94	92	302
		원직복귀자	1,025	149	353	106	71	73	273
		원직복귀율	77.4	68.3	72.8	79.1	75.5	79.3	90.4
	미제 출자	종결자	31,110	7,768	9,209	2,498	2,635	2,647	6,353
		원직복귀자	10,325	1,653	3,208	926	945	1,069	2,524
		원직복귀율	33.2	21.3	34.8	37.1	35.9	40.4	39.7
구 분(명, %)		계	1~3급	4~6급	7~9급	10~12급	13~14급	무장해	
전체 요양 종결자	종결자	85,787	95	286	1,323	6,859	13,075	64,149	
	원 직복귀자	39,336	15	88	372	2,153	4,768	31,940	
	원직복귀율	45.9	15.8	30.8	28.1	31.4	36.5	49.8	
대상군 전체	종결자	32,435	95	286	1,323	6,859	13,075	10,797	
	원 직복귀자	11,350	15	88	372	2,153	4,768	3,954	
	원 직복귀율	35.0	15.8	30.8	28.1	31.4	36.5	36.6	
	제출 자	종결자	1,325	0	2	32	181	310	800
		원 직복귀자	1,025	0	1	23	141	240	620
		원 직복귀율	77.4	0.0	50.0	71.9	77.9	77.4	77.5
	미제 출자	종결자	31,110	95	284	1,291	6,678	12,765	9,997
		원 직복귀자	10,325	15	87	349	2,012	4,528	3,334
		원 직복귀율	33.2	15.8	30.6	27.0	30.1	35.5	33.4

- 직장복귀계획서 제출자와 미제출자 평균 요양기간을 비교한 결과 직장복귀계획서 제출자의 평균 요양기간은 190.4일로 미제출자 평균 요양기간인 290.4일 보다 100일 짧았음

< 표 4-9 > 직장복귀계획서 제출자와 미제출자의 요양기간

전체 제출대상(명, 일)		직장복귀계획서 제출자(명, 일)		미제출자(명, 일)	
종결자수	평균요양기간	종결자수	평균요양기간	종결자수	평균요양기간
32,435	286.4	1,325	190.4	31,110	290.4

제2절 근로자와 사업주 만족도

1. 근로자 조사

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 대한 인지여부를 확인한 결과 인지하고 있는 비율이 71.8%로 나타나서 대체로 인지하고 있는 것으로 나타났지만, 28.2%는 인지하지 못하고 있어서 보다 적극적인 홍보와 안내가 필요함

<표 4-10> 제출제도에 대한 인지여부

구분	빈도	백분율(%)
아니오	72	28.2
예	183	71.8
전체	255	100.0

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 대한 전반적 만족수준은 만족하다는 의견이 65.5%로 높은 편으로 나타난 반면에 불만족은 5.5%로 낮아서 대체로 계획서 제출제도에 대해서 만족하고 있었음

<표 4-11> 전반적 만족도

구분	빈도	백분율(%)
매우 만족	79	31.0
만족	88	34.5
보통	74	29.0
불만족	8	3.1
매우 불만족	6	2.4
전체	255	100.0

- 사업주 직장복귀계획서 제출에 따른 직장복귀특진을 위한 지원이 필요한지에 대해서는 75.7%가 필요하다는 의견을 제시하여서 특진에 따른 추가적인 지원방안 검토가 필요한 것으로 판단됨. 실제로 사업주와는 달리 산재근로자에 대한 직장복귀계획서 제출제도 관련 유인제도가 없어서 이에 대한 보완이 필요한 상황임

< 표 4-12 > 근로자 직장복귀특진 지원 필요성

구분	빈도	백분율(%)
매우 필요함	89	34.9
필요함	104	40.8
보통	39	15.3
필요없음	21	8.2
전혀 필요없음	2	.8
전체	255	100.0

- 사업주 직장복귀계획서가 산재근로자의 직장복귀에 도움이 된다고 생각하는지에 대해서는 도움이 된다는 의견이 77.5%로 다수였고, 도움이 되지 않는다는 의견은 6.7%고 나타남. 대체로 직장복귀계획서 제출이 산재근로자의 원직장 복귀에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 평가됨

< 표 4-13 > 계획서 제출제도의 직장복귀 도움정도

구분	빈도	백분율(%)
매우 도움됨	107	42.0
도움됨	88	34.5
보통	43	16.9
도움이 되지 않음	14	5.5
매우 도움이 되지 않음	3	1.2
전체	255	100.0

- 원직장 또는 타직장 복귀 이후 지속 고용유지를 위한 지원 필요성에 대한 생각은 필요하다는 의견이 92.1%로 압도적으로 높은 반면에 필요없다는 의견은 2.8%에 불과하였음. 직장복귀계획서 제출에 따른 사업주 지원제도가 존재하지만 근로자의 지속적인 고용을 유지하기 위해서는 사업주와 근로자에 대한 추가적인 지원이 필요한 것으로 판단됨

< 표 4-14 > 직장복귀 이후 고용유지를 위한 지원 필요성

구분	빈도	백분율(%)
매우 필요함	134	52.5
필요함	101	39.6
보통	13	5.1
필요없음	5	2.0
전혀 필요없음	2	.8
전체	255	100.0

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 대해 알게 된 경로는 공단지사 안내가 71%로 가장 많았고 다음으로 우편과 온라인매체의 순이었음. 따라서 공단에서 수행하는 직접적인 안내가 가장 중요한 역할을 하는 것으로 본 제도의 인식제고를 위해서는 공단의 적극적인 역할 수행이 가장 중요할 것을 판단됨

< 표 4-15 > 계획서 제출제도 인지 경로

구분	빈도	백분율(%)
우편(DM)안내	18	11.8
공단지사 안내(유선, 홍보물)	181	71.0
온라인매체(유튜브, 블로그등)	22	8.6
옥외광고(전광판)	4	1.6
기타	18	7.1
전체	255	100.0

* 기타 : 검색, 소속병원, 문자안내, 서울의원, 지인, 재활운동 프로그램 참여중중, 직장복귀 후 회사, 직장산재담당자 안내 등

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에서 우선적으로 개선되어야 할 부분은 ‘요양중 원직장 복귀에 필요한 재활상담 및 재활서비스 지원확대’가 39.2%로 가장 높았고 ‘직장복귀지원 의료기관 확대’와 ‘사업주 지원제도 확대’가 유사한 수준으로 높았음
- 산재근로자들은 요양중 보다 집중적인 재활 상담과 서비스 제공을 필요로 하고 있는 것으로 보임

< 표 4-16 > 제도에 있어서 개선되어야 하는 부분

구분	빈도	백분율(%)
직장복귀지원 의료기관 확대(특진기관 확대)	51	20.0
사업주 지원제도(지원금) 확대	49	19.2
요양중 원직장 복귀에 필요한 재활상담 및 재활서비스 지원 확대	100	39.2
원직장 복귀 사업장 작업환경 개선비용 지원	16	6.3
원직장복귀 촉진수당 신설	36	14.1
기타	3	1.2
전체	255	100.0

* 기타 : 산재근로자 급여지원, 잔업 및 특근강요 불필요, 직장복귀계획서 모름

- 그 외에도 직장복귀계획서 제출제도의 활성화를 위하여 근로자 원직복귀와 관련하여 발생하는 사업주의 부정적인 인식과 초기 업무부담, 사업주의 복귀거부, 마음의 불안정 등 다양한 원직복귀 관련 문제의 적극적인 해결, 근로자에 대한 지속적인 치료지원, 직장복귀지원금 등 근로자 지원강화, 지원금과 지원기간 등 지원제도의 강화, 지원제도 이용의 간소

화 등 사업주 지원강화, 원직복귀 이후 부당대우에 대한 모니터링, 작업환경개선비 활용에 대한 모니터링, 원직복귀 후 적응상태 등 근로자 원직복귀 후 모니터링과 개선강화, 작업장 환경개선 등 모니터링과 개선강화, 지원금 조기 지급 등 근로자 원직복귀 후 모니터링과 개선강화, 근로복지공단의 직장복귀계획서 업무 역할강화와 정보제공, 산재근로자의 직장복귀를 위한 재활 등 복귀지원서비스 제공 강화, 직장복귀계획서 제출제도에 대한 인식개선과 홍보강화, 사업장에 대한 처벌조치 마련 등이 제안되었음

<표 4-17> 기타 제출제도에 관한 의견

항목	주요 내용
근로자 원직복귀 관련 다양한 어려움 해결 노력 강화	· 근로자가 원직장 복귀에 어려움이 있을 경우에 대한 구체적 대안 제시. 사업장이 영세하여 사업주가 사후 업무복귀에 부정적임. 산재로 직장복귀가 늦어짐에 따라 사업주 이해와 배려가 전적으로 필요. 근로자가 몸도 돌보면서 최선을 다해 업무에 지장이 없도록 함께 노력하고 배려하는 모습이 노사간 필요. 복귀 후에도 병원진료나 재활운동 지원. 복귀하면 차별이 없기를 기대. 원직장에서 관리자를 통해 직장복귀를 전화상으로 못하게 함. 산재발생으로 회사에 지장이 많아서 미안한 마음이 있음. 직장복귀전 근로자와 공단 담당자와의 만남으로 요양중인 근로자의 몸 상태를 최종 확인하고 필요시 연장이나 종결 과정 필요. 현재로선 몸과 마음이 복귀하고픈 생각이 없는 시점으로 개인의 판단으로 요양기간을 늘려서 안정된 마음을 추스려 사회에 복귀할 수 있도록 해야 함. 다시 일을 잘할 수 있을까 염려되고 다른 동료에게 민폐를 끼칠까봐 복귀하기가 두려움
산재근로자에 대한 재활, 치료, 재정 지원강화	· 산재근로자 불편함을 조금 더 개선. 재활과 치료에 대한 지원은 전혀 없음. 현재 재활과 물리치료 문제로 일찍 퇴근하여 급여의 절반 정도 받고 있어서 생활이 안 되고 있어서 재정지원 필요. 산재 대상자에게 세금혜택 필요. 산재근로자에게도 직장복귀지원금 필요. 사업주만 혜택을 주고 근로자는 혜택을 주지 않는지 불만족함. 재활중인 장해근로자들에게 차비 지원 필요. 치료기간 내 사회보험 지원 필요. 복귀 후 산재부위에 지속적 통증으로 인한 삶의 질 저하에 대한 지원 필요. 산재 원인이 된 문제부터 해결되도록 지원필요. 상해정도가 원직장 복귀에 문제가 생기면 맞는 직장을 선정해주면 좋겠음, 재취업을 적극 권장해서 근로 공백 최소화. 재활 상담 및 특진 필요
사업주 지원제도 확대 및 추가마련 등 강화	· 대체인력지원비 서류간소화, 대체인력지원비 확대, 원직장 복귀시 적응기간 동안 회사 지원금 확대. 지원제도 금액 증액, 복귀상태가 애매한 부분에 대해선 결과에 따라 몇 달만이라도 지원. 사업주 비용부담을 덜어주고 근로자 건강체크 및 관리지원 확대. 근로자 복귀하여 업무기간 동안 대체인력 지원. 환자상태를 정확히 인지할 수 있도록 정보전달과 적응 시까지 동료들도 이해필요. 회사에서 나가라고 한다는 근로자들을 조사해서 그 사업주에게 혜택을 주는 게 필요

산재 근로자 원직복귀 후 모니터링 강화를 통한 적응 관련 문제 개선	· 근무지 위험성과 노동강도 등 확인을 위한 현장방문. 원직복귀후 부당한 대우 받지 않도록 모니터링. 미복귀시 확인 후 조치. 복귀환경에 대한 개선여부 및 지원사항을 점검하고 실제 작업환경 개선. 같은 업무를 볼 수 없는 상태이나 같은 업무를 시켜 산재에 노출되는 문제예방. 임금차별이나 퇴사 방지. 본인 의사와 상관없는 지역 이동금지, 불이익 없이 정상적인 고용을 유지 지원. 작업환경개선비가 취지에 맞게 사용되었는지 확인. 근로자가 적응할 수 있도록 초반에는 강도 있는 업무를 많이 시키지 않고 시간을 두고 늘려갈 수 있도록 조정. 눈치 안 보고 일할 수 있도록 공단의 관심과 관리. 사업주의 계획서와 다른 일도 많이 하고 있어서 개선 필요. 10%지원금 시점을 앞당겨주는 것 필요
공단 업무 역할 강화와 정보제공 활성화	· 공단의 원활한 업무를 위한 인원 확충이나 제도개선. 공단에서 신경써주시니까 직장에서도 신경 씬. 남은 기간과 대기 순번을 문자로 안내 필요. 전화상담 필요. 계획서 제출 방법 안내 필요. 충분한 요양 후 이상이 없을 때 제도 안내. 복잡한 타 병원 전원 절차 개선 필요. 근로자 복귀 관련 정보공유 필요. 사업주 신청 시 산재근로자도 사실을 인지하도록 안내 필요, 직장복귀계획서 제출절차 관련 내용을 문자나 카톡으로 안내
재활, 의료, 상담 등 복귀지원 서비스 제공 강화	· 의료서비스 개선 부탁. 완전히 회복되고 현장에 투입될 수 있도록 관심. 24주 이상도 재활이 더 필요하면 지원필요. 치료에 전념할 수 있도록 지원 및 상담. 계획서 제출로 직장복귀재활을 못할 수 있는 것 같아서 개선 필요. 재활서비스 범위 확대. 재활프로그램 활용 인원 확대. 재활필라테스 관련 장비측정설비를 갖추어진 곳을 본인이 찾아야해서 2주 정도 소요되어서 개선필요. 화상 치료시 비급여 부분이 개선 필요. CT나 MRI같은 고액검사 비용 지원. 직장 복귀 후 재활서비스 지원. 직장복귀를 위한 의료서비스 지원 필요. 재활치료기관 확대 운영. 직장복귀시 최소 3개월 정도는 후유증 관리 등 배려. 근로복지공단 재활프로그램이 너무 좋고 직장복귀하는데 큰 도움
직장복귀 계획서 제출제도 인식개선과 홍보강화	· 사업주의 명확한 인식 이해로 직장복귀에 있어 불이익이 없도록 지원. 산재근로자가 치료에 더 집중할 수 있도록 사업주 의식 개선. 산재처리를 할때 초기에 제출제도를 함께 안내. 몰라서 원직장 복귀하려다가 욕만 엄청먹고 사직. 상담과 대체인력지원시 정보가 미흡해서 서신이나 문자로 제도 안내 필요. 산재요양시 부터 홍보 필요. 일부 사업주는 혜택에만 관심이 있고 근로자 회복이나 복귀 후 적응에 무관심. 서비스 사례를 카톡이나 메일로 안내 필요. 직장복귀 프로그램이 홍보가 되어서 도움을 많이 받았으면 좋겠음
사업장에 대한 처벌 조치	· 복귀 후 업무적으로 불리한 대우, 사내괴롭힘 발생시 사업체에 대한 제재 필요. 원직장 이직률이 최소화될 수 있도록 사업주에 대한 계도와 상벌을 엄격히 적용 필요

2. 사업장 조사

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 대한 전반적 만족도는 만족이 73.3%로 나타나서 대체로 만족하였으며 불만족 의견은 4.8%수준으로 낮았음. 응답한 사업주가 많지는 않지만 대체로 만족도가 높은 것으로 보이는데 이는 계획서 제출을 위한 지원절차와 지원제도에 대한 만족도가 높은 것으로 보임

<표 4-18> 사업장의 전반적 만족도

구분	빈도	백분율(%)
매우 만족	75	29.9
만족	109	43.4
보통	55	21.9
불만족	6	2.4
매우 불만족	6	2.4
전체	251	100.0

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도가 사업장에 도움이 된다고 생각하는지에 대해서는 도움이 된다는 의견이 69.3%로 높아서 대체로 도움이 된다는 의견을 나타내고 있었으며 8.4%는 도움이 되지 않는다는 의견을 제시함. 설문에 응답한 사업주들은 근로자의 직장복귀를 희망하는 경우가 많아서 계획서 제출이 이를 촉진할 수 있는 유인이 되고 있다고 판단하고 있는 것으로 보임

<표 4-19> 사업장에 도움이 된다고 생각하는 정도

구분	빈도	백분율(%)
매우 도움됨	58	23.1
도움됨	116	46.2
보통	56	22.3
도움이 되지 않음	18	7.2
매우 도움이 되지 않음	3	1.2
전체	251	100.0

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 대해 알게 된 경로는 공단지사 안내가 47.3%로 가장 높게 나타났으며 우편도 43.8%로 유사하게 높았음. 따라서 사업주 직장복귀계획서 제출제도를 안내하고 홍보하는 가장 효과적인 방법은 공단의 홍보와 안내 관련 노력으로 보임

< 표 4-20 > 제도를 알게 된 경로

구분	빈도	백분율(%)
공단 지사 안내(유선, 홍보물)	121	47.3
온라인매체(유튜브, 블로그 등)	9	3.5
우편(DM)안내	112	43.8
기타	14	5.5
전체	256	100.0

- ☐ 사업주에 대한 대체인력지원금과 직장복귀지원제도(직장복귀지원금, 직장적응훈련비, 재활운동비)가 직장복귀계획서를 제출하시는데 영향을 미치는지에 대해서는 58%가 영향을 미친다는 의견을 제시하였고 24.8%는 영향이 없다고 응답함. 사업주의 직장복귀계획서 제출율을 높이기 위해서는 지원제도에 대한 안내를 강화하고 지원수준을 높이는 것이 필요할 것으로 보임

< 표 4-21 > 지원제도가 계획서 제출에 미치는 영향

구분	빈도	백분율(%)
매우 영향있음	50	20.0
영향있음	95	38.0
보통	43	17.2
영향없음	50	20.0
전혀 영향없음	12	4.8
전체	250	100.0

- ☐ 직장복귀계획서 제출 사업장에 대한 지원의 충분정도에 대해서는 충분하다는 의견이 40.5%로 나타나서 높지 않은 반면에 보통이 48.2%로 높았으며, 불충분하다는 의견은 11.3%로 나타남. 따라서 지원제도의 충분성을 높게 평가하지는 않는 것으로 보임

< 표 4-22 > 사업장에 대한 지원의 충분성

구분	빈도	백분율(%)
매우 충분함	25	10.1
충분함	75	30.4
보통	119	48.2
불충분함	22	8.9
매우 불충분함	6	2.4
전체	247	100.0

- ☐ 근로자의 직장복귀 지원을 위한 사업장 작업환경 개선지원 필요성에 대해서는 필요하다는 의견이 40.1%로 나타난 반면 필요없다는 의견이 23%로 나타남. 산재근로자의 직장복귀후 원활한 근무를 위해서는 필요한 작업환경 개선이 필요할 것으로 판단됨

<표 4-23> 사업장 작업환경 개선지원 필요정도

구분	빈도	백분율(%)
매우 필요함	20	8.1
필요함	79	32.0
보통	93	37.7
필요없음	48	19.4
전혀 필요없음	9	3.6
전체	249	100.8

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도에서 우선적으로 개선되어야 할 부분에 대해서는 ‘사업주 지원금(기간)확대가 34.7%로 가장 높았고 산재근로자 요양정보 제공 18.2%, 산재보험료 경감 16.8%, 신청서식 간편 개정 15.8%의 순으로 나타남. 따라서 사업주 지원제도를 지속적으로 보완·확대하면서, 산재근로자가 직장에 복귀할 수 있는 수준인지에 대한 명확한 의학적 정보제공이 필요할 것으로 보임

<표 4-24> 우선적으로 개선되어야 할 부분

구분	빈도	백분율(%)
사업주 원직장복귀 컨설팅 확대(법률 등)	12	4.2
사업주 지원금(기간) 확대	99	34.7
산재근로자 요양 정보 제공(진료계획서 결과 알림)	52	18.2
산재보험료 경감	48	16.8
신청서식 간편 개정	45	15.8
원직장복귀 사업장 작업환경 개선비용 지원	21	7.4
기타	8	2.8
전체	285	100.0

- 사업장에서는 직장복귀계획서 제출제도 개선을 통한 활성화를 위하여 서류와 절차의 간소화, 산재환자의 요양정보 등에 대한 사업주 정보 제공 등 관련 제도의 개선, 기관부담 산재보험료 경감 등 사업장 지원, 작업장 환경 개선지원, 근로자 복귀를 위한 심리적 지원과 직장복귀 의지 고취, 불필요한 요양기간 연장방지 등 근로자 지원강화, 제출제도와 사업주 지원에 대한 지속적인 홍보와 안내 강화 등이 제안됨

<표 4-25> 기타 제도 개선을 위한 의견

항목	주요 내용
대체인력 지원금 관련 제도	· 대체인력 충원시 회사지원 필요. 받기 어려움. 대체인력으로 하지 않고 기존 인원으로 대체하거나 야근으로 빈자리를 채우는 건 지원금에 해당되지 않음. 1~2개월을 대체인력으로 대체하기 어려움. 대체할 인력이 없음. 대체

개선	인력 구인에 협조요망. 대체인력지원금 신청에 대한 홍보안내장 발송필요. 대체인력지원금에 대한 기준 완화. 빨리 우선 지급 필요. 지원금 규모나 기간 확대. 일용직 근로자도 대체될 수 있도록 지원
제출제도 대상 등에 대한 개선	인정 장애등급 기준 확대 필요. 소견서 발급을 하려고 하니 일정이 되지 않아 못함. 관련 병원이 많으면 좋겠음. 산재요율이 올라가는 것을 직장복귀 시 기본요율로 적용필요. 산재진행 상황이 사업주에게 공유가 되지 않아 답답. 상담원 교육 필요, 지역공단의 친절한 설명과 빠른 진행. 신청서 간편 및 컨설팅 지원, 작업환경 개선지원. 신청 절차 간소화. 본인이 하던 업무 소화 안되어서 단순업무 변경 후 복귀는 아닌듯함. 무작정 복귀하라고 등 떠미는 느낌이 불편함. 컨설턴트가 설명해 주신 게 많은 도움. 자세한 내용을 알지 못한 부분 아쉬움. 소규모 사업장 위주의 지원금 제도의 활성화. 최저임금 상승과 물가 인상으로 지원금 상향. 특수고용직 기사들은 스스로 직장복귀 잘하고 있어서 계획서가 크게 도움되지 않음. 상시근로자 50인 미만에 적용되는 혜택이 확대되어 300인 이상에도 적용 되었으면 함
사업장에 대한 지원 강화	원직복귀시 기관부담 산재보험료 경감. 요양기간에 따른 사업주 지원제도 (지원기간 차등)의 보완. 요양정보가 제공되어야 계획을 잡을 수 있는데 근로자 사정에 따라 요양내용도 바뀌는 등 계획을 현실에서 적용시키기가 어려움. 작업자 변심으로 사업주가 지원을 받지 못하는 경우가 발생. 직원을 복귀시까지 기다리는 지원금에 대해서 사전에 받을 수 있는 방안 도출
서류와 절차 간소화 등 제도개선과 공단의 관련 업무 충실	대체인력지원금은 받았으나 계획서 제출 문의 결과 하지 않아도 된다고 하여 미제출. 100%복직 기업들은 받아봐야 큰 의미가 없음. 각종 서식을 간편하게 해주고 임금은 즉시 해결하도록 지원. 복귀하여도 3개월 이상 지속적인 근무가 안됨. 본인들이 지속적으로 근무할 의사를 가지고 않고 있음. 사이트 상세와 필요서류를 자세히 설명해주면 좋겠음. 용어와 서류를 직관적으로 이해하기 쉽게 제작 필요. 업무상 재해 요양기간을 3개월 이상으로 확대 필요. 업종에 맞는 제도 개선 필요. 여성에 대한 복직기회 확대 필요. 장애 여부와 무관하게 지원금을 실행
근로자 지원 강화	기업은 직장복귀를 명령하고 싶으나 근로자 심리적 위축, 불이익 등 우려로 복귀가 쉽지 않음. 산재후 환경을 즉시 개선했으나 근로자 직장복귀 의지가 생기도록 심리상담, 홍보를 병행하고 작업환경 지원을 해주면 좋겠음. 대상자(산재 장애등급) 확대 필요. 사업장 복귀 후 현재 근무시간에 진료받으러 가고, 지원제도 없음. 직장복귀가 간단하지 않음. 즉, 본사/현장에 따라 작업환경 개선에 많은 노력이 필요하고, 사업주의 긍정적인 동의도 확인해봐야 할 문제로 충분한 지원이 필요. 산재근로자의 요양기간이 지나치게 반복 연장되는 문제 해결필요(비슷한 정도의 재해에도 개인차이가 많음). 요양연장

	조건강화로 근로의욕 저하 방지 필요. 요양기간 연장은 단순한 물리치료 연장으로 근로의욕 저하로 기업 및 근로자 모두에게 나쁜 영향
제도에 대한 홍보와 안내 강화	• 모르는 사업주가 많아서 홍보강화 필요. 문의시 공단대표 전화번호와 담당 부서 직통 전화번호를 함께 안내하면 업무에 도움. 계획서 제출하였으나 사업주 지원 전혀 홍보없음. 산재 관련 정보의 지속적인 안내자료 필요(개인 및 회사지원제도 홍보). 지원제도 유무를 모를 수 있으니 지속적인 안내

직장복귀계획서 제출제도 운영성과 분석

제3절

- 직장복귀계획서 제출제도의 운영성과를 구체적으로 확인하기 위하여 2022년 1월부터 12월 까지 1년간 직장복귀계획서 제출 산재근로자와 미제출 산재근로자의 직장복귀율과 요양기간의 차이를 비교분석함
 - 분석은 두 가지 방식으로 이루어짐. 우선, 직장복귀계획서 제출근로자와 미제출 근로자의 직장복귀율(원직장, 타직장, 전체)과 요양일수의 단순비교를 실시함. 다음으로 제출근로자와 미제출 근로자가 가진 특성을 고려한 성향점수 매칭분석을 실시하였음
- 성향점수매칭 미 상태에서 직장복귀율과 요양일수 비교
 - 직장복귀계획서 제출자의 68.4%가 원직장 혹은 타 직장으로 복귀하여서 미제출자 복귀율 48.5%에 비해 19.90%가 높은 것으로 나타남. 특히, 직장복귀계획서 제출자는 미제출자에 비해 원직복귀의 비율이 30.80%나 높았음. 다만, 타직복귀율은 미제출근로자가 제출근로자에 비해 높았음
 - 요양일수는 미 매칭 상태에서는 직장복귀계획서 제출자 205일, 미제출자 294일로 직장복귀계획서 제출자가 89일 적었음
 - 직장복귀율과 요양일수의 차이를 볼 때 직장복귀계획서 제출제도가 전체와 원직장복귀율 향상에 기여하고, 요양일수 감소에 기여하고 있는 것으로 평가됨

< 표 4-26 > 직장복귀계획서 제출에 따른 직장복귀율 차이 비교

구분			원직복귀		타직복귀		복귀전체		Total
			미복귀	복귀	미복귀	복귀	미복귀	복귀	
계획서 제출	미제출	빈도	28262	11228	31558	7932	20330	19160	39490
		비율(A)	71.60%	28.40%	79.90%	20.10%	51.5%	48.5%	100.0%
	제출	빈도	738	1070	1641	167	571	1237	1808
		비율(B)	40.80%	59.20%	90.80%	9.20%	31.6%	68.4%	100.0%
Total		빈도	29000	12298	33199	8099	20901	20397	41298
		비율	70.20%	29.80%	80.40%	19.60%	50.6%	49.4%	100.0%
차이(B-A)			-30.80%	30.80%	10.90%	-10.90%	-19.90%	19.90%	-

< 표 4-27 > 직장복귀계획서 제출에 따른 평균 요양일수 차이 비교

구분		평균 요양일수
직장복귀계획서	미제출	294
	제출	205
	차이	89

- 성향점수 매칭(Propensity Score Matching) 상태에서 직장복귀율과 요양일수 비교
- 성별(남·여), 연령대(청년·중년·장년·노년), 재해발생형태(질병·사고·출퇴근), 중등도지수(경미·경도·중등도·고도·극도·무장해)를 활용하여 직장복귀계획서 제출과 미제출 산재근로자 집단의 속성을 유사하게 매칭하는 성향점수 매칭(Propensity Score Matching)분석을 수행함
 - 직장복귀계획서 제출자의 68.4%가 원직장 혹은 타 직장으로 복귀하여서 미제출자 복귀율 51.4%에 비해 17.00%가 높은 것으로 나타남. 원직장복귀율도 직장복귀계획서 미제출자에 비해 제출한 경우가 28.30%가 높았음. 타직복귀는 미제출 근로자가 제출근로자에 비해서 높았음
 - 요양일수는 PSM을 실시한 결과 계획서 제출 근로자 205일, 미제출 근로자 272일로 제출자가 67일 적었음
 - 따라서 성향점수 매칭을 통하여 직장복귀계획서 제출근로자와 미제출 근로자의 직장복귀율과 요양기간을 비교한 결과 직장복귀계획서를 제출한 경우에 전체와 원직장복귀율이 높고 요양기간이 짧아서 제출제도가 전체와 원직장복귀에 기여하고, 요양기간 단축에도 긍정적인 영향이 있는 것으로 판단됨

< 표 4-28 > 직장복귀계획서 제출에 따른 복귀율 차이비교 성향점수 매칭분석(PSM)

구분			원직복귀		타직복귀		복귀전체		Total
			미복귀	복귀	미복귀	복귀	미복귀	복귀	
계획서 제출	미제출	빈도	1250	558	1409	399	879	929	1808
		비율(A)	69.10%	30.90%	77.90%	22.10%	48.6%	51.4%	100.0%
	제출	빈도	738	1070	1641	167	571	1237	1808
		비율(B)	40.80%	59.20%	90.80%	9.20%	31.6%	68.4%	100.0%
Total		빈도	1988	1628	3050	566	1450	2166	3616
		비율	55.00%	45.00%	84.30%	15.70%	40.1%	59.9%	100.0%
차이(B-A)			-28.30%	28.30%	12.90%	-12.90%	-17.00%	17.00%	-

< 표 4-29 > 직장복귀계획서 제출에 따른 평균 요양일수 차이 비교

구분		평균 요양일수
직장복귀계획서	미제출	274
	제출	205
	차이	67

□ 성향점수매칭 전후 비교

- 성향점수매칭을 통해 데이터를 보정할 경우 미제출자의 원직, 타직, 전체 직장복귀비율이 매칭하지 않은 원데이터에 비해 소폭 증가하나, 성향점수매칭을 하지 않은 경우와 유사한 수준을 보임
- 요양일수도 미매칭 상태에서 요양일수 격차가 다소 크기는 했지만 여전히 요양일수 격차가 상당히 존재하는 것으로 나타남
- 요컨대 성향점수 매칭을 하는 경우와 하지 않는 경우 모두 직장복귀계획서를 제출한 경우에 전체와 원직장 복귀율이 높고, 요양기간이 짧았음. 따라서 직장복귀계획서 제출제도 운영이 산재근로자의 요양기간을 단축시키고 전체와 원직장복귀율에 기여하고 있는 것으로 판단됨

참여자 의견조사(FGI)

제4절

1. 근로복지공단 담당직원 면접조사

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영절차의 문제와 개선방안

- 공단 담당직원들은 직장복귀계획서 제출대상은 대체로 확대가 바람직하다는 입장이 강하며, 일부는 현재 계획서 제출제도 운영에 대한 효과를 검증한 후 점진적으로 확대하는 것이 바람직하다는 의견을 제시함
- 직장복귀계획서 제출제도 업무 수행시 소속기관 재활보상부는 요양 및 보상민원으로 제출제도 관련 업무는 상대적으로 적절히 대처하지 못하고 있어서 개선이 필요하며, 소속병원을 계획서 제출대상 발굴 등에 적극 활용하는 것이 필요하다는 의견이 제시됨. 특히, 제출제도 활성화를 위해서는 사업주에 대한 충분한 상담과 안내가 필요하다는 의견을 제시함
- 부서 및 조직간에도 재활업무가 분산되어 있고 전산만 연계되는 등 실제적인 정보교류가 되지 않아서 효율적 업무진행에 어려움이 있는 것으로 나타남. 특히, 직장복귀업무가 원직은 소속기관, 타직은 지역본부(거점)으로 분산되어 있어서 효과적, 효율적이지 않아서 직장복귀 업무의 통합운영이 필요하며 소속병원과 기관의 계획서 제출과 특진업무 수행을 위한 효과적인 정보연계가 필요함
- 제출제도는 내일찾기와 연계하여 운영이 필요하며 잡화식으로 운영되고 있는 재활서비스를 통합적으로 계획서 제출제도와 연계하여 제공하는 것이 필요함
- 직장복귀지원 의료기관의 경우 주치의와 산재관리역사의 역할과 전문진료과목별 역할을 명확히 할 필요가 있으며 직장복귀지원 의료기관을 확대하여 산재근로자의 접근성을 향상시키기 위한 노력이 필요함

<표 4-30> 직장복귀계획서 제출과정과 서비스·조직 등 연계

구분	주요내용	
제출 대상의	상용직, 일용직 등으로 확대 바람직	· 작업능력강화(Work hardening)는 타직장 복귀도 지원 필요. 병원 의사판단으로 작업능력강화(Work hardening)가 필요시 확대 필요

적절정		- 지원에서 제외되고 있는 일용직까지도 작업능력강화(Work hardening)를 받을 수 있도록 확대 - 산재발생시 사업주들이 부정적인 생각이 많으므로, 상용직 전체로 확대 필요
	효과 검증 후 점진적 확대	- 효과 검증되면 확대 필요 - 제도 초기에 너무 많은 대상자로 확대하는 것은 다소 위험
제출절차 (과정) 문제점과 개선방안	재활보상부 민원과 대로 낮은 상담율	- 우편은 한계가 많고 회수율이 제한적임. 현재 재활보상부는 민원 처리로 상담을 못하게 되는 경우가 많이 발생해 상담율이 10%도 안되는 것이 현실임 - 공단이 이해관계자간 조정자, 중재자, 정보제공자(수시 의학적정보제공 등), 지원자 역할을 연속적·통합적으로 수행해야 하나, 산재보험이 현금보상 중심으로 운영되어 재활보상부 인력으로 오랜 시간이 소요되고 민원서류 처리를 우선 수행하여 주요업무에서 밀림. 약 23종에 달하는 재활서비스를 연계 지원하는데도 한계
	소속병원을 적극활 용 필요	- 소속병원 환자 발굴과 연계시 원직복귀계획서 제출이 증가예상(산재관리간호사 대상발굴→산재병원 발굴시스템 발굴라인 추가 필요. 로컬은 환자를 뺏길 수 있어서 적극적으로 하지 않겠지만 병행치료로 발굴시스템에 포함) - 병원발굴 대상 제출율은 80-90%. 본부 명단 계획서 제출율이 30-40%정도로 병원의 적극적인 발굴자 역할수행이 필요
	사업주에 충분한 정보제공 필요	의료기관이나 제3의 기관을 활용해서라도 재활상담을 100%하면서 제도 설명 필요. 제출제도 관련 다양한 정보 사업주 안내 필요
부서 (조직) 인력간 협력 적절성과 개선방안	재활 관련 업무분 산으로 소극적 업 무진행 우려	- 업무가 여러 기관에서 연관되어 효율성이 낮거나 지체됨. 재활업무 일부(직업훈련, 취업지원, 재활스포츠)를 재활지원팀에서 실시하고 있는데 재활지원센터로 확대해 재활업무를 권역별로 관리하면서 계획서를 통한 원직장 복귀 여부에 따라서 집중재활치료 및 작업강화훈련을 연계하고, 원직복귀가 어려운 경우 직업훈련과 재활스포츠를 통해 취업연계 필요 - 원직은 지사, 타직은 거점에서 하고 있음. 계획서는 의료기관 담당자가 하고 사례관리가 필요한 대상자는 잡코디가 하고 있음. 이렇게 되면 초기부터 소극적으로 이루어질 가능성이 높아져 잡코디를 중심으로 통합적으로 수행하는 것 필요
	전산만 재해자 안됨	- 전산연계만 할 뿐이고 계획서상 직업복귀소견서 발급이 비희망인 경우 의료기관에서 재해자 정보를 알 수 없어 집중재활치료나 작업강화프로그램을 권하는데 어려움→희망으로 바꾸기 위해서 소속 병원에 재해자나 사업장 정보 연계 필요 - 직업복귀소견서 희망 재해자 상황을 지사 직원에게 의존하고 있고, 의료기관에서 지사로 작업능력강화나 집중재활치료를 진행해도 되는지 묻는 경우가 많아 의료기관의 역할이 적절하게 이루어지지 않고 있다는 생각 → 소견서 희망 시 집중재활치료나 작업능력강화 프로그램을 바로 진행 필요하며, 재해자 정보(사업장의 연락처 등)를 확인할 수 있는 전산연계로 업무효율 개선 필요
제출제도와 기존사회	내일찾기와 계획서 제출제도의 연계운 영 필요	- 초기 프로세스는 지사 의료기관 담당자가 처리하고 적극 개입이 필요하면 잡코디가 하는 형태가 필요. 문제는 잡코디 업무과중임 - 내일찾기는 원직장복귀가 어려운 경우에 하기 때문에 계획서와 통

복지서비스 연계와 문제점		- 합되면 더 효율적일 것으로 생각됨(현재 내일찾기 프로세스 안에 계획서 제출이 있음) - 사업주 제공 지원은 안내필요. 제출제도가 앞으로 계속 늘어 날 것이라 내일찾기가 다 개입하는 것은 어려움
	재활서비스와 제출 제도 연계방안 필 요	재활서비스가 잡화식으로 되어있음. 제출제도를 이러한 사업들을 어떻게 연계시킬 것인지 고민필요. 여전히 하나의 서비스나 프로그램이라고 생각하고 있어서는 성공할 수 없음
직장복지 지원의료 기관의 역할적절 성과 개선방안	주치의와 산재관리 의사 역할이 중요	- 요양중 산재근로자의 원직무수행능력 향상을 지원하는 산재보험 의료기관 주치의사 및 산재관리의사 역할 중요 - 산재관리의사제도(직무수행능력평가 및 적응훈련지원)를 확대하고 실효성 있는 운영
	진료과목별 전문의 역할 정립 필요	- 재활전문의와 직환전문의가 동상이몽으로 수가로 관계정립 필요 - 직환의 작업환경평가는 15만원에 불과한데 증액이 필요. 1인만 있는 경우에는 민간병원과 공단병원의 협업으로 민간병원이 못하는 것은 공단이 하면 됨(즉, 재활의만 있으면 직환의 관련된 것은 공단으로 내부에서 하는 것으로 검토 필요)
	직장복지지원 의료 기관을 민간의료기 관으로 확대	- 직장복지지원 의료기관을 업무적성성, 작업능력평가를 할 수 있는 병원으로 확대 필요 - 직장복지지원 의료기관은 공단 직영병원 11개에 한정 운영되어 접근성 문제 등으로 활성화 한계가 있어서 민간기관까지 확대 필요 → 민간 산재관리의사가 있는 의료기관까지 확대 필요 → 집중재활과 마찬가지로 작업능력강화 훈련도 민간 산재관리의사가 있는 의료기관으로 확대 필요 - 외부 의료기관 확대시 장비 등 확보가 필요한데 장비가 없어도 대체장비라도 인정해주는 방향 검토 필요. 재활의학과 1인, 직환의 1인이 함께 있어야 하는데 이런 의료기관이 많지 않음.

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안

- 공단 담당직원들은 계획서 제출제도의 성과로 짧은 기간임에도 불구하고 안정적으로 정착하고 있다고 평가하고 있었으며, 사회복지서비스에 대한 조기 인지와 이용으로 원직복귀율 개선 등의 효과를 창출하였다고 평가함
- 계획서 제출제도 의무화와 관련하여서는 패널티는 없는 의무조항으로 전환하고 이해당사자간의 협력의무조항을 마련할 필요가 있다는 의견과 장단기로 제출제도를 의무화하기 위해 노력하고, 필요에 따라서는 제출제도 미이행시 패널티도 부여해야 한다는 의견을 제시함. 일부에서는 제출제도를 통해 원직복귀를 지원하는 것이 중요하지 의무화하고 벌칙을 부여하는 것을 바람직하지 않다는 의견도 제시함
- 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 위해서는 산재근로자 요양초기 재활상담을 강화하고 통합적인 재활업무 조직마련과 인력배치가 필요하다고 함
- 원직복귀 장애요인을 극복하기 위하여 소견서를 활용한 잡코디 중심의 협력체계 운영이 필요하며 사업주 이해 제고를 위한 정보제공과 상담이 필요함. 특히, 원직복귀과정에서

발생하는 다양한 장애요인과 문제점을 해결해주는 잡코디 역할과 공단의 사업주와 근로자간 협력을 조정하는 역할이 필요함

< 표 4-31 > 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안

구분	주요 응답 내용	
제출제도 1년 성과	초기임에도 안정적으로 운영	권고사항임에도 2022년도 약 3,500건 정도 제출·지원되고, 이용사업주 만족도 높음
	사회복귀를 위한 서비스 이용	- 원직장 복귀희망 여부를 파악하여 요양종결 후 사회복귀방법을 빠르게 파악 가능 - 양질의 재활치료와 산재병원의 직업능력강화 훈련과 같은 좋은 서비스를 받게 되는 등 양질의 산재병원의 치료가 이루어짐
	원직복귀율 개선과 요양기간 단축	제출제도의 장점은 원직복귀율 개선과 요양기간 단축. 계획서 제출제도를 통해 지원제도를 초기부터 알 수 있어서 원직복귀에 효과 미침
직장복귀 계획서 의무화에 대한 견해	패널티 없는 의무제도로 전환하고 협력의무조항 필요	- 계획서 제출제도 의무조항으로 수정(패널티 없는 의무조항 - 경과 조치후 패널티 일부 부여). 의학적 소견에서 원직복귀가능시 원직복귀 의무조항 필요 - 산재근로자의 원직복귀를 위해 근로자, 사업주, 공단이 협력하는 협력의무조항 포함 필요
	단기 또는 장기적으로 의무화하고 패널티 등 부여	- 상용직 노동자는 의무제출 필요, 제출제도 의무화 및 과태료 부과 - 단기적으로 강제조항으로 개정(미이행시 패널티 부여 포함), 이해관계자간 협력의무 법제화와 더불어 요양중 산재근로자에게 직장복귀 특진(작업능력강화 프로그램 참여 등) 의무화 필요 - 독일, 프랑스 등은 원직복귀 의무제도를 도입하는 반면, 우리나라는 현금보상 중심 제도운영과 원직복귀의무제도가 없어 산업장해에 따른 직무수행 곤란, 사업주와의 갈등, 재해사업장으로 복귀에 따른 두려움, 사업주 복귀거부 등으로 원직장 복귀가 어려움 - 장기적으로는 원직복귀를 당연히 하는 의무제도 도입 필요. 직무수행이 가능한 경우 산재근로자를 의무적으로 원직복귀를 시키되 이를 위반하는 경우에는 패널티 부여, 산재근로자 또한 복귀를 거부하는 경우에는 휴업급여를 제한하는 강력한 제도적 장치가 필요 - 의사의 소견서에 복귀가 가능하다고 하면 원직복귀를 반드시 해야 함. 캐나다 등은 보험급여를 깎거나 1년치 휴업급여를 반납하는 패널티가 사업주나 근로자에게 주어짐
	제도 의무화 반대	제도 의무화는 반대. 의무화와 벌칙보다 지원하는 것이 중요
제도 활성화 제언	인력증원과 전담인력 배치, 통합적 전담조직 마련	- 제출제도가 단순 제출에 한정되어 있고, 현재 재활보상부 인력으로 오랜 시간이 소요되고 민원서류 처리를 우선하는 문제 발생. 인력증원에 따른 전담인력 배치와 통합적인 조정과 관리 필요 - 지사 인력 추가와 권역별 재활지원팀 업무를 확대하여 재활지원센터를 만들어 권역별 재활업무를 전체 맡아서 하는 방식이 효율적
	요양초기 재활상담 강화	요양 초기 이해관계자 대상으로 재활상담을 통한 계획서 제출~원직장복귀까지 연속적 서비스 제공. 직원 요양보상 민원서류 처리 간소화 및 인센티브(재활상담 수당) 제공

제출제도 부진 등 한계와 개선방향	원직복귀 장애요인 극복과 조정 노력 부족	- 원직복귀 장애요인을 관리하고 해결해 주지 못하고 있음 → 원직복귀 도움을 위한 잡코디 역할 강화 필요(의료기관 담당자 주도에서 잡코디 중심으로 전환 필요) - 요양결정 후 진료계획서는 사업장에 제공되지 않아서 사업주가 진료과정 등에 대한 정보가 없음→진료계획서나 요양정보를 사업주에게 수시 제공해서 복귀계획 구체화 필요 - 지사에서 소견서를 가지고 원직복귀를 하도록 해야 함. 잡코디가 대상자를 발굴해서 사업주와 협의해서 원직복귀가 어렵거나 분쟁이 발생한 대상자를 대상으로 계획서 제출하고 소견서 내도록 해서 원직복귀를 지원하도록 필요 - 공단, 사업주, 근로자 협력모델 필요. 캐나다 모델과 같이 사업주 - 근로자 - 공단이 어떤 의무를 가지고 협력하느냐를 포함한 법조항이 만들어져야 함.
	효과적인 제출방식 부재	- 산재발생 후 필수적으로 노동청에 제출하는 산업재해조사표와 통합 제출하는 방안 - 접근성 높은 산재의료기관 또는 보험사무대행기관이 계획서 제출을 대행하는 방안(산재보험의료기관 제출시 추가 수가 마련 필요)
	상담 등이 부진한 것이 문제	- 사업장 대상 수시 정보제공, 컨설팅, 장애요인별 맞춤형 사업주 지원 등 필요하지만, 전담인력 부재로 단순 제출에만 초점을 두어 실질적 과정관리 미흡 → 과정관리로 사업주, 근로자 실질적 지원 노력 - 사업주가 인식개선 필요 1) 인식제고 노력(제출하면 사업장에 도움된다는 인식 필요) 2) 내외부 직접 안내시스템 구축(전담인력 등)이 필요
	제도를 의무화하지 않은 것이 원인	권고사항이 문제. 우편홍보 등 하고 있지만 우편물이 실제 사업주에게 전달(대부분 경리 등)되지 않고 제출의무도 없는 것이 원인
	사업주 인식과 제 도 이해 부족	- 홍보 부족으로 인한 사업주 인식부족, 권고수준의 제도로 사업주 자발적 제출은 적고, 컨설팅과 최초상담을 통하여 유도해서 낸 건이 많음 → 산재발생 초기 홍보강화로 사업주 인식개선 필요 - 사업주에게 의학적 정보 수시제공과 지원으로 원직복귀에 도움을 주지 못하고 있음. 지사 의료기관 담당자 업무로 재할 개입 부재

□ 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안

- 사업주 지원제도의 경우 기존 대체인력지원금과 직장복귀지원금을 현실화하고 직무전환 비용과 작업장 환경개선 지원이 필요하다는 의견이 제시됨. 아울러 직장복귀계획서 제출제도와 사업주 지원제도가 연계되도록 설계하여 실효성을 높일 필요가 있다고 함
- 사업주에 비해 상대적으로 지원제도가 부재한 근로자를 위하여 원직에 복귀한 산재근로자의 지속고용에 대한 지원과 산재 및 고용보험료 경감과 같은 근로자에 대한 별도 지원 필요성도 제시됨. 즉, 원직에 복귀하지 못하는 이유가 사업주에게만 있는 것이 아니라 근로자에게도 있어서 산재근로자에 대한 유인이 필요하다는 의견

< 표 4-32 > 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안

구분	주요 응답 내용	
사업주 지원정책 적절성과 개선방안	대체인력지원금과 직장복귀지원금 등 확대	· 대체인력지원금 지원사업 개선·확대(직장복귀지원제도와 동일 수준) 확대(안) : 지원대상(50인 미만→300인 미만), 지원기간(최대 6개월 이내→최대 1년 이내), 지원금액(최대 월60만원 이내→최대 월80만원 이내) · 고용유지 사업주에게 지급하는 직장복귀지원금 등(복귀지원금, 적응훈련비, 재활운동비)지원 확대(안) : 직장복귀지원금등 지원대상(장해 12급 이상→장해 14급 이상), 지원기간(최대 12개월→최대 24개월), 지원금액(최대 월 80만원 이내→최대 월 100만원 이내), 지원요건 완화(장애인의무고용 사업주와 무관하게 고용유지 사업주 지급) · (직장적응훈련비용 확대) 현행 직장적응훈련비용을 사업주 직장복귀계획서 제출 사업장에 한정하여 최대 3개월에서 최대 6개월까지 지원 확대. 적응훈련비 3개월 의무보장 및 최대금액인 45만원 금액보장. 원직장으로 복귀한 경우에는 산업재해 승인된 재해자에게 전부 지급하거나 타직장으로 복귀한 경우에도 지원 필요
	직무전환 비용 지원 및 작업환경 개선	· (직무전환 비용지원) 원직무수행이 어려운 산재근로자가 직무전환후 원직장 복귀하는 경우, 사업주에게 직무전환 비용 보전 필요 · (작업환경개선 및 보조공학기기 지원) 사업장 중 작업환경 개선 필요한 경우, 해당 비용 직접 또는 연계 지원 · 작업환경개선 필요. 비용을 안전보건공단에서 지원하고 있는데, 연말에 해주고, 품목도 안 맞아서 할 수 없는 상황. 작업환경개선은 공단에서 외부 자원과 연계해서 하는 것이 공단 역할 이라고 판단 ※ (안전보건공단) 클린사업장(작업환경개선비등), (장애인고용공단) 보조공학기기 지원중이나 '예산부족, 지원대상 및 품목 제한 등' 으로 연계에 제한적임 ※ 유관기관(안전보건공단, 장애인고용공단) 외 외부자원(기업등) 연계 적극 검토 필요
	제출제도와 지원제도의 연계	· 제출제도 안내의 뒤편에 사업주 지원제도 잘 안내 필요. 직장적응훈련비와 재활운동비는 잘 모르고, 직장적응훈련비는 청구절차가 복잡해 청구하지 않고, 재활운동비도 청구를 귀찮아하는 것 같음 · 직장복귀계획서와 따로 만들어진 제도이기 때문에 따로 작동 → 제출제도와 연계성 필요. 제출하면 지원되는 제도여야 하는데 계획서 제출여부와 무관하게 운영됨 · 지원금 대상이 아니더라도 원직장 복귀시 보험료 지원 등 지원제도 개선 필요
근로자 지원정책의 적절성과 개선방안	원직복귀자 지원제도 필요	· 원직복귀자 대상 지원제도 부재. 선진국(독일, 프랑스 등)과 같이 요양기간 중 조기 원직복귀한 경우 휴업급여를 일괄 지급하거나, 복귀촉진수당 등 신설필요 · 원직장 또는 타직장으로 복귀한 경우에 일정기간(6개월이상) 고용된 경우 일정금액 지원금 지급 유인책 필요 · 제출제도 활성화를 위해서는 과태료 또는 산재/고용보험 경감 등 지원 필요 · 일정기간 고용유지시 추가지원 제도 필요
	주거와 이동지원 필요	· 중증장애인 주거지원이나 이동지원은 연간 5-6천명(직장복귀계획서 프로세스 대상자는 더 적음) 정도밖에 대상자가 없어서 이것도 충분히 할 수 있음

2. 사업주 지원 컨설턴트 면접조사

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영절차의 문제와 개선방안

- 사업주를 지원하기 위하여 사업장을 방문하고 있는 컨설턴트들은 직장복귀계획서 제출 대상의 제한은 불필요하며, 요양초기에 사업주 지원제도에 대한 조기 안내를 실시하고 컨설턴트를 활용한 상담과 제도 안내 활성화가 필요하다고 함. 특히, 소규모 사업장의 경우 사업장 방문시 사업주를 직접 대면하고 관련 업무를 수행하는 것이 현실적으로 어려운 만큼 세무대리인 등이 관련 업무를 대신할 수 있도록 개선이 필요하다고 함
- 산재 이후에 사업주와 근로자간 연락이 단절된 경우가 많아서 사업주와 근로자의 직장 복귀 관련 의사를 상호 전달하고 조정할 수 있는 체계가 필요하고 관련 업무를 위해 컨설턴트 등 인력보강의 필요성이 제기됨

< 표 4-33 > 직장복귀계획서 제출과정과 서비스·조직 등 연계

구분	주요내용	
제출 대상의 적절성	제출대상 불필요	· 사업주 직장복귀계획서 제출대상은 특별히 제한 불필요 · 재해근로자를 한 사람이라도 더 복귀시켜 직업복귀율을 올리려고 하는 것이 목적인데 대상을 제한한다는 것은 이치에 맞지 않음
제출절차 (과정) 문제점과 개선방안	요양초기 사업주 지원제도 안내와 영세사업장 일용직 대체인력에 대한 조건 완화	· 사업주는 직장복귀지원금 및 대체인력지원금 제도에 대한 안내는 요양 승인시점인 초기에서 해 줄 것과 청구조건 중 영세사업장 (특히 음식점업)은 일용직 대체인력에 대한 사회보험 가입조건 완화를 가장 많이 요구 · 사업주 지원제도는 산재요양 승인후 최대한 빨리 사업장에 우편안내 및 방문상담 안내 · 원직복귀를 높이기 위한 지원제도를 최대한 활용할 수 있도록 초기 안내 필요
	세무대리인에 대한 안내와 제출	· 즉석에서 계획서를 받기 어려운 상황이 많음. 영세사업장은 세무대리인을 통해서 하는 경우가 많아서 세무대리인에게 설명과 안내필요 · 사업주가 현장에 없어서 바로 작성해 제출하지 못하는 문제 발생
부서 (조직) 인력간 협력 적절성과 개선방안	사업주와 근로자의 의견전달을 위한 정보부재	· 사업주만 방문하고 있어서 사업주와 근로자가 단절이 돼서 연락도 안되고, 사업주가 복귀하면 좋겠다고 하는데 근로자와 연락도 할 수 없어서 불편(근로자 정보 컨설턴트에게 제공 필요) · 사업주가 재해자에게 복귀를 해달라는 희망을 전달해야 하는데 근로자 연락처 부재
	컨설턴트를 활용한 상담과 안내 활성화	· 공단 직업복귀 관련 정규직 인력 부족을 보완하기 위해 시니어 컨설턴트들을 적극적으로 확대해 활용 필요 · 상담시 원직복귀에 대해서 근로자 복귀희망 여부를 물어는 보는데 10%밖에 상담을 안하고 있고 시점도 계획서 제출 보다 상담이 늦어지는 경우 발생

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안

- 직장복귀계획서 제출제도는 권고사항으로 운영되고 있어서 실효성이 부족하여 의무화가 필요하다는 의견과 의무화하되 패널티 보다는 인센티브가 바람직하다는 의견이 제시됨. 즉, 패널티 없는 의무화 추진이 바람직하다는 의견이 제시됨
- 제출제도 활성화를 위해서는 확실한 인센티브를 마련하거나 강제규정을 두는 것이 필요하다는 의견이 제시됨. 무엇보다도 소속기관 직원의 책임감 있는 업무노력과 소규모 등 원직복귀가 어려운 업종에 집중하는 것이 필요하다는 의견이 있었음
- 직장복귀계획서 제출 활성화를 위해서는 패널티 없는 의무제도라도 의무성을 강화하는 것이 필요하며, 현재 사업주 지원제도와 계획서 제출간의 연계성을 높이고 사업주에 대한 홍보와 안내, 컨설팅트를 활용한 상담강화가 필요함

< 표 4-34 > 직장복귀계획서 제출제도 성과와 한계, 개선방안

구분	주요 응답 내용	
직장복귀 계획서 의무화에 대한 견해	권고사항이라 협조가 잘 되지 않아서 의무화 필요	· 제출을 권유해 보지만 반드시 제출해야 하는 것이냐 어떤 불이익이 있느냐? 는 등의 반문을 하며 귀찮아 하면서 제출에 비협조적 · 제출제도 실효성을 위해 의무화 규정을 두는 것이 좋을 것임
	강제화보다는 패널티 없는 의무화 수준	· 강제화보다는 패널티 없는 의무화 수준으로 진행 필요 · 패널티 보다는 인센티브를 주는 것이 필요.
제도 활성화 제언	제출시 확실한 인센티브	· 활성화를 위해서는 제출할 때에 제출하지 않았을 때 보다 인센티브(이익) 제공이 필요 · 계획서를 제출한 곳은 지원제도를 인센티브 차원에서 더 줄 수 있을 것임
	강행규정을 두는 것이 가장 확실, 담당자의 책임감 있는 업무 수행	· 직장복귀계획서를 의무적으로 제출해야 한다는 강행규정을 신설하는 것이 가장 확실 · 컨설팅트 활동이 원활하도록 대상자 명단을 적기에 신속 제공 · 지사 담당자 역할이 제일 중요. 책임감 가지고 할 수 있도록 요청
	소규모 등 원직복귀가 어려운 업종에 대한 집중	· 원직복귀율 향상을 위해서는 소규모 사업장 중 재해빈도가 많은 음식점업종과 도·소매업종 재해발생시(최초요양 승인시점) 지원제도 적극 안내. 또한, 청구조건과 청구방법의 간소화 필요 · 업종별 사업규모별 원직복귀가 불가능한 비율이 높은 그룹과 업종별 연령대별 원직복귀가 불가능한 비율이 높은 그룹에 대한 특별 대안 마련 필요
제출제도 부진 등 한계와 개선방향	의무사항으로 규정	· 계획서 제출해야 하는 것인지 제출하였을 때와 제출하지 않았을 때 이익 또는 불이익이 명확히 구분되지 않고, 의무조항이 아닌 권고사항으로 강제성이 없어 실적이 저조 · 대체인력지원금 등과 연계가 안되어서 의미가 없으며, 패널티는 없어도 의무로라도 하면 될 것으로 보임(패널티 없는 의무제도로 변경 필요)

지원제도와 제출의 연계성 강화	- 제출제도와 직장복귀지원제도의 연계 필요. 즉, 직장복귀지원금이나 대체인력지원금을 수령하기 위해서는 제출해야 한다는 강제규정 - 계획서 제출 사업장에 대한 인센티브 제공방안 강구 필요(제출사업장 추가 인센티브 제공)
사업주에 대한 홍보와 안내 강화	- 사업주가 이 제도에 대해서 잘 모르는 경우가 많음. 산재발생 시점에 충분히 인지할 수 있도록 홍보 필요. 사전안내 제도가 필요(산재발생시점에 충분한 안내) - 신속한 안내가 필요. 담당자에게 신속한 정보제공 - 적극적인 홍보가 안되어서 문제임. 공단에서 왜 제출해야 하는지 등에 취지를 문서 또는 팩스로 보내는 것이 필요 - 방문하는 곳은 8-90%를 받음. 못 가는데, 컨설턴트가 배치가 안된 곳은 홍보가 안됨 - 서비스 업종의 경우 미안해서 복귀를 안함. 대부분 제조업체는 사람을 못구해서 가급적이면 다시 일해주기를 바람
컨설턴트 업무 절차개선으로 제출제도 업무 활성화	- 사업장 방문시 실제로 사업주를 직접 상담할 수 있는 경우가 많지 않아서 직원들에게 계획서 제출을 안내하고 사업주에게 전달할 것을 요청할 수 밖에 없음 - 제출대상 사업장에 해당될 경우 적기(신속)에 사업장 리스트를 컨설턴트에게 제공 - 사업주 부재시 유선통화로 사업주 동의 확인 후 직원의 서명이나 법인 인감 등으로 확인을 갈음하는 방안 - 영세사업장은 행정력이 부족해서 우편물로 봐서 아는 것이지 아직은 모른다고 생각. 그러것도 있어요 하는 수준. 방문상담이 중요 - 직원을 만나는 경우가 많은데, 사업주에게 잘 전달이 안됨. 다른 책임있는 자 또는 법인 날인으로 할 수 있도록 하면 될 것임

□ 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안

- 직장복귀계획서 제출제도의 활성화를 위해서는 사업주 지원제도의 경우 대체인력지원금과 직장복귀지원금을 확대하고 관련 기준을 개선하고, 계획서 제출시 추가적인 지원제도 마련이 필요함. 즉, 직장복귀계획서를 제출한 경우에 차별성 있는 지원이 필요함
- 직장복귀계획서 제출에 따른 지원이 부재한 산재근로자에 대해서는 특진시 추가적인 지원을 제공하고, 직장복귀를 위한 작업장 환경개선이 필요함

< 표 4-35 > 사업주와 근로자 지원제도의 적절성과 개선방안

구분	주요 응답 내용	
사업주 지원정책 적절성과 개선방안	대체인력지원금과 직장복귀지원금의 확대와 개선	- 대체인력지원금 대상은 현행 유지, 지급기간과 지급금액은 확대 필요(지급대상은 현행 유지, 지급기간 6개월을 12개월로 확대, 지급금액 60만원에서 120만원으로 상향(최저임금의 50% 이상) - 직장복귀지원금은 사업주가 산재노동자(장해 12급 이상자/예정자)

		를 복귀시켜 6개월 이상 고용을 유지한 경우 지급하고 있으나, 사업주들은 지급조건 완화 요구(직장복귀지원금 지급조건 완화, 지급 대상은 현행 장해 12급에서 장해 14급까지 확대, 지급기간은 연장(직장복귀후 1개월이 지나면 청구·지급하고 기간도 2년 정도 확대, 지급금액은 월 최저 45만원, 60만원, 최고 80만원을 대폭 상향 조정하여 실질적으로 사업주가 재해근로자를 복귀시켰을 때 혜택을 볼 수 있게 개선) · 서비스 업종은 대체인력지원금을 일당제로 쓰다 보니 비용은 늘어나는데 고용보험에 가입을 못해서 혜택을 못 받음. 대부분 계속 알바를 쓰다가 보니 조건이 안 맞아서 못하는 경우가 많음. 보완책 필요(대체인력에 대하여 고용보험이나 산재보험료 지원, 4대보험에 가입을 하지 않아도 혜택 등) · 직장복귀지원금 12급 유지, 지원금액 상향 요구 · 대체인력지원금 100만원, 직장복귀지원금 100만원 수준까지 인상
	제출한 경우 추가적인 인센티브 운영	· 추가적 인센티브 필요(산재보험료 감액, 대체인력지원금과 직장복귀지원금 추가 지급) · 대체인력지원금 등을 추가로 더 주는 것이 필요. 제출하시는 분들에게만 사업주 지원제도에 일부를 늘리는 것이 필요. 제출한 기업과 미제출 기업에 대한 사업주 지원이 동일하기 때문에 제출한 기업에 대해서 더 지원해주는 방식으로 변화 필요
근로자 지원정책의	특진에 따른 지원	· 직업복귀소견서 발급을 위해 재해근로자가 지정된 의료기관에서 가서 특진을 받는 것을 좋아할 근로자는 없을 것으로 생각. 특진을 하는 근로자에게도 적절한 보상 필요
적절성과 개선방안	작업장 환경개선	· 작업환경개선이 도움은 되겠지만 산업안전공단과 협조해야 할 문제. 노동부 차원에서 풀어야 할 문제(작업환경 개선 필요)

3. 근로자 면접조사

- 조사대상 근로자는 학교와 대기업에 근무하고 있어서 원직복귀를 원칙으로 하고 있는 상황에서 사업주 직장복귀계획서 제출제도가 절차에 따라서 적절히 이루어지고 있으며 근로자에게 불편한 사항이 발생하지 않는 것으로 나타남
- 산재근로자들은 원직복귀를 위해서 필요한 재활과 작업능력강화 훈련을 위한 기구와 공간 등을 추가로 확보하고 작업장 환경개선이 필요하다고 함

<표 4-36> 근로자 면접조사 의견

구분	주요 응답 내용
원직복귀 희망여부와 사업주와 의견소통 여부	· 근로자 2명 모두 원직장 복귀를 희망하며, 1인은 사업장 연락을 받았고, 1인은 받지 않았음
이용서비스와 직장복귀 도움	· 병원 수증치료를 이용(환자에게 무리가 되지 않도록 해서 이용 할 수 있게 해줌) · 병원 필라테스 이용(처음에는 어려웠지만 점차 능숙)
계획서 제출제도 인지 여부와 경로	· 공공학교에 근무하고 있는데, 학교에서 연락와서 서명하고 옴 · 기아 자동차에서 근무하고 있는데 모바일로 동의함
계획서 제출 인지 여부	· 사업주가 제출한 것으로 알고 있음
집중재활치료와 작업능력 강화훈련 이용경험과 만족도	· 두 프로그램 차이가 큼. 작업능력평가는 레벨을 업무에 맞추어서 프로그램을 진행해줌 · 민간병원에서 전원신청을 해서 옴. 산재병원에서는 2주간 관찰한 후 필요한 서비스를 제공해서 편하게 서비스를 이용 · 전원 이전에 도수치료를 했는데 개인비용이 들었고, 산재병원에 와서 다시 검사를 해보니 악화가 돼서 재평가 후 재수술을 함. 심리치료도 해주셔서 좋았음 · 작업능력평가가 쓸모없이 길지 않고 불필요해 보이지는 않았음
기타 원직복귀 촉진을 위한 지원이나 의견	· 산재환자 증가로 복귀훈련실 기구 부족. 자전거도 10분밖에 못 탔. 넓은 공간과 충분한 기구 필요 · 학생 수가 많은 초등학교에 근무하는데 복귀했을 때 교실배식을 하려면 전쟁터인데, 바닥이 미끄럽고 다칠 수 밖에 없는 상황이라 작업환경개선이 필요 · 공장이 넓다 보니까 무거운 짐과 위험요소들이 많은데 성급하게 되어 실수가 있을 수 있음

4. 직업환경의학과와 재활의학과 전문의 면접조사

- 직업환경의학과 전문의에 대한 면접조사 결과 재활의학과와 직업환경의학과와의 협력은 병원마다 차이가 있었으며, 직업능력평가는 현재와 같이 모든 영역을 하지 않아도 되는 경우가 있어서 간소화할 필요가 있음

< 표 4-37 > 직업환경의학과 면접조사 결과

구분	주요 응답 내용
직장복귀지원 운영현황	- 안산병원은 재활의학과를 거치지 않고 직업환경의학과로 가는 반면, 인천병원은 재활의학과를 거쳐서 직업환경의학과로 감. 그 사이에 수익이 발생하지 않음 - 직업복귀소견서를 꼭 쓰고 있는데, 소견서를 쓰기 위해서는 굳이 평가를 하지 않아도 됨. 그런다고 복귀를 잘하는 것은 아님 - 인천은 직무능력평가를 모두 재활의학과에서 하고 있음 - 작업능력평가는 근골관절 위주로 되어 있어서 한쪽 시야가 되어 있는 사람은 별로 의미가 없음. 안과환자들에게 악력 테스트를 하도록 하는게 직무능력평가인데 의미가 없음

- 재활의학과 전문의 면접조사 결과 직업능력평가를 위해 장비를 사용하는 것은 표준화된 것으로 사용하지 않을 경우 더 많은 시간이 소요될 우려도 있음
- 사무직과 재해 정도가 경미한 산재근로자의 경우에 활용할 수 있는 슛폼 형태의 평가도구를 마련하는 것을 필요할 것으로 보임
- 재활의학과와 직업환경의학과 관련 수가와 역할에 대한 구분과 정리는 필요. 구체적으로 재활의학과는 신체기능 측면, 직업환경의학과는 작업환경 측면에 특화하여 역할을 하도록 구분이 필요함

< 표 4-38 > 재활의학과 면접조사

구분	주요 응답 내용
표준화된 장비 사용(이발택)	- 작업능력평가는 외국에서 하고 있고, 표준화된 장비를 쓰는 것은 일관성 있게 하는 것으로 인증이 되고 정리가 됨 - 장비를 안 쓰고 할 수 있다고 하는데 작업자세, 높이 등에 따라서 설정이 되어 있어서 하는 것인데, 만약 안 쓰면 더 시간이 걸릴 수도 있고 어려움 - 시간은 4시간으로 되어 있는데 실제로는 3시간 정도 소요됨. 준비 등으로 고려하면 4시간임 - 작업능력평가 환자 질환군을 분류하기는 힘들지만 하지골절로 기능장애, 척추 쪽이 많음
스�폼 여부	- 사무직과 재해 정도가 경미한 분들도 다할 필요는 없음. 그럴 분들이 4시간을 다할 필요는 없다고 생각함. 재활의학과에서도 슛폼을 만드는 것에 동의함 - 환자를 전체적으로 할 필요가 없기 때문에 직무분석을 해서 고빈도로 꼭 필요

	한 상의 몇 가지 자세만 골라서 하는 것이 필요할 것임 • 전반적인 신체기능 평가는 반드시 필요함 • 직무수행능력 쪽만 선택해서 할 수 있도록 하고 적게 수가를 주는 것으로 하는 것이 어떨런지 검토 필요
워크 하드닝과 집중재활치료	• 의학적으로 특별한 문제가 있는 경우들이 일부 있지만 많지는 않음. 왜냐하면 집중재활이 완전히 끝난 사람만 워크 하드닝으로 넘어가기 때문임 • 작업장 등 병원 외 활동은 이야기가 나오고 있는데 본래 프로세스가 거의 구분이 되기 때문에 따로 하는 것이 바람직
병원수가와 특별수가 개선방향	• 직장복귀지원 의료기관 10개소 운영중으로 12개 수가 적용중임 • 재활의학과, 직업환경의학과 전문의가 처방할 수 있는 수가를 각각 구별 필요 (재활의학은 신체기능평가를 하는데 직업환경의학과는 환경 관련 평가부분으로 구분하는 것과 소견서 작성 시 수가 제공이 필요) • 현재 작업능력평가가 1개로 되어 있는데, 단순 평가방법을 만드는 등 작업능력 평가방법의 세분화 필요(현재 이발택 활용하여 작업능력 평가)

운영실태 합의

제5절

- 사업주 직장복귀계획서 제출이 직장복귀율과 요양기간 단축에 영향을 미치고 있음
 - 계획서 제출 여부에 따른 직장복귀율, 원직장복귀율, 요양기간에 대한 일반차이 분석과 성향점수매칭 분석을 수행한 결과 계획서 제출이 직장복귀율과 요양기간 단축에 긍정적인 영향을 미치고 있었음. 근로자와 사업장 대상 조사에서도 직장복귀계획서 제출제도에 대하여 대체로 만족하고 있으며 직장복귀에 긍정적인 효과가 있다고 응답함
- 사업주 직장복귀계획서의 저조한 제출율에 대한 개선이 필요함
 - 사업주 직장복귀계획서 제출비율은 전체 대상의 약 10%미만으로 제출을 하지 않는 이유에 대한 종합적인 평가를 통한 제도 개선이 필요함. 사업주 직장복귀계획서 제출과 관련하여 제출과정의 장애요인에 대한 확인을 통한 장애물 제거하고 관련 절차를 간소화 하는 등 제출절차 개선 추진이 필요함
 - 제출대상의 적합성에 대한 평가와 개선이 필요함. 즉, 6개월 이상 요양이 예상되는 자 등으로 대상자를 규정하고 있는 부분에 대한 적합성 평가와 개선을 통하여 보다 많은 산재근로자들과 관련하여 직장복귀계획서를 제출하도록 함으로써 원직장 복귀 등 직장복귀율을 향상시킬 수 있는 토대 마련이 필요
- 사업주 직장복귀계획서 제출에 따른 사용자에게 대한 지원제도 확대와 산재노동자에 대한 지원이 필요함
 - 사업주지원을 위한 대체인력지원금 등 제도가 있지만 직장복귀계획서 제출제도와 관련 없이 이용할 수 있는 제도로 기존 대체인력지원금과 직장복귀지원금 등 지원제도를 확대하고 동시에 계획서 제출과 연계된 사업주 지원제도를 마련할 필요가 있음
 - － 사업주들은 사업주 지원금(기간) 확대, 신청서식 간편 개정, 산재근로자 요양정보 제공, 산재보험료 경감, 작업환경개선 비용 지원을 필요로 하고 있음. 신청서식의 간편화와 산재근로자 요양정보제공은 프로세스 개선을 통해 추진 가능하고, 산재보험료 경감화 작업장 환경개선은 새로운 신규사업으로 추진이 필요함
 - － 직장복귀계획서를 제출할 수 있도록 제출한 경우와 미제출한 경우에 지원 수준의 차별성이 명확해야 함
 - 계획서 제출제도와 관련된 산재근로자 대상 지원은 특진 외 지원제도가 부재한 상황으로 원직장 복귀후 일정기간 고용되는 경우에 고용유지지원금을 지급하는 등 추가적인 인

센티브를 마련할 필요가 있음. 원직장 복귀를 하지 않거나, 원직장 복귀후 고용이 지속되지 못하는 이유가 산재근로자의 의지에도 있는 만큼 이에 대한 인센티브 차원의 지원제도 마련이 필요함

- 산재근로자들은 재활상담 및 재활서비스 지원 확대, 직장복귀지원 의료기관 확대, 원직장복귀 촉진 수당 신설, 사업주 지원제도(지원금) 확대, 작업환경개선 비용 지원을 필요로 하고 있음
- 원직복귀촉진수당의 경우 근로자 복귀의지 강화를 위해 도입검토가 필요하며 재활상담 및 재활서비스 지원확대는 제출제도 운영절차 개선과 기존 서비스 연계확대를 통해서 해결노력 필요함. 특히, 직장복귀 의료기관 지원은 관련 기준을 낮추어 추진하고, 작업장 환경개선은 신규사업으로 추진이 필요함

□ 직장복귀계획서 제출 활성화를 위해서는 권고수준의 제도를 의무화하는 노력이 필요함

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도는 권고조항으로 규정되어 사업주가 반드시 해야할 필요성을 느끼지 못하고 있는 상황으로 해당 업무를 수행하는 공단직원 등이 업무에 있어서 애로사항이 발생함
- 계획서 제출 활성화를 위해서는 계획서 제출을 의무화하고 미이행시 사업주와 근로자 모두에게 패널티를 부여하는 것이 필요함. 그러나, 패널티 부여는 제도에 대한 불신을 가져올 우려가 있고 현실적으로도 바로 적용이 어려운 상황이기 때문에 패널티 없는 의무조항으로 조정하는 것이 필요함

□ 직장복귀계획서 제출제도에 대한 홍보강화를 위한 공단의 역할강화가 필요함

- 직장복귀계획서 제출제도와 관련하여 사업주와 근로자 모두 인식과 이해가 부족한 상황으로 산재발생 직후 요양초기부터 적극적으로 안내하고 홍보하기 위한 노력이 필요함
- 사업주와 근로자 모두 직장복귀계획서를 인지하게 된 경로가 공단지사의 안내와 홍보로 나타나서 소속기관과 본부의 체계적인 홍보와 안내가 중요함
- 공단의 제도홍보와 안내, 직업복귀를 위한 구체적인 상담 등 노력을 위해서는 인력증원과 전담인력 배치 등이 필요함

□ 직장복귀지원 의료기관의 확대와 효율적 역할체계를 마련해야 함

- 직장복귀지원 의료기관은 소속병원으로만 제한하고 있어서 많은 산재근로자들이 접근하기에는 한계가 많은 상황임. 또한, 재활의학과와 직업환경의학과 등 진료과목별 전문성을 고려한 수가가 개발되어 있지 않고, 산재근로자 특성을 고려한 맞춤형 접근이 미흡한 상황임
- 따라서 직장복귀지원 의료기관을 민간의료기관으로 확대하여 접근성을 향상시키고, 진료과목 등 전문분야를 고려한 역할부여와 수가 제공이 필요하며, 산재근로자 특성을 고려하지 않은 복잡한 직업능력평가 양식의 개선이 필요함

- 아울러 직장복귀지원 의료기관의 직장복귀계획서 제출 대상 발굴과 계획서 제출을 위한 적극적인 역할수행이 필요함. 이처럼 의료기관이 직장복귀계획서 제출제도에 있어서 필요한 역할을 수행하기 위해서는 전산 등을 통한 정보공유가 보다 원활히 이루어질 필요가 있음
- 산재근로자 원직복귀와 관련된 문제해결을 위한 재할상담 등을 통한 체계적인 해결노력 지원이 필요함
 - 산재근로자의 원직복귀에 있어서는 다양한 문제가 발생하고 있음. 예컨대 사업주의 잘못된 인식으로 근로자의 복귀 거부, 복귀를 반기지 않는 동료와의 문제, 산재근로자의 원직장 복귀 거부와 같은 심리 정서적인 이유와 함께 산재근로자에게 적합하지 않는 작업환경 등임
 - 소속기관을 중심으로 근로자와 사업주와 관련하여 발생하는 다양한 직장복귀의 어려움을 해소하고 필요에 따라서는 상호 협력과 조정의 과정을 거칠 수 있도록 공단의 재할상담과 조정을 강화할 필요가 있음
- 내일찾기 등 기존 사회복귀서비스와의 연계를 강화해야 함
 - 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영에 집중하여 다른 사회복귀서비스와 연계 제공 노력이 미흡함
 - 기존 사회복귀서비스와 연계/제공 과정에 대한 분석을 통한 제도 개선이 필요함. 또한, 제출대상의 사회복귀서비스 수요 대비 미충족서비스에 대한 분석과 서비스 제공 노력이 필요함. 나아가 사업주 직장복귀계획서 제출제도와 사회복귀지원 프로그램을 연계한 포괄적 사회복귀 지원 프로그램 운영프로세스 개발이 필요함
 - 특히, 원직복귀에 어려움이 많은 산재근로자를 대상으로 운영되고 있는 내일찾기 프로그램을 직장복귀계획서 제출제도와 연계하여 운영할 필요가 있음
- 충분한 의료서비스 제공과 재활 이후 직업복귀가 이루어질 수 있도록 하고, 직업복귀소견서를 통하여 직업복귀 가능여부를 전문성에 근거하여 판단하고 관련 정보를 사업주와 근로자에게 제공해야 함
 - 사업주와 근로자가 원직복귀를 어려워하는 중요한 이유가 원직무를 수행하기 어렵다고 판단하기 때문이라는 의견이 상당수 존재함. 근로자가 원직복귀를 희망하지 않는 이유도 자신의 신체적 회복수준이 부족하다고 판단하는 것이 상당할 것으로 판단됨
 - 산재근로자의 체계적인 요양과 재활로 직장복귀가 가능한 수준이 되었음이 확인되었을 때 직장복귀를 지원하도록 하고, 직업복귀소견서를 통하여 사업주와 근로자에게 명확히 확인시켜 줄 수 있도록 해야 함

제 5 장

직장복귀계획서
제출제도 업무
절차분석과 개편방안



업무절차의 현황과 문제점

제1절

1. 요양초기(요양승인 후 3개월 이내)

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
• 최초요양 승인 처리 완료 - 요양급여신청서 : 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의 서식 신설 • 기본 대상 안내 문자DM 발송 ① (자동문자·DM 발송 : 사업주, 산재근로자) 사업주 지원사업 및 사업주 직장복귀 계획서 안내 ② (자동문자 발송 : 근로자) 재활서비스 욕구조사 → 원직복귀 희망여부·직장복귀 계획서 제출제도 희망여부·개인정보동의 • 직장복귀계획서 제도안내 등을 위한 상담 - 상담대상 : ‘상용’ 근로자 (노동보험 종사상 지위 기준에 따라 원직복귀 희망자로 아래 조건에 해당 자 · 중증도지수 ‘경미’ 이상자 또는 요양급여 신청서(최초요양급여신청서)상 소견서에 입·통원 등 예상기간이 6개월이상인 자 ※ 내일찾기서비스 대상자는 직장복귀계획서 제출제도 참여 적극 안내 (제외) 원직복귀 비희망자, 사실상 원직복귀가 어려운 자(건설 일용, 불법외국인, 원 직장 폐업, 요양결정 당시 이미 요양 종결, 최초상담 이전 원직장 복귀자 등)	소속기관 공단본부 소속기관
① (근로자 최초상담 : 요양승인 후 21일 이내) 가. 산재근로자 원직복귀 의사확인 나. 직장복귀계획서 제출제도 참여 동의 확인 - 사업주에게 산재승인 정보 등 원직복귀 준비에 필요한 정보가 제공될 수 있음을 사전 안내 * 근로자 동의 방법 2가지 : ① (동의서류) 개정된 요양급여신청서 뒷면 또는 직업 재활업무처리규정상의 정보제공 동의 서식 활용가능 ② (모바일회신) 원직복귀 의사, 제출제도 정보제공 동의 모바일 회신결과 활용 * 최초상담 후 내일찾기서비스 대상 산재근로자는 직장복귀계획서 제출제도 참여를 충분히 안내하고 참여 협조를 얻어 절차 진행	

□ 현황 및 문제점

- 요양초기 소속기관 직장복귀계획서 제출제도 업무 담당은 병원담당자임
- 요양승인 후 21일내 산재근로자 대면 또는 유선 최초상담이 20-30%수준만 이루어지고 있어서 근로자 원직복귀 희망여부 파악이 불충분하게 이루어지고 있음
 - － 현재 근로자 원직복귀 희망여부 확인방법은 1) 모바일 동의 2) 최초요양신청서상 원직복귀 의사 표기 3) 최초상담(유선 또는 대면)을 활용한 원직복귀 의사 확인 등임. 이러한 방법으로 파악된 원직복귀 의사가 있는 산재근로자에게 DM발송이 이루어지고 있음
 - － 대면 또는 유선 최초상담의 경우에도 원직복귀 의사와 계획서 제출제도 설명이 중요 내용이 아니어서 산재근로자 대상 직장복귀계획서 홍보와 안내가 필요한 상황임
- 원직복귀 비희망 산재근로자의 경우 계획서 제출대상에서 제외하고 추가적인 조치가 이루어지지 않고 있음
 - － 원직복귀 비희망 산재근로자는 직장복귀계획서 제출대상에서 제외하고 DM발송도 제외되고 있음
 - － 비희망 원인파악과 지원노력이 부재함. 또한, 트라우마 등 극복이 어려워 원직복귀를 희망하지 않는 경우 타직복귀 지원이 필요하지만, 타직복귀 지원이 제대로 이루어지고 있는지 확인하기 어려움
 - － 타직복귀 취업지원상담은 공단 퇴직자가 일부 수행하고 있지만, 인원이 적고 지사에 모두 배치되어 있지 않은 상황이어서 충분하지 않음
 - － 근로자가 원직복귀를 희망하지 않는 이유가 해결 또는 조정가능한 경우 원직복귀지원을 위한 직장적응훈련, 재활스포츠 등을 적극적으로 지원하여 원직복귀 지원이 필요함. 현재, 직장적응훈련과 재활스포츠 관련 서류가 복잡하고 힘들어서 활용하지 못하는 경우 많아서 개선이 필요함

□ 개선방향

- 요양초기 직장복귀계획서 관련 소속기관 담당자(전담조직) 업무 역할인식을 강화할 필요가 있음
 - － 업무분장과 역할명확화를 위하여 업무 매뉴얼에 업무역할을 명확히 제시하는 것이 필요함
- 근로자 최초상담을 100%실시하고 직장복귀계획서 설명을 강화하는 등 요양초기부터 직장복귀계획서 제출제도에 대한 설명과 안내를 충실히 해야 함
 - － 근로자 원직복귀의사를 파악하고 이에 부합한 직장복귀 지원을 실시함
 - － 근로자 최초상담 100%실시를 통해 원직복귀여부를 명확히 파악하고, 직장복귀계획서에 대한 충분한 설명이 필요함
 - － 최초상담시 원직복귀계획서에 대한 설명, 원직복귀계획서 제출시 산재근로자 작업능력강화훈련 등 지원제도 설명을 충실히 해야 함

- 원직복귀를 희망하지 않는 근로자에 대한 문제해결 노력을 강화하고 타직복귀를 체계적으로 지원해야 함
 - － 최초상담시 원직복귀 비희망 근로자는 1) 원직복귀를 꺼리는 이유를 명확히 파악하고 이를 해결하기 위한 노력이 필요함 2) 원직복귀를 꺼리는 이유가 명확한 경우 타직복귀를 체계적으로 지원하기 위한 노력이 필요함
 - － 원직복귀를 꺼리는 근로자에게 직장적응훈련, 재활스포츠 등 지원제도를 적극적으로 연계하고 관련 절차와 서류를 간소화해야 함
- 원직복귀 여부 상담과 후속적 지원을 위한 지사 또는 본부 재활조직을 강화해야 함
 - － 재활지원팀 확대 개편으로 직장복귀계획서 상담을 강화하고, 타직복귀 지원업무를 추가해야 함. 또는 직장복귀계획서 제출대상 관리와 원직과 타직복귀, 사후관리까지 지원하는 통합적 재활지원조직을 마련해야 함

2. 최초상담

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
• 원직복귀를 희망한 산재근로자의 사업주 안내 DM - (본부) 원직복귀 의사 확인(최초상담, 개인정보 동의 등) 확인된 경우 → 사업주 대상 직장복귀계획서 제출제도 안내문 및 서식 DM 발송	공단본부

□ 현황 및 문제점

- 원직복귀의사가 확인된 산재근로자 사업주만을 대상으로 직장복귀계획서 제출제도를 안내하고 있음
- 산재근로자가 원하지 않으면 제외하도록 규정(직업재활업무처리규정)하고 있음. 그러나, 최초상담을 통한 원직복귀 희망여부가 제대로 파악되지 않는 상황이어서 원직복귀의사가 있는 산재근로자 사업주에 대한 안내가 다수 누락될 가능성이 있음
 - － 산재근로자 의사와 상관없이 복귀를 희망하는 사업주에 대한 안내도 누락될 가능성이 있음. 실제로 사업주들은 복귀를 희망하지만 근로자들이 복귀를 희망하지 않아서 원직에 복귀하지 못하는 경우도 다수 발생하고 있음
 - － 소속병원에서 직장복귀계획서 제출 대상을 발굴하여 계획서 제출을 요청하고 있는 상황을 고려하면 모든 제출대상 사업주에게 직장복귀계획서 제출제도 안내문과 서식을 발송하는 것이 바람직할 것으로 보임

□ 개선방안

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도 대상 산재근로자 사업주에게 안내문과 서식을 전수 받
송함
 - 사업주 직장복귀계획서 제출제도 대상인 산재근로자가 근무했던 사업장 사업주에게
전수 안내하는 것이 제도홍보와 계획서 제출률 향상에 기여할 것임
 - 산재가 발생한 사업장의 모든 사업주에게 발생하는 것도 향후 검토 필요함

3. 최초상담 이후 ~ 직업복귀 준비기까지

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
• 직장복귀계획서 제출 요구 - 산재근로자 최초상담 진행 후 1개월 이내(요양승인 후 2개월 이내) 제출 요구. 다만, 6 개월이상 요양자는 회복상태 감안, 요양종결 3개월 이전까지 계획서 제출·처리완료 - 필요시 1회차 제출요구 후 제출기간 도과 시 2차 제출요구 가능 ※ 재제출 요구 불응시 소속 산재근로자 원직복귀 의무를 공문 안내 후 제출요구 업 무 종료 → 산재근로자에게 관련 사실 안내 - (재활계획 반영) 산재근로자가 내일찾기서비스 대상인 경우, 직장복귀계획서 제출 및 지원사항을 ‘재활계획’에 반영하여 사례관리 • 사업주에게 직장복귀계획서 제출 요청 공문 - 사업주 직장복귀계획서 제출요청 공문 발송(제출기한 30일, 근로자 원직복귀 의사를 명시하고 사업주에게 계획서 제출을 요청) - 대상 : 원직복귀의사가 확인된 산재근로자의 사업주 • 접수처리 권한 : 원소속지사, 현소속지사(직업복귀소견서 희망시 현소속지사 처리) • 사업주 직장복귀계획서 제출 및 직업복귀소견서 희망시 - 소속 산재근로자의 정보제공 동의 최종 확인 • 사업주 대상 계획서 이행지원 - 제출된 직장복귀계획서에 명시된 요청사항 ① 사업주지원제도 안내 및 연계(직장복귀지원금, 대체인력지원금 등) ② 직업복귀소견서 제출 희망시 → 소속 산재근로자 직업복귀 특진절차 진행 ③ 기타 산재근로자 요양기간결정 정보(요양·보험급여결정통지서 등 요청사항 제공 • 산재근로자 대상 재활상담 진행 - 재활특진 등 재활상담/지원상담(내일찾기 담당자, 의료기관 담당자, 재활서비스 담당자)	소속기관

□ 현황 및 문제점

- 사업주 직장복귀계획서 제출 관련 공문을 계획서를 제출하지 않은 사업장에 한하여 발송하고 있음
 - － 소속기관 재할 서무가 일괄하여 직장복귀계획서 안내 공문을 발송하고 지원금 등 제도를 안내하고 있음
 - － 근로자가 원직복귀를 희망하나 사업주가 계획서를 내지 않는 경우 2차 공문안내를 하도록 하고 있지만 실제로 적절히 이루어지고 있는지는 파악되지 않고 있음
 - － 근로자가 원직복귀를 희망하지만 사업주가 직장복귀계획서를 내지 않는 경우 관련 조치와 지원활동은 거의 없는 상황임. 즉, 산재근로자가 원직복귀를 희망하는 경우는 계획서 제출 안내 공문과 대면 설명이 필요함에도 불구하고 공문이 최종 행정행위가 되고 있으며 추가적인 노력이 부재한 상황임
- 요양중 지원하는 재할서비스는 희망찾기, 심리상담 정도이며, 내일찾기는 원직복귀를 희망하지만 어려운 분들을 지원하는 프로그램이지만 직장복귀계획서 제출제도와 연계하여 운영하는 부분이 없는 상황임
 - － 내일찾기 또는 재할서비스가 직장복귀계획서 제출제도 활성화를 촉진하거나, 제출제도와 연계되어 시너지 효과를 가져올 수 있도록 개선이 필요함
 - － 타직복귀도 희망찾기나 심리상담 등 재할서비스를 제공하고 있지만, 타직복귀 관련 특화된 재할서비스 제공이 부재함. 타직장복귀 희망 산재근로자는 이를 지원하는 11개 권역 재할요양팀의 적극적인 지원개입이 필요한 상황임
 - － 타직장복귀 지원은 취업알선사업과 취업지원위탁사업 등 운영중에 있지만, 내일찾기와 같이 1:1로 지원하는 밀착형 지원 시스템은 부재함. 타직복귀 지원과 관련해서는 현재 지원되는 서비스에 대한 종합적인 평가와 개편이 필요할 것임
- 직장복귀소견서를 직장복귀계획서를 제출하지 않아도 받을 수 있는 등 직장복귀계획서 제출과 원직장 복귀지원의 연계성이 부족함
 - － 원직장 원직무, 원직장 타직무(직무변경), 타직장 원직무 모두 직장복귀소견서를 받을 수 있어서 작업능력강화훈련을 받을 수 있음. 즉, 타직장 원직무도 산재근로자가 직장복귀소견서를 신청해 작업능력강화훈련을 받을 수 있음
 - － 원직장 원직무인 경우 사업주가 직장복귀계획서를 제출해야 해서 더 어려울 수 있으며, 타직장 타직무만 작업능력강화훈련을 못 받는 문제가 있음
 - － 작업능력강화훈련 외에 직장복귀계획서 제출을 강화하여 원직장복귀를 활성화할 수 있는 유인 수단이 추가로 필요함
- 타병원 요양 근로자 최적의 시기에 재할특진이 이루어지지 않는 경우가 다수 발생하고 있음. 초기에 특진을 보내서 이야기해보면 공단 특진을 희망하시는 경우와 그렇지 않은 분들이 나뉘어서 전원처리를 안 하거나 하지 않으려고 해서 진행하지 못하는 경우가 있음. 이 경우 요양종결 직전에 이어서 특진을 진행하는 상황이 발생하여 요양기간을 연

장하는 문제를 초래함

- 산재근로자 개인의사에 맡겨 놓고 있어서 발생하는 문제로, 직장복귀계획서 의무화 또는 인센티브 제공으로 재활치료 후 적정 시기에 복귀하도록 할 필요가 있음
- 타 병원에 있는 경우 최초 입원시 직장복귀계획서 제출안내를 통해서 계획서를 제출하게 되면 특진을 위한 소속병원 전원에 도움이 되기 때문에 직장복귀계획서 제출과 직장복귀특진을 유도하기 위한 지속적인 노력이 필요함
- 소속병원은 계획서가 제출되지 않은 근로자도 담당의사가 작업능력강화훈련이 필요하다고 판단하면 계획서 제출을 위해 다각적인 노력을 수행하고 있음
 - 1) 소속기관에 연락해서 내도록 해달라고 하거나 2) 근로자 본인에게 직접 받아오도록 함. 그래도 계획서 미제출시는 사업주와 관계가 안 좋은 경우로 3) 산업위생사가 연락해서 방문하거나 4) 산재간호사가 연락하기도 하는 등 적극적인 제출 노력을 하고 있음
 - 병원판단으로 계획서 제출이 필요한 경우 1차로 소속기관에 요구하고, 1개월 이내에 제출되지 않으면 소속병원에서 직접 처리하고 있음
 - 소속병원에서 요양중 직장복귀특진과 작업능력강화훈련이 필요한 대상자를 적극적으로 발굴하고 계획서 제출을 유도하는 지원 노력이 필요함
 - 소속병원에 재활특진으로 방문하면 집중재활, 작업능력강화훈련 등 의료기관 내 재활에 대한 상세한 설명을 통해 직장복귀특진과 직장복귀계획서 제출을 유도할 필요가 있음
 - 산재간호사의 계획서 제출제도, 작업능력강화훈련에 대한 적극적인 홍보와 안내 역할
- 비소속병원에 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서를 제출하지 않는 경우는 적절한 개입이 부재한 상황임
 - 비소속병원 요양환자의 경우 원직복귀를 희망하지만 계획서 제출이 안된 경우는 소속기관에서 역할을 해야 하지만 충분히 안내와 개입이 이루어지지 못함. 결국 소속기관 차원의 DM과 공문으로 제출 안내가 되는 수준에서 종결이 이루어짐
 - 비소속병원 환자는 직업재활과 작업능력강화 필요성을 인식하지 못하게 됨, 따라서 집중재활이나 특진 연계 수가를 제공 등 관심을 가질 수 있도록 비소속병원 참여를 유인하기 위한 노력이 필요함
 - 비 소속병원의 경우 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서를 제출하지 않은 경우 계획서 제출을 위해 적극적으로 노력하는 전담체계가 부재함. 이 경우는 소속기관 병원담당자의 적극적인 역할이 요구됨

□ 개선방안

- 직장복귀계획서 제출 안내와 요구에도 불구하고 미제출하는 경우 지속적인 제출제도와 지원제도에 대한 대면 및 비대면 안내가 필요함

- 공단이 개입하여 사업주가 산재근로자의 상태를 이해하고 필요한 치료와 적극적인 재활 후 직장 재복귀할 수 있음을 설명하는 과정이 필요함
- 산재근로자가 원직복귀와 직장복귀특진을 희망하는 경우 적극적으로 직장복귀계획서 제출을 요구할 수 있는 절차가 필요함
 - 산재근로자는 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서가 미제출된 경우 근로자가 계획서를 내도록 요구하는 절차가 필요함(즉, 원직복귀를 희망하고 강화훈련을 받고 싶다는 의사표시를 근로자가 명확히 할 수 있는 절차 필요)
 - 사업주가 계속 제출을 거부하는 경우 거부 사유에 대한 안내 후 조정 노력이 필요함
- 내일찾기 대상 요건에 ‘원직복귀 희망자중에서 직장복귀계획서가 미제출된 경우’를 추가하여 계획서 제출여부와 내일찾기서비스를 적극적으로 연계할 필요가 있음
 - 내일찾기 대상은 원직복귀 희망자중 계획서를 낸 경우와 내지 않은 경우에 모두 해당됨. 향후 원직복귀 희망자 중 복귀에 어려움이 많은 대상자 중 계획서가 미제출된 경우로 전환하는 것을 검토해야 함
- 타직장복귀 희망자에 대한 재활서비스 지원을 강화해야 함
 - 타직 원직무 또는 타직, 타직무를 희망하는 근로자에 대한 1:1밀착형 재활서비스 또는 직장복귀지원을 실시해야 함
 - 권역별 재활요양팀의 타직장복귀 지원을 적극적으로 연계하여 지원해야 함
 - 타직장 타직무도 직장복귀에 필요하다면 직장복귀소견서를 요청할 수 있도록 해서 직장복귀에 도움이 되도록 할 필요가 있음
- 산재간호사의 직장복귀계획서 제출제도에 대한 설명과 역할강화가 필요함
 - 재활특진환자 방문시 산재간호사를 통한 계획서 제출제도와 작업능력강화훈련에 대한 안내와 홍보를 강화할 필요가 있음
 - 산재간호사가 병원에 요양중인 근로자를 대상으로 제출제도 안내와 직장복귀를 적극적으로 연계할 수 있는 시스템을 구축해야 함
- 소속병원이 직장복귀계획서 제출에 적극적으로 참여할 수 있는 기전 마련 및 전담조직을 운영해야 함
 - 작업능력강화훈련을 위하여 계획서 제출을 위한 소속병원의 노력이 있는 반면, 일부 병원은 집중재활치료를 더 늘려서 하는 방법을 활용하는 경우도 있음. 병원이 적극적으로 제출제도와 관련하여 역할을 수행할 수 있는 경영평가 지표 반영 등 실제적인 노력이 필요함
 - 소속병원 내 재활지원부 등에 전담팀을 운영하는 것이 필요함
- 소속병원 직장복귀계획서 미제출 근로자에 대하여 계획서 제출 집중관리가 필요함
 - 소속병원 산재간호사와 소속기관 담당자 직장복귀특진과 작업능력강화훈련이 필요하지만 계획서가 미제출된 대상자에 대하여 적극적인 관리와 계획서 제출을 위한 노력이 필요함

- 비소속병원 산재근로자 적기 직장복귀특진과 전원을 체계적으로 지원해야 함
 - － 소속기관 담당자는 최초상담 후 파악된 원직복귀 희망자에 대한 모니터링과 관리로 직장복귀특진과 전원이 적기에 이루어질 수 있도록 유도해야 함
 - － 산재근로자 개인의사에 맞게 놓고 있어서 계획서의 낮은 제출율이 발생하고 있어서 직장복귀계획서 의무화 또는 인센티브 제공으로 재활치료 후 복귀를 유도해야 함
- 비소속병원 원직복귀 희망자에 대한 집중관리가 필요함
 - － 민간병원에 입원한 한 경우 원직을 희망하지만 사업주가 계획서를 안낸 경우에도 소속병원과 마찬가지로 소속기관 병원담당자가 1) 사업주에게 제출요구 2) 근로자가 직접 받아오도록 요구하는 등 적극적인 조치가 필요함
- 비소속병원의 직장복귀특진 연계에 대한 수가 보상체계 운영이 필요함
 - － 소속병원이 아닌 의료기관에서 요양중인 근로자의 경우 원직복귀 희망하지만 직장복귀계획서 제출이 안된 경우 지속적인 안내와 홍보가 어려운 상황이어서 근로자가 직장복귀지원제도나 특진에 대한 이해가 부족함. 이에 비소속병원이 역할을 할 수 있도록 연계수가를 운영하는 것이 필요함
- 비소속병원 요양근로자에 대해서는 소속기관 전담부서의 적극적인 역할 수행이 필요함
- 원직복귀에 대한 근로자와 사업주 의견 불일치를 조정하고 필요한 내용을 지원할 수 있는 위원회를 운영해야 함
 - － 산재근로자가 원직복귀 희망하지만 직장복귀계획서 제출을 계속 거부하는 경우, 사업주는 원직복귀를 희망하지만 산재근로자가 원하지 않는 경우 등은 공단안에 조정 및 지원위원회를 설치하여 운영하는 것이 필요함

4. 직업복귀지원 기초상담

☐ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
• 산재근로자 대상 직장복귀지원 기초 상담 - 의료재활 상담제공 : 산재관리간호사	소속병원

☐ 현황 및 문제점

- 집중재활치료와 작업능력강화훈련의 차별성이 모호함. 사업주가 직장복귀계획서를 제출하지 않으면 작업능력강화훈련을 받지 못하지만, 병원에서는 집중재활치료를 더 늘려서

하는 방법이 있어서 계획서 제출이 재활에 큰 영향을 주지 못함

□ 개선방안

- 산재근로자의 상태에 따라서 집중재활과 작업능력강화훈련으로 연계가 적절히 이루어지고 있는지 모니터링 및 관리가 필요함
- 소속병원에 직장복귀지원 체계화를 위한 전담조직 운영이 필요함

5. 직업복귀준비기

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
• 직장복귀지원 특별진찰 의뢰 - 대상: 제출된 직장복귀계획서에 직업복귀소견서 요청시 - (재활특진 조기의뢰) 직장복귀계획서 상 ‘직업복귀소견서’ 제출 요구가 확인된 산재근로자로 집중재활치료대상 승인상병이 있는 경우, 재활담당자(또는 직장복귀계획서 처리담당)는 재활특진 적극 안내 - (지원상담 진행) 소속기관 특진업무 담당자는 산재근로자가 직장복귀계획서 제출 대상인 경우 조기 재활특진부터 진행 될 수 있도록 상담 진행 ※ 산재관리간호사 재활상담 입력결과가 있을 경우, 소속병원을 통해 재활특진부터 직장복귀지원 특진까지 연계 진행될 수 있도록 지원상담 진행 • 직장복귀지원 특별진찰 진행(직업복귀소견) : 기본직무분석 + 직업능력평가 + (필요시 진행) 작업능력강화훈련[전원필요] - (특진대상) 사업주가 직장복귀계획서를 통해 직업복귀소견서 발급이 요청된 산재근로자로 제출된 직장복귀계획서에 직업복귀소견서 ‘희망’ 표시된 경우 해당 - (특진의뢰) 특별진찰(환자가 요양중인 의료기관이 직장복귀지원 의료기관이 아닌 경우 직장복귀지원 의료기관으로 특진 의뢰), 소견의뢰(환자가 요양중인 의료기관이 직장복귀지원 의료기관으로 지정되어 있는 경우) - 소속기관에서 직장복귀지원 특별진찰 의뢰는 산재근로자별 진행하며, 작업능력강화훈련 후 직업복귀소견서 2차 발급은 특별진찰 추가 의뢰 없이 직장복귀지원의료기관에서 진행 - (특진가능 의료기관) 직장복귀지원 의료기관으로 지정된 의료기관(10개소) * (직장복귀 지원 특진) 직업복귀소견서 제공이 필요한 경우 • (일반) 기본직무분석, 직업능력평가 후 직업복귀소견서 발급 의뢰 • (의료기관 변경) 특진결과 작업능력강화 훈련이 필요하다는 특진의 소견 제출시, 해당 산재근로자의 의료기관 변경(전원)신청에 따라 진행 ※ 작업능력강화훈련 후 직업능력평가 진행을 통한 직업복귀소견서 발급 진행	소속기관 직장복귀지원 의료기관

- (특진시기) 협의된 특진일정에 따라 직장복귀지원 의료기관 특진 진행, 가급적 요양종결 예정일 3개월 이전 관련 절차 진행하고, 요양기간 중 특진 의뢰 - (특진비회망) 직장복귀지원 특별진찰 아래 대상자가 비회망할 경우 • (사업주) 사업주 직장복귀계획서 ‘변경제출’ 안내 후 변경된 사업주 직장복귀계획서 접수처리 → 특별진찰 철회-사업주 비회망 체크 후 첨부파일(변경제출 서류) 저장 • (산재근로자) 특진은 사업주의 요청에 의해 실시되며, 특별한 사유가 없으면 소견서 발급을 위해 특진이 필요함을 안내. 충분한 안내에도 불구하고 비회망시 비회망 사유 지원상담 입력 → 사업주에게 산재근로자의 비회망 사실 안내(공문) → 특별진찰 철회-산재근로자 비회망 체크 후 첨부파일(공문) 저장 - (산재관리간호사 재활상담 활용) 소속병원 산재관리간호사가 진행한 재활상담 입력결과를 참고하여 특진업무 활용 • 직장복귀소견서 작성 • 결과제공 : 특진 의료기관에서 회신된 직업복귀소견서는 소속기관에서 사업주·산재근로자에게 제공, 필요시 계획서 변경 제출 요구	
---	--

□ 현황 및 문제점

- 직장복귀계획서 제출시 소견서 비회망에 적는 경우가 일부 존재하는데, 이 경우 작업능력강화훈련을 받지 못하기 때문에 소속기관에서 요청해서 사업주에게 다시 수정해 제출해 줄 것을 요청하고 있음
- 직장복귀지원 의료기관이 소속병원 10개 기관에 불과하여 접근성과 역할에 한계가 있음. 현재 소속병원만으로 직장복귀지원을 활성화하기에는 한계가 많음. 따라서 요구되는 장비를 다양화하는 등 민간의료기관이 수행할 수 있도록 기준 변경이 필요함
 - 실제로 직업복귀특진의 경우 하더라도 거리 때문에 포기하는 경우가 많아서 직장복귀지원의료기관을 확대해야함
 - 필요하다면 직업능력평가와 작업능력강화훈련을 다른 기관에서 수행할 수 있도록 하는 것도 검토되어야 함. 예컨대, 직업능력평가는 장비기준을 낮추어서 민간기관까지 확대하고, 작업능력강화훈련은 소속병원에서 수행하는 방안도 가능할 것임
- 재활의학과와 직업환경의학과 전문진료영역의 역할정립과 연계를 통한 체계화된 산재근로자 직장복귀지원이 필요함
 - 현재 직장복귀특진시 재활의학과 의사가 먼저 진료 후, 직업환경의학과에서는 어떤 업무를 했는지 복귀에 대해서 어떻게 생각하는지(복귀에 관해서는)에 대하여 평가하고 있음
 - 현재 작업능력평가는 재활의학과에서(처방권은 재활의학 및 직업환경의학과) 주로 진행함(실제평가는 작업치료사가 수행). 직업환경전문의가 작업환경특진을 처방하면 산업위생사가 현장에 나가서 확인하는 절차로 운영됨
- 직업환경의학과 작업환경개선에서의 역할 한계 발생하고 있어서 실제적인 역할을 수행

할 수 있도록 해야 함

- 작업환경의학과에서 사업장을 방문하여 작업환경개선을 요구해도 작업환경을 바꿀 재원이나 프로그램이 없어서 하지 못하는 상황임
- 직업복귀소견서에 대한 사업주, 근로자 대상 충분한 설명이 미흡하여 실효성이 부족함
 - 소속기관에서 직장복귀소견서를 사업주에게 발송하고 있지만, 상호이해가 부족함. 특히, 소속기관에서 담당직원이 직업복귀소견서 내용을 전문적으로 설명하기 어렵고, 사업주도 비의료인의 설명내용을 신뢰하기 어려운 상황임

□ 개선방안

- 직장복귀계획서 제출시 직장복귀소견서 비회망인 경우 조치절차를 명확히 해야함
 - 소속기관에서 사유를 확인하고 직장복귀특진의 필요성을 대면 또는 유선으로 자세히 설명하여 변경할 수 있도록 지원해야 함
- 직장복귀지원 의료기관 확대와 소속병원/민간의료기관의 협업을 강화해야 함
 - 직장복귀지원을 활성화하기 위해서는 환자들의 직장복귀지원 의료기관 접근성을 높이는 것이 필요함. 이를 위해서 요구되는 장비를 다양화하는 등 기준을 다양화하거나, 장비없이 작업능력을 평가할 수 있도록 해야 함
 - 소속병원과 민간의료기관 협업체계 구축이 필요함. 즉, 작업능력평가는 장비기준을 낮추어서 민간기관까지 확대하고, 작업능력강화훈련은 소속병원에서 수행하도록 함
- 재활의학과와 작업환경의학과 전문영역의 역할정립과 연계지원이 필요함
 - 직장복귀지원을 위한 작업능력평가, 작업환경개선, 작업능력강화훈련, 직업복귀소견서 작성 등의 영역에서 재활의학과와 작업환경의학과 전문성 활용과 협업을 강화함
- 작업환경의학과 현장에서 역할을 하려면 작업장 개선 관련 사업이나 지원제도를 운영하여 작업환경의학과 역할의 실효성을 높여야 함
 - 작업환경의학과는 경우 작업현장에 대한 확인과 개선방향에 대한 전문성을 활용할 수 있도록 관련 활동을 강화할 필요가 있음. 아울러 실효성 있는 활동이 이루어질 수 있도록 작업환경 개선사업이나 지원제도를 운영하는 것이 필요함
 - 작업환경의학과에서 현장 개선을 지도하고 이를 지원할 수 있는 사업운영이 필요함
- 직장복귀소견서 설명 주체의 명확화가 필요함. 1차로 소속기관에서 담당직원이 설명하고 필요할 경우 2차 소속병원 산재간호사가 설명함
 - 직장복귀소견서 제공 후 소속기관 담당직원이 설명하도록 하고, 사업주가 추가적인 설명을 요구하는 경우 소속병원 산재간호사가 설명할 수 있도록 함
 - 의료기관에서의 직장복귀소견서 설명에 대해서는 설명수가를 마련하여 제공함

6. 직장복귀 자문회의(필요시)

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
- 직장복귀계획서 전문가 자문 - 직장복귀계획서 변경을 위해 자문이 필요한 경우, 직업복귀소견서에 대한 전문가 자문이 필요한 경우 등 (자문대상) 직장복귀계획서 제출이후 원직복귀 이행과정에 이견이 있는 사업주 또는 산재근로자 (자문진행) 소속기관 자문 건을 취합, 지역본부에서 월 1회 이상 회의 (자문내용) 제출된 직장복귀계획서 변경사유 타당성 및 직업복귀소견서 결과에 관한 전문가 자문	지역본부

□ 현황 및 문제점

- 자문회의는 실제로 운영되지 않고 있음. 자문회의는 한번도 진행하거나 의뢰한 경우가 없음. 예컨대, 원직장에 복귀하되 직무를 변경해야 하는 경우에는 사업주가 계획서 제출시 직무변경을 체크해서 계획서를 제출하기 때문임

□ 개선방안

- 향후 직장복귀계획서 제출제도가 의무화되거나 활성화되면 다양한 상황이 발생하여 필요한 경우가 발생할 수 있기 때문에 제도는 유지하는 것이 필요함

7. 사후관리(요양종결 후 6개월 까지)

□ 업무내용 및 수행주체

내 용	업무수행
- 직장복귀계획서 이행 관련 고용유지 모니터링 - 직장복귀지원금 및 대체인력지원금 등 지급 - 산재근로자 요양종결 이후 6개월 동안 2회(종결 후 2~3개월 시점 1회, 종결 후 6개월 1회) 상담 후 전산처리(노동보험 지원상담) - 산재근로자 고용보험 피보험 자격유지 사실 등 개발된 전산 조회를 통한 고용유지 모니터링 진행 - 직장복귀지원금 및 대체인력지급이 지급된 경우 해당업무 자격확인 등 고용유지 모니터링과 연계하여 동시 진행	소속기관

□ 현황 및 문제점

- 본부에서 직장복귀계획서 제출한 근로자중에서 원직에 복귀한 경우 고용유지 상황에 대해서는 모니터링하고 있지만, 제출 후 원직복귀를 하지 않는 근로자(약 20%)에 대해서는 관리가 이루어지지 못하고 있어서 원직복귀를 하지 않은 이유에 대하여 확인하고 해결책을 모색하는 것이 필요함

□ 개선방안

- 요양종결 후 원직복귀한 근로자와 원직복귀하지 못한 경우로 구분하여 사후관리를 체계적으로 실시해야 함
 - － 원직복귀한 근로자의 경우 지속 고용유지 여부를 확인하고 지속고용에 대한 필요한 지원 필요성을 확인하는 것이 필요함
 - － 원직복귀를 하지 못한 근로자의 경우 원직에 복귀하지 못한 원인을 파악하고, 사업주와의 이견이 있는 경우 조정을 실시하고, 원직복귀가 불가능한 것이 명백한 경우 타 직복귀 등 지원이 필요함

제2절 업무절차 개선방안

1. 업무절차 개선방안

□ 업무절차 개선목적

- 사업주 직장복귀계획서 제출 활성화를 통해 원직복귀율을 향상시킴
- 산재근로자의 원직과 타직복귀 희망에 따른 맞춤형 직장복귀지원으로 직장복귀율을 향상시킴
- 소속병원과 비소속병원에 요양중인 모든 산재근로자에 대한 관리체계를 운영함
- 직장복귀계획서 제출제도 대상분류에서 사후관리까지의 과정관리를 체계적으로 실시함
- 사업주와 산재근로자의 원직복귀 의견차이에 대한 협력과 조정을 실행함

□ 지원조직과 인력운영방향

- 소속기관 전담조직 운영으로 근로자 원직복귀 희망 여부, 사업주 직장복귀계획서 제출 여부를 고려한 산재근로자 밀착형 관리체계를 운영해야 함
 - － 산재근로자 초기상담을 통한 원직복귀 등 직장복귀희망에 대한 전수파악
 - － 요양초기부터 사업주 직장복귀계획서 제출제도와 관련 지원제도에 대하여 사업주, 산재근로자에게 안내와 상담 실시
 - － 산재근로자와 사업주의 직장복귀에 대한 이견과 직장복귀 관련 장애요인을 해결하기 위한 적극적인 활동
 - － 소속병원 요양환자에 대하여 병원과 연계하여 밀착관리
 - － 소속병원이 아닌 의료기관에 요양중인 산재근로자에 대한 집중관리 수행
- 소속병원을 사업주 직장복귀계획서 제출주체로 추가하고 해당 업무를 수행할 수 있는 병원내 전담인력 또는 전담조직을 마련함
 - － 소속병원 의사소견에 따라서 직장복귀특진이 필요한 환자에 대하여 적극적인 직장복귀계획서 제출제도 안내와 관련 업무 진행
 - － 요양환자중 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서가 제출되지 않은 근로자와 의사소견에 따라서 직장복귀특진이 필요한 근로자에 대한 밀착관리 필요
 - － 소속기관 전담조직 및 인력과 정보연계, 소통으로 직장복귀계획서 제출업무 효율적

운영

- 소속병원에서 발급된 직업복귀소견서의 내용을 사업주와 근로자에게 전문적으로 설명하고 안내하여 직업복귀지원

□ 업무절차 개선추진 내용

- 요양초기부터 사업주 직장복귀지원제도에 대한 적극적인 안내와 관련 지원제도 홍보를 실시함
 - 전체 산재근로자를 대상으로 최초상담 등을 통해 원직복귀 희망여부 파악후 맞춤형 직장복귀지원 추진
- 최초상담 이후 계획서 제출을 적극적으로 유도할 수 있도록 안내와 홍보를 강화하고, 원직복귀에 대한 사업주와 근로자 이견시 적극적으로 조정하기 위해 노력함. 아울러 소속병원과 비소속병원 요양환자에 대한 직장복귀지원을 강화함
 - 직장복귀계획서 제출과 원직복귀에 어려움이 있는 근로자에 대해서는 내일찾기 연계 등 지원강화
 - 타직복귀 희망 근로자의 경우 맞춤형 지원
- 직업복귀준비기의 원활한 지원을 위하여 직장복귀지원 의료기관을 지속적으로 확대하고, 직업환경 개선과 직장복귀소견서 활용을 강화함
- 원직장복귀와 미복귀 근로자를 분류하여 체계적인 사후관리 강화를 추진함. 특히, 원직 미복귀자의 경우 원인과 문제해결 노력을 강화함

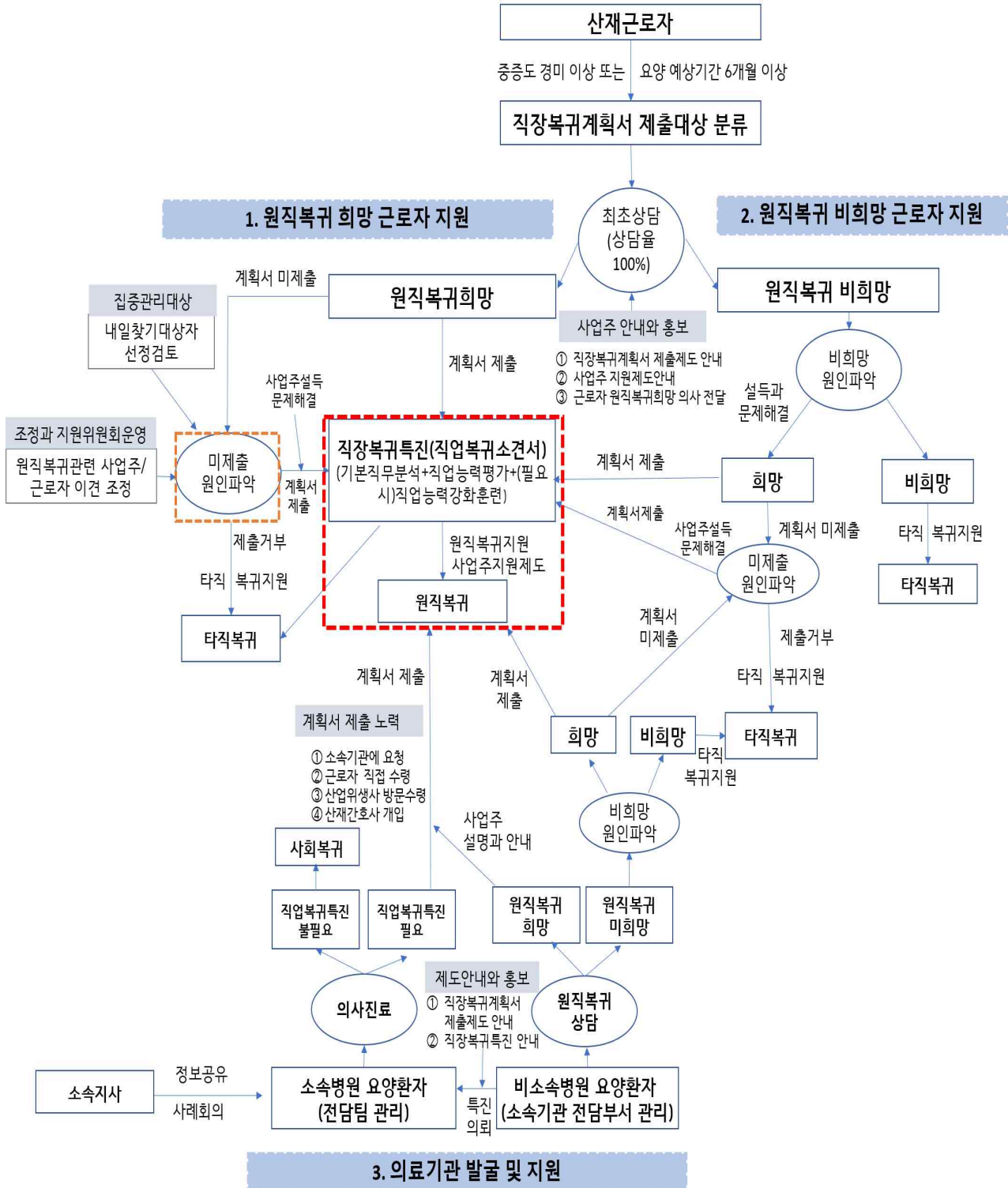
< 표 5-1 > 업무절차별 개선내용과 업무주체

구분	현행	개선내용	업무수행
요양초기 (요양 승인후 3개월 이내)	최초요양 승인 처리 완료	현행 유지	소속기관
	기본 대상 안내 문자DM 발송 ① (자동문자·DM 발송:사업주, 산재 근로자) ② (자동문자발송) 재활서비스 욕구조사	요양초기부터 직장복귀계획서 제출제도와 지원제도에 대한 적극적인 안내 → 사업주에게는 지원제도, 근로자에게는 직장복귀특진 등 안내	공단본부
	- 직장복귀계획서 제도안내 등을 위한 상담 - 근로자 최초상담(요양승인 후 21일 이내 가. 산재근로자 원직복귀 의사확인 나. 직장복귀계획서 제출제도 참여 동의 확인	- 원직복귀 희망 여부 산재근로자 전체 대상 확인(소속기관 담당자 또는 전담 부서 역할로 명시) - 원직복귀 미희망자에 대한 상담을 통한 및 원인과 문제해결 노력 ① 사업주와 이견시 공단조정자 역할 수행 ② 원직복귀지원을 위한 재활서비스 요구 시 연계지원	소속기관 (*전담조직 강화)

		③ 타직복귀 희망시 타직복귀지원	
최초상담	원직복귀를 희망한 산재근로자의 사업주 안내 DM : 원직복귀 의사 확인된 경우 발송	근로자 원직복귀 희망여부 상관없이 사업주 직장복귀계획서 제출 대상 전수 안내	공단본부
최초상담 이후 ~ 직업복귀 준비기 까지	사업주에게 직장복귀계획서 제출 요청 공문	- 계획서 제출요구에도 불구하고 미제출하는 경우 대면 및 비대면 안내 강화 - 근로자가 직장복귀계획서 제출을 요구할 수 있는 절차 운영 : 공단이 사업주 계획서 미제출 사유를 확인하고 조정 - 사업주와 근로자 원직복귀 이견시 공단 내 조정 및 지원위원회 운영 - 소속병원과 비소속병원 요양 산재근로자에 대한 차별화된 접근 ① 소속병원 요양환자의 직장복귀지원특진 이 필요한 의사진단이 있을 경우 산재간호사 중심(전담팀)으로 계획서 제출관리 ② 소속병원은 산재간호사(전담팀)를 중심으로 비소속병원 재활특진 등 방문환자에 대한 계획서 제출제도 및 직장복귀 지원특진 안내 강화 ③ 비소속병원은 소속기관 담당자(전담팀) 집중관리 : 근로자는 원직복귀를 희망하지만, 계획서 미제출자된 경우 계획서 제출 지속관리	소속기관 (전담조직 강화) *소속병원 (전담팀)) 추가
	접수처리 권한 : 원소속지사, 현소속지사	현행유지	
	사업주 직장복귀계획서 제출 및 직업복귀소견서 희망시 : 소속 산재근로자의 정보제공 동의 최종 확인	현행유지	
	사업주 대상 계획서 이행지원 : 지원내용 : 제출된 직장복귀계획서에 명시된 요청사항	타직복귀 희망자 타직복귀 재활서비스 제공 : 1:1밀착형 타직복귀 지원, 직장복귀소견서 신청 권한 부여	
	산재근로자 대상 재활상담진행 : 재활특진 등 재활상담/지원상담 진행	직장복귀계획서 제출여부와 직장복귀지원의 연계 운영 - 내일찾기 대상요건에 '직장복귀계획서 미제출' 요건 추가 (필요시 미제출한 경우만 대상자로 관리)	
직업복귀	산재근로자 대상 직장복귀지원 기	현행유지	소속병원

지원 기초상담	초 상담 : 의료재활 상담제공 : 산 재관리간호사		
직업복귀 준비기	직장복귀지원 특별진찰 의뢰 : 제 출된 직장복귀계획서에 직업복귀소 견서 요청시	직장복귀계획서에 소견서 ‘비희망’ 시 소속기관이 대면 또는 비대면 원인파악 후 필요한 조치	소속기관 (전담조직)
	- 직장복귀지원 특별진찰 진행(직업 복귀소견) : 기본직무분석 + 직업능 력평가 + (필요시 진행) 작업능력강 화훈련[전원필요] ★ (특진대상) 사업주가 직장복귀계획 서를 통해 직업복귀소견서 발급이 요청된 산재근로자로 제출된 직장 복귀계획서에 직업복귀소견서 ‘희 망’ 인 경우	- 직장복귀지원의료기관 민간의료기관 등 확대 - 직업환경의학과 작업환경개선 필요 확 인과 개선 노력	직 장 복 귀 지 원 의 료 기관
	직업복귀소견서 사업주, 근로자에 게 제공	직장복귀소견서 설명주체 명확화 : 1차 소속기관, 2차 소속병원 산재간호사	소속기관
직장복귀 자문회의 (필요시)	직장복귀계획서 전문가자문 : 계획 서 제출 이후 원직복귀 이행과정에 이견이 있는 사업주 또는 산재근로 자, 소속기관 자문 건을 취합, 지역 본부에서 월 1회 이상 회의	현행유지	지역본부
사후관리 (요양종결 후 6개월 까지)	직장복귀계획서 이행 관련 고용유지 모니터링 : 산재근로자 요양종결 이후 6개월 동안 2회(종결후 2~3 개월시점 1회, 종결 후 6개월 1회)	- 원직복귀근로자, 미복귀근로자 구분관리 ① 원직복귀근로자는 지속 고용여부 관리 ② 원직미복귀자는 원인파악 후 이견조정, 원직복귀불가시 타직복귀지원	소속기관

- 개선내용을 반영한 원직복귀 희망여부와 직장복귀계획서 제출여부에 따른 통합지원 체계
- 원직복귀 희망 근로자(계획서 제출 & 미제출), 원직복귀 비희망 근로자, 의료기관 발굴 및 지원(소속병원 & 비소속병원)으로 분류하여 다음과 같은 체계적인 접근이 필요함



[그림 5-1] 원직복귀 희망여부와 계획서 제출여부에 따른 통합관리 체계

2. 원직복귀희망자, 소속병원환자 중심 개선방안

□ 사업주 직장복귀계획서 제출제도 업무절차에 대한 개선방안

- 사업주 직장복귀계획서 제출제도 운영초기로 현재 인력과 조직, 업무수행 절차를 고려할 때 ① 원직복귀를 희망하는 산재근로자에 대한 지원과 ② 소속병원 요양환자에 대한 지원절차 개선과 내실화를 우선하여 추진하는 것이 필요함

○ 원직복귀희망 근로자 지원

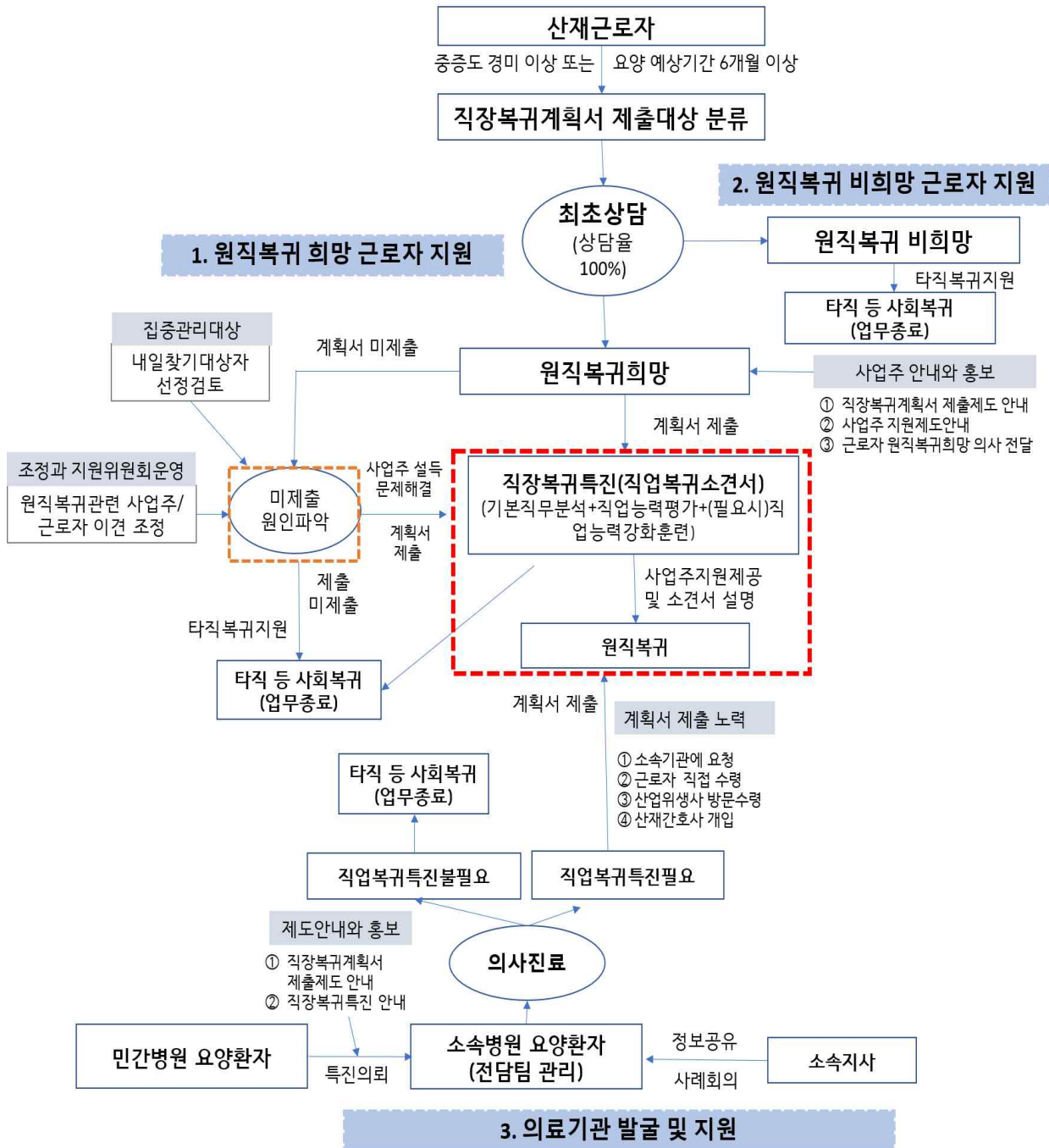
- － 직장복귀계획서 제출대상을 상대로 최초 상담을 전수 실시하여 산재근로자의 원직복귀 희망여부를 우선 확인함
- － 원직복귀를 희망하는 산재근로자에 대해서는 해당 사업주에게 ① 근로자의 원직복귀 희망의사를 전달하고, ② 직장복귀계획서 제출제도를 안내하며, ③ 사업주 지원제도를 안내함
- － 원직복귀 희망근로자 중에 사업주가 직장복귀계획서를 제출한 경우는 직장복귀특진을 진행하고 원직복귀를 위한 지원을 제공. 특히, 사업주 지원제도를 실행하여 근로자 복귀를 돕고, 사업주에게 직업복귀소견서에 대한 설명을 제공함
- － 근로자가 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서가 제출되지 않은 산재근로자는 집중관리대상으로 분류하여 계획서 제출과 원직복귀를 위해 지속적으로 노력함. 특히, 내일찾기 대상자로 선정하여 집중 지원하는 것을 검토하고, 직장복귀계획서가 제출되지 않은 원인을 파악하여 해결하기 위한 노력을 수행함
- － 사업주와 산재근로자 직장복귀에 대한 이견이 지속될 경우 공단은 조정과 지원을 위한 위원회를 운영함
- － 이러한 노력에도 불구하고 산재근로자가 원직복귀를 희망하지만 직장복귀계획서를 제출하지 않고, 원직복귀를 거부하는 경우 타직복귀 또는 사회복귀를 지원함

○ 의료기관 발굴 및 지원(소속병원)

- － 소속병원도 직장복귀계획서 발굴, 지원을 적극적으로 수행하고 있어서 소속병원이 계획서 제출제도에 있어서 적극적으로 역할을 수행할 수 있도록 유도
- － 소속병원 요양환자를 대상으로 의사진료를 통하여 직장복귀특진이 필요한 환자와 불필요한 환자를 분류함
- － 직장복귀특진이 필요하다고 의사가 진단한 경우 소속지사 담당자와 연계하여 직장복귀계획서를 제출하고 직장복귀특진을 받은 수 있도록 함으로써 산재근로자가 원직에 복귀할 수 있도록 지원함. 이를 위하여 소속지사 담당자와 병원 담당자간 정보공유와 사례회의 운영을 통해 협조체계를 구축함
- － 소속병원에서도 직업복귀특진이 필요하다고 의사가 진단한 경우 소속기관에 요청, 근

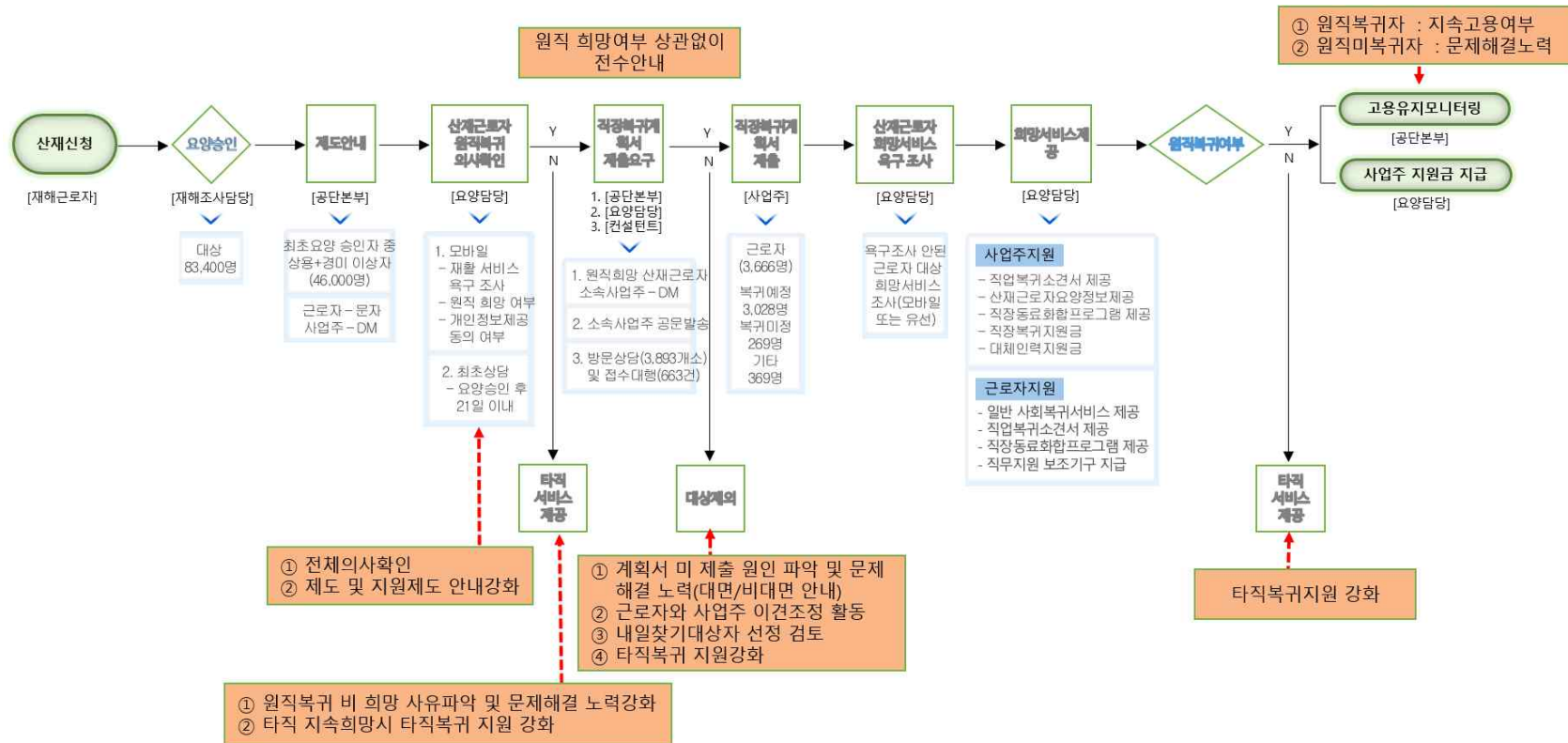
로자 직접수령, 산업위생사와 산재간호사의 직장복귀계획서 제출을 위한 사업주 설득 등 적극적으로 노력하도록 함

- 민간병원 환자의 특진 등 방문시 직장복귀계획서 제출제도 안내 및 직장복귀특진 안내를 통하여 계획서 제출제도 활성화를 추진함



[그림 5-2] 원직복귀 희망근로자 지원 및 의료기관 지원체계

□ 제안한 개선내용을 중심으로 공단의 직장복귀계획서 제출제도 운영절차 개선안을 제시하면 다음과 같음



[그림 5-3] 직장복귀계획서 제출제도 운영절차 개선(안)

[illegible]

- 94 -

업무절차 개선을 위한 과제

제3절

- 산재근로자별 계획서 제출과 원직복귀 희망여부에 따른 직장복귀계획서 제출과 원직복귀 지원 관련 철저한 과정관리를 실시함
 - 원직복귀희망 여부를 고려하여 산재근로자별 직장복귀계획서 운영절차에 따라서 철저히 관리함으로써 제출제도 효과성을 제고함
- 직장복귀계획서 제출 및 원직복귀 과정관리를 위한 전담조직 설치 및 인력을 배치함
 - 산재근로자에 대한 과정관리를 통한 계획서 제출 활성화와 직업복귀율 향상을 위하여 전담조직과 전담인력 활동을 강화하는 것이 무엇보다도 중요함
- 직장복귀계획서 제출과 원직복귀를 위한 공단-노동자-사용자간 협의 및 조정과정과 기구를 마련하고 운영함
 - 현재는 원직복귀와 관련하여 사업주와 근로자간 이견이 존재함에도 불구하고 이를 해결하기 위한 노력과 조정기구가 부재한 상황임. 이를 적극적으로 해결하기 위한 공단, 사업주, 근로자간 협력모델로의 전환이 필요함
 - 직장복귀계획서 미제출 사업주, 원직복귀 미희망 근로자 등 사업주 직장복귀계획서 제출제도에 순응하지 못하는 경우 이를 조정하고 협력하는 등 문제해결 노력을 강화해야 함
- 직장복귀계획서 제출제도와 사회복귀서비스의 연계를 강화해야 함
 - 기존 사회복귀 프로그램과 연계강화를 통하여 원직복귀율 향상 효과 극대화. 특히, 내일찾기서비스를 활용하여 계획서를 제출하지 않는 등 근로자가 원직복귀를 희망함에 불구하고 장애요인이 많은 근로자의 어려움 해결을 위해 노력해야 함
- 사업주 대상 직장복귀계획서 제출제도에 대한 홍보를 강화하고 인식제고를 위해 노력해야 함
 - 직장복귀계획서 제출 활성화를 통한 원직복귀강화를 위해서는 사업주 인식전환이 가장 중요함에도 불구하고 홍보부족 문제가 지속적으로 제기되고 있음. 산재발생

초기부터 직장복귀계획서 제출제도와 사업주 지원제도에 대한 적극적인 홍보를 통하여 사업주 인식전환과 협조를 유도해 나아가야함

- 직장복귀지원 의료기관 확대를 통한 산재근로자 접근성 향상이 필요함
 - 직장복귀가 원활히 이루어지기 위해서는 작업능력개선을 위한 훈련과 직장복귀가능성을 확인해주는 직업복귀소견서 제공이 매우 중요함에도 불구하고 이를 수행하는 지원 의료기관이 소속병원 11개로 제한적으로 운영되고 있음
 - 민간의료기관으로 직장복귀지원 의료기관을 확대하여 직장복귀를 지원하기 위한 의료기관과 의료인력의 적극적인 역할을 유도해야 함
 - 직업복귀소견서에 대한 제공과 설명 노력이 미흡한 상황으로 이를 개선하기 위하여 소속기관 담당자와 의료기관의 설명 기능 강화가 필요함. 또한, 산재근로자 요양정보 등을 사업주에게 지속적으로 제공하여 사업주가 원직복귀의 근거로 활용하고 이에 맞추어 복귀계획을 수립할 수 있도록 지원해야 함

<표 5-2> 계획서 제출 활성화를 위한 과제

영역	현황과 문제분석	개선방향
과정관리와 전담조직 부재	- 과정관리 부재 : 계획서 제출에 집중하고 수시 정보제공, 직장복귀 지원, 컨설팅, 맞춤형 사업주 지원 등 서비스 연계 부재 - 이중요양비 등 민원처리 업무 중심 재활보상부 운영	원직장복귀를 위한 과정관리 수행 : 계획서 제출과 함께 필요한 서비스 지원 관리
효율적 운영을 위한 연계·조정 미흡	- 소속기관과 소속병원 정보연계 미흡과 업무역할 모호성 존재 - 소속기관의 사업주와 근로자 간 의견 불일치에 대한 협의 및 조정기능 부재 - 내일찾기 서비스 등 사회복지 서비스와 효과적 연계체계 부재	- 재활계획서 업무와 과정관리를 위해서는 전담조직 운영 필요(소속기관과 소속병원에 모두 조직 필요) - 소속병원 정보와 소속기관 재해자와 사업장 정보연계로 집중재활치료, 작업능력강화훈련 효과적 진행 - 소속병원 정보제공으로 원직복귀 비희망자를 희망자로 전환하기 위한 노력 - 소속기관 전담조직을 중심으로 의견조정과 지원을 위한 조정지원위원회 운영을 통해 계획서 제출과 원직복귀 유도 - 직장복귀계획서 미제출 사업장 근로자를 내일찾기 대상자로 우선 지정하는 등 기존 사회복지서비스와의 연계 강화
운영절차와 제도 문제	- 홍보부족과 낮은 사업주 인식 - 사업주에 대한 정보제공 미흡 - 직장복귀지원 의료기관 소수로 접근성 제한 - 협소한 제출대상과 제출제도 강제수단 부재	- 산재근로자 초기상담을 100%진행하고 원직복귀 희망유무 확인 및 직장복귀계획서 제출제도 안내 - 산재발생초기 직장복귀계획서 제출제도 홍보강화를 통한 사업주 인지강화 - 직장복귀계획서 제출 안내에도 불구하고 미제출 사업장에 대한 대면 또는 비대면 안내 지속 - 산재근로자 요양정보 및 직장복귀소견서 등에 대한 정보제공 강화 - 사업주 지원제도에 대한 안내 - 직장복귀지원 의료기관을 재활인증병원 등 민간병원으로 확대 추진 - 장비·인력 등 지원기관 기준을 개선하고 소속병원과 연계해서 직장복귀지원 가능한 구조 마련 - 중장기적으로 사업주 직장복귀계획서 제출제도 의무화 및 과태료 부과 등 실효성 강화 노력

제 6 장

직장복귀지원 의료기관 운영현황과 개편방안



직장복지지원 의료기관 운영현황 및 문제점

제1절

1. 직장복지지원 직업재활프로그램 개요

□ 직장복지지원 대상

- 산업재해보상보험법 제75조의2(직장복지지원)에 의거하여 업무상 재해를 입은 근로자에게 장기간 요양이 필요하거나 요양 종결 후 장애가 발생할 것이 예상되는 등 대통령령으로 정하는 기준
- 시행령 제71조의2(직장복지 지원) 1항에 의거하여 업무상 재해로 인한 부상 또는 질병으로 6개월 이상 요양이 필요한 경우 혹은 제1급부터 제14급까지의 장애등급에 해당하는 장애가 발생할 것이 예상되는 경우 등임

□ 직장복지지원 의료기관 직업재활프로그램 운영 수가 현황

- 2023년 기준으로 12개 항목의 수가 운영
- 2022년 직장복지 지원을 위한 진료수가 6개 항목이 신설되었음

구분	직장복지지원 의료기관 산정기준(12개)			
	청구코드	한글명칭	수가(원)	비고
기본진료료 (7개)	VR0101	기본 직무분석	44,550	
	VR0102	재활보조기구 교육·상담료	45,180	2022년 신규
	VR0103	작업환경 평가	150,370	2022년 신규
	VR0104	작업환경 개선 현장 지도료	59,330	2022년 신규
	VR0105	사업장 방문료 50km 이내	57,330	2022년 신규
	VR0106	사업장 방문료 50km 초과1km 당	740	2022년 신규
	VR0107	집중 상담(1일당)	45,180	2022년 신규
검사료 (2개)	VR0201	직업능력평가	460,000	
	—VR0202	기초 심리검사	38,970	2022년 신규
이학요법료 (2개)	VR0301	신체기능향상 훈련(30분)	29,280	
	VR0302	모의작업 훈련(30분)	29,280	
기타(1개)	VR0401	직업복지소견서	100,000	

□ 직장복귀를 위한 직무분석 및 평가의 주요 내용

- 기본직무분석, 작업환경평가, 작업환경 개선 현장 지도료, 직업능력 평가, 직업복귀소견서가 있음

항목	실시자	내용
기본직무 분석	직업환경의학과 전문의(전공의), 재활의학과 전문의(전공의), 물리치료사, 작업치료사, 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	- 산재환자(근로자)나 사업주, 관계자와의 상담 등을 실시한 경우 상담내용을 바탕으로 직무를 기술한다. - 현장을 방문하여 직무특성 파악이 필요한 경우 사업장 방문조사를 시행한다. - 원직장복귀 지원 필요 여부 등 종합 분석결과를 기록한다. ※ 필요한 경우 직무분석 조사표를 작성·첨부한다.
작업환경 평가	직업환경의학과 전문의(전공의), 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	- 산재환자의 원 직무 또는 작업 전환이 필요한 경우 전환 직무를 분석한다. - 직무명 및 직무 해설: 원직무, 전환가능 직무, 기타 직무 등 - 직무내용: 작업공정 및 근무형태, 직무관련 특이사항 등(필요시 사진 첨부) - 직무관련 신체요구도: 직무수행과 관련해서 요구되는 작업빈도, 작업요구 무게, 작업 소요시간 등(필요시 사진 첨부) - 직무특성: 안전, 작업환경, 온도, 소음, 진동, 운전 등 직업복귀시 고려해야 할 정보 제공 ※ 직무 및 작업별 복수 시트 작성 가능 - 분석대상 직무, 사업주에 의한 취업상 배려, 인사노무 관리상 대응, 동료 의견, 복귀를 위한 치료목표 설정시 고려사항, 종합 의견 등 종합분석 결과를 작성(별지 제5호 서식) 비치 한다
작업환경 개선 현장 지도료	직업환경의학과 전문의(전공의), 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	작업조건 개선 내용은 대상자에 대하여 다음의 사항과 관련하여 필요한 사항이 있는 경우에 지도를 실시한다. 가. 작업관리 - 작업자 중심의 작업 설계 - 작업자를 고려한 작업 배분적 요소 등 나. 작업환경관리 - 취급부품, 작업물 배치 - 부적절한 작업자세 - 부적합한 작업공간, 공구 및 장비 청소, 유지 보수 - 부적절한 작업대 - 과도한 중량물 취급 - 불편한 작업도구 - 반복성 - 접촉스트레스 - 진동 등
직업능력 평가	직업환경의학과 전문의(전공의), 재활의학과 전문의(전공의), 작업치료사	- 본인이 느끼는 통증 형태를 기호를 사용하여 평가한다. - 손상부위 및 전반적 신체기능을 평가한다. · (손상부위 신체기능) 관절가동범위, 근력, 수부 악력, 손동작, 수부 기민성 평가 등을 별도 검사 · (전반적 신체기능) 민첩성, 평형성, 유연성, 지구력 평가

		※ 유연성 평가는 상병상태에 따라 앞으로 숙이기와 능동적 하지 직거상 평가를 선택하여 시행 - 직무수행 능력을 평가한다. · (모의작업 동작 평가) 물건 들어올리기, 제자리에서 밀기/당기기, 카트 밀기/당기기, 두 손으로 물건 옮기기, 한 손으로 물건 옮기기, 어깨에 물건 올려 옮기기, 등 뒤로 물건 옮기기 등 · (작업 자세) 앉기, 서기, 눕기, 앞으로 손 뻗기, 어깨위로 손 뻗기, 무릎 꿇기, 웅크리기, 허리 회전하여 작업, 어깨 숙이기, 쳐다보기, 쪼그리고 앉기, 한발로 균형잡기 등 · (작업장 이동) 걷기, 기어오르기, 기기, 계단 오르기 등 - 직업복귀 준비도를 평가하고 서식을 작성·비치한다.
직업복귀 소견서	직업환경의학과 전문의(전공의), 재활의학과 전문의(전공의),	- 직무분석 및 직업능력 평가 결과를 반영하여 직업복귀 소견 - 서로 다른 전문과목 전문의가 협의진료를 통해 소견서를 작성한 경우에는 전문과목별로 수수료를 각각 산정 할 수 있다.

□ 2022년 사업주 직업복귀계획서 제출에 따른 직장복귀지원 특별진찰 요양급여 지급 현황 분석결과 총 7,017,287천원이었음

○ 직업복귀소견서의 경우 1,129건에 총 116,825천원이 지급되어 건 당 103천원이 지급되었음

- 직업복귀소견서 건 당 수가가 100천원으로 서로 다른 전문과목인 재활의학과와 직업환경의학과가 협의진료를 통해 소견서를 작성한 경우에는 전문과목별로 수수료를 각각 산정할 수 있으나, 2022년 건 당 103천원으로 협의 진료가 거의 이루어지지 않음을 고려할 수 있음

(단위 : 건, 천원)

구분	항목	수가코드	건수	요양급여
직장복귀지원요양급여	기본직무분석	91520(기존), VR0101(신규)	1,242	58,113
	직업능력평가	91169(기존), VR0201(신규)	1,764	811,490
	작업능력강화	91215, 91216(기존), VR0301, VR0302(신규)	201,277	5,999,008
	직업복귀소견서	91802(기존), VR0401(신규)	1,129	116,825
	기타	VR0102-0107, VR0202(신규)	5,270	31,850
합계			210,682	7,017,287

2. 직업능력 평가

☐ 법 제75조의2제3항에 의거한 직업능력 평가

- 직업능력 평가에 대한 진단 및 직업능력 평가의 실시
- 직업능력 회복·강화를 위한 지원
- 재활치료에 대한 진단 및 신체기능 회복·강화를 위한 지원
- 의지(義肢) 또는 보조기의 처방, 제작·유지·보수를 위한 지원과 그 사용에 따른 적응력 향상 훈련 지원
- 장애 상태를 고려한 작업환경 개선 및 근로자의 직무 전환을 위한 지원
- 근로자의 심리적 안정 및 정신기능 회복과 가족, 직장동료와의 관계 회복 지원
- 그 밖에 근로자의 직장복귀를 위해 공단이 필요하다고 인정하는 조치
- 시행령 제71조의2(직장복귀 지원) 2항에 의거하여 7개로 정의하고 있음

☐ 직업능력 평가 수거

- 직장복귀 여부 판단 또는 직무수행을 위한 직업능력 평가가 필요한 산재근로자에 대하여 재활의학과 전문의(전공의) 또는 작업환경의학과 전문의(전공의) 처방에 따라 해당 의료기관에 상근하는 작업치료사가 실시한 경우 산정
- 직무수행 능력(모의작업 동작, 작업 자세 및 작업장 이동) 등에 대한 평가가 가능한 장비를 이용하여 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제2호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정
- 직업능력 강화 훈련 참여자는 전·후 평가를 실시할 수 있음

☐ 직업능력 평가는 재활의학과 전문의의 이학점 검사와 보유하고 있는 장비(EvalTech 등)를 활용하여 ‘신체기능, 직무적합성 등’을 평가함

- EvalTech 장비를 이용하여 신체 각부위의 근력 및 관절 가동범위, 자세(구부르기, 쪼그려 앉기, 무릎 꿇기 능력 등, 균형, 들어올리기, 물건내리기, 밀기/당기기/누르기, 운반하기, 팔뻗기(상, 하, 좌, 우), 손기능(키보드 활용 능력, 쥐기/손가락으로 잡기, 양손 동시 활용능력 등), 머리/목/허리기능 평가

3. 직장복귀지원 프로세스 중 직업재활프로그램 운영 과정

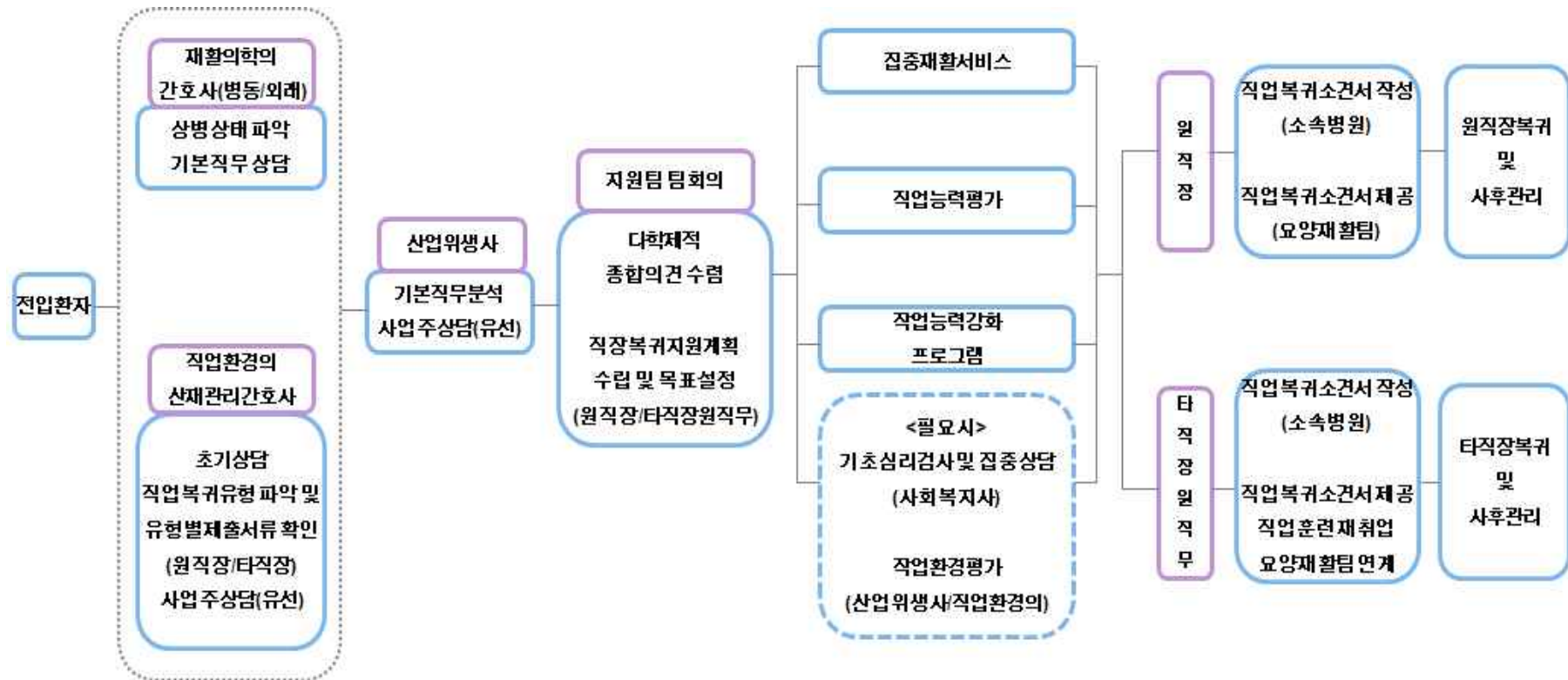
□ 대상자선정 후 직장복귀 지원계획 수립

- 원직장 복귀 지원 : 직업능력평가 및 강화프로그램, 작업환경평가 등
- 타직장 복귀 지원
- 직장복귀 및 사후관리

구분	주요 내용
1. 대상자 선정절차	① 상병상태 및 직업력 파악 (재활의학의) 상병상태 및 신체적 손상 정도 파악 등 (병동, 외래 간호사) 기본직무 상담 -> 추가상담 필요시 산재관리간호사 연계 ② 초기상담 및 대상자 선정 *직장복귀 지원 필요대상자일 경우 진료 후 즉시(당일) 직업환경의학과 진료접수 (직업환경의/산재관리간호사) 초기상담, 추가 직무정보 파악 후 대상자 선정 (사업주 상담) 산재관리간호사--유선 등으로 사업주에게 원직복귀 가능여부 및 장애요인 등 파악. 사업주와 갈등관계, 지원금 안내 등이 필요한 경우 요양재활팀에게 연계 산업위생사--보험가입자측의 의견 청취 및 재해자와 면담내용을 토대로 원직장-원직무, 원직장- 타직무 등 부서전환 및 요양종결 후 업무 조정 등에 대한 회사 측 의견청취 및 전달. (대상자 선정) 원직장/타직장 복귀 선정
2. 직장복귀 지원계획 수립 (전입 1개월 이내)	① 직장복귀지원팀 회의 (다학제적 접근) 선정 대상자에 대한 재활의학의· 직업환경의 등이 참여 (산업위생사) 기본직무분석 실시 후 팀회의 시 정보 제공 ② 지원계획 수립 (직업환경의) 전입 후 1개월 이내 ‘직장복귀 지원계획’ 수립 및 작성 ③ 원직장<->타직장 복귀 목표 변경 (목표변경) 목표가 변경되는 경우 즉시 직장복귀지원 계획 변경 후 서비스 제공 ④ 사업주 정보제공(원직복귀 대상 협조관계 유지) (주요내용) 산재노동자 상병상태 및 예상 치료기간, 지원 사항에 대한 정보 제공 (산재관리간호사) 유선 등으로 사업주에게 정보제공 (지사 요양재활팀)- 원직장 - 사업주 직장복귀계획서 제출 요청 타직장 원직무 - 직업복귀소견서 발급 신청서 안내 및 제출
3. 원직장 복귀 지원	① 전문재활서비스 (재활의학의) ‘재활종합계획’ 수립 후 집중재활프로그램 제공 맞춤형 스포츠 재활, 직무지원 보조기구 제공 ② 직업능력 평가 및 강화 프로그램 (작업능력평가) 대상자선정시 실시, 작업능력강화프로그램 중 중간평가 실시 가능 (작업능력 강화 프로그램) 재활의학의 및 직업환경의 협진 통해 프로그램 운영 신체기능 향상 훈련(재활의학의) + 모의 작업 훈련 (재활의학의) + 사업장 훈련지도 (직업환경의) ③ (재활의학의/직업환경의) 직업복귀소견서 작성

	(산재관리간호사) 지사요양재활팀에게 직업복귀소견서 회신 ④ 사업주 등 집중 지원 (소속병원) 정밀 직무분석, 직무지원 보조기구, 갈등해소 및 직무전환을 위한 사업주 상담, 소속기관 및 타기관 사업주 지원 안내 및 연계 (요양재활팀) 대체인력지원금, 직장복귀지원금, 직장적응훈련비, 직장동료화합프로그램 등 ⑤ 작업환경 평가(필요시) (직업환경의/산업위생사) 장해상태를 고려한 작업환경 개선 또는 직무전환 지도를 위한 현장평가가 필요한 경우 등 ⑥ 기초심리검사(필요시) (사회복지사) 심리적 어려움이 있는 경우
4. 타직장 복귀 지원	① 전문재활서비스 ② 직업능력 평가 및 강화 프로그램 ③(재활의학의/직업환경의) 직업복귀소견서 작성 (산재관리간호사) 지사요양재활팀에게 직업복귀소견서 회신 직업훈련 및 재취업지원 서비스 연계 안내 (직업환경의) 수행가능한 직업훈련 및 타직무 직종 범위에 대한 상담 ④ 타직장 타직무 (요양재활팀 연계) 산재관리간호사는 타직장복귀 위한 직업훈련 및 재취업 지원 희망자 연계
5. 직장복귀 및 사후관리 (직장복귀 후 3개월까지)	① 원직장복귀 사후관리 (직업환경의) 최소 2회(1개월 및 3개월 시점) 이상 유선 및 방문 상담 등 모니터링 통해 고용유지 및 직무전환 필요성 등 확인 (업무적합성 평가) 타직무 전환을 필요로 하는 경우 사업장 방문

□ 직장복귀지원 의료기관의 업무흐름



[그림 6-1] 소속병원 직장복귀지원 흐름

4. 직장복귀지원의 한계와 개선방향

□ 프로세스 용어의 정의 불명확함

- 직업능력평가는 직장복귀 여부 판단 또는 직무수행을 위한 직업능력 평가로 직무수행 능력 등에 대한 평가를 의미하고 있음
 - － 직업은 생계를 유지하기 위하여 자신의 적성과 능력에 따라 일정기간 동안 계속하여 종사하는 일을 의미함
 - － 작업은 일, 일정한 목적과 계획 아래 하는 일을 의미함
- 현 직업능력평가 항목이 신체기능 및 전반적 신체기능으로 악력, 민첩성, 평형성, 유연성, 지구력과 직무수행 능력평가, 작업 자세 및 작업장 이동 등을 평가함에 따라 작업 능력평가로 용어를 명확화 하는 것이 요구됨

□ 프로세스별 실시자 명확화 필요

- 직무분석과 직업복귀소견서 작성은 직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)가 실시자로 되어 있음
 - － 직무분석 및 직업복귀소견서 작성 주체가 주로 재활의학과 전문의(전공의)가 되고 있음
 - － 이는 작업환경에 대한 부분이 직무분석 및 직업복귀소견서 작성에 반영이 되지 않은 부분이 있음
 - － 따라서 직무분석 및 직업복귀소견서 작성시 실시자를 직업환경의학과 전문의(전공의)와 재활의학과 전문의(전공의)로 원직복귀 지원을 위해 작업능력과 작업환경을 동시에 고려될 수 있는 체계가 필요함
- 직업능력평가 실시는 직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)가 실시자로 되어 있음
 - － 직업능력평가 주체가 주로 재활의학과 전문의(전공의)가 되고 있음
 - － 이는 직업능력평가 내용이 근력, 지구력, 유연성, 평형성 등으로 재활의학과 전문의(전공의)의 전문 영역임
 - － 따라서 직업능력평가는 재활의학과 전문의(전공의)를 실시자로 제한하는 것이 필요로 됨

□ 직업능력평가 평가 방법의 다양화

- EvalTech 장비를 이용하여 평가하고, 평가 양식이 작업능력평가 2시간 측정과 이외 재활상담, 신체기능, 평가결과 분석 시간 2시간을 포함한 4시간이 소요되는 양식 1가지로 단일화 되어 있음
- 직업능력평가 항목이 근력, 지구력, 유연성, 평형성 등을 측정함에 따라, EvalTech 장비를 사용하지 않고, 측정가능한 도구를 이용한 측정으로 확대할 필요가 있음

- 현재 4시간 소요 평가양식에서 근로자의 손상 정도 및 작업에 따라 단축형으로 다양화하여 평가할 수 있는 양식이 필요로 됨

구분	실시자	현 프로세스 및 상황	개선사항
대상자 선정			
▼			
직무분석 (필요시 현장방문)	-직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의), -물리치료사, 작업 치료사, 산업 위생관리산업기 사, 인간공학기 사	(프로세스) (산업위생기사) 기본직무분석 실시 (현 상황) -재활의학과전문의(전공의)가 주로 직무분석을 실시함 -직업환경의학과(전공의)는 대 상자를 재활의학과에서 의뢰 해주지 않으면 알수 없는 상 황 -병원에 따라, 재활의학과와 직업환경의학과가 협력하거 나, 재활의학과에서만 이루어 지고 있음	-직장복귀 여부에 대한 직무 분석시 재활의학과와 기능 적 측면 뿐만 아니라, 직업 환경의학과(전공의) 작업환 경과 관련된 직무분석이 필수적으로 요구됨 -재활의학과와 직업환경의학 과 직무분석 필수로 변경
▼			
직업능력평가 (작업능력 강화 훈련 참여자는 전· 후 평가)	-직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공 의), 작업치료사	- 직업능력평가로 명명되어 있으나, 평가내용이 작업능 력 평가로 용어 변경 필요 -직업능력평가 항목이 재활의 학과전문의(전공의), 작업치료 사가 측정할수 있음 -따라서 직업환경의학과전문의 (전공의)는 실시하지 않음 -신체기능평가 항목 측정 부위 및 개수와 상관없이 단일수 가임(460,000원) -EvalTech 장비를 이용하여 평	- 실시자를 명확하게 재활의 학과 전문의(전공의)로 제 한하고 작업능력평가로 용 어를 명확히 하는 것이 필 요로 됨 -소속병원의 경우 직업환경의 학과보다는 재활의학과에서 대부분 실시하고 있음. 직업 능력평가 항목이 근력, 집중 력, 평형감 등으로 재활의학 과 전문의(전공의)로 제한하 는 것이 필요로 됨. 기관 확 대를 고려하여 역할분담을 명확히 하는 것이 필요함 -대상자에 따라 직업능력평가 항목 중 부분 측정만 필요로 됨 -단일수가를 다양화하여 대상 자의 직업특성에 따라 직업 능력평가 항목을 선택적으로 적용 -신체기능평가를 측정 행위에 따라 수가가 발생될 경우 행 위별 수가제로 심사의 복잡 함에 예상되어 현재 측정 도 구와 간단한 측정 양식을 고 려하여 수가를 별도 산정하 는 것이 요구됨 -장비를 사용하지 않고 측정

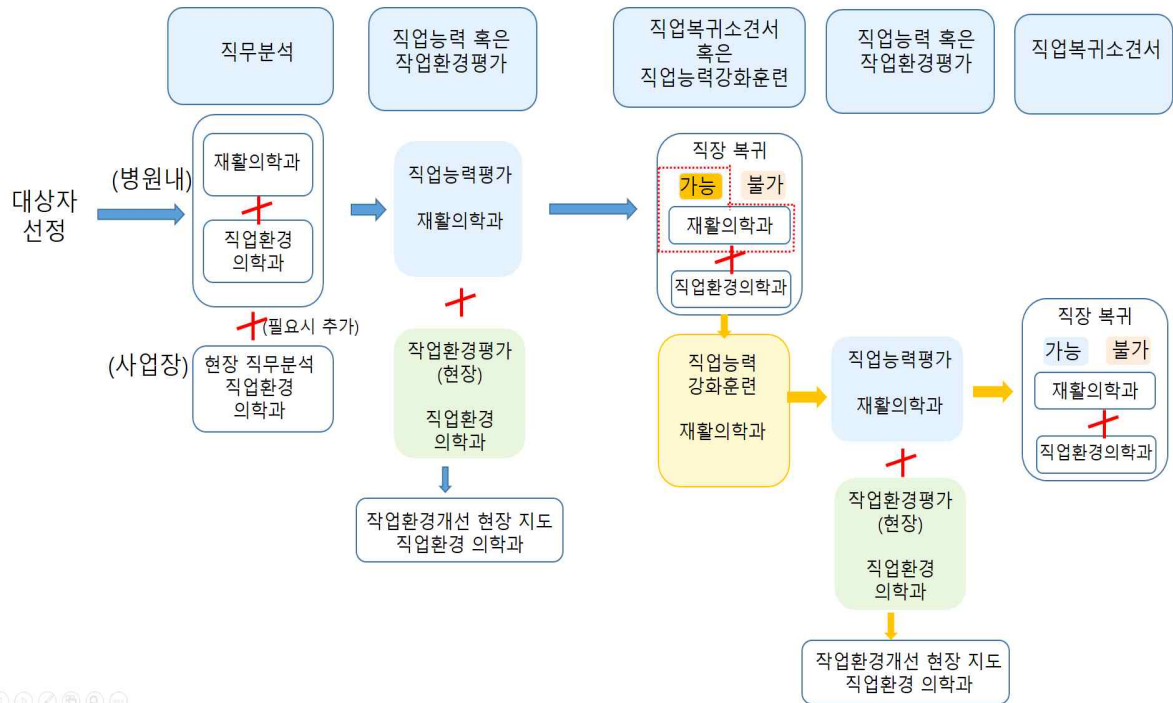
		가	하는 방법 -EvalTech 이외 동일한 기능이 있는 장비 사용
▼			
작업능력 강화 훈련	-재활의학과 전문의(전공의), 물리치료사, 작업치료사	-작업능력 강화 훈련은 12주 이내 실시	
▼			
직업능력평가 (사후 평가)			
▼			
작업환경평가 (최대2회)	-작업환경의학과 전문의(전공의), 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	(프로세스-필요시) (작업환경의/산업위생사) 장애 상태를 고려한 작업환경 개선 또는 직무전환 지도를 위한 현장평가가 필요한 경우 등	-작업환경뿐만 아니라 현장 작업능력과 작업환경 평가를 통해 업무적합성평가를 시행할 수 있는 도구 보완이 필요로 됨
		(현 상황) -재활의학과전문의(전공의) 의뢰시 작업환경의학과 전문의(전공의)가 처방하여 실시 -작업환경평가만 실시됨에 따라, 작업의 강도 및 빈도 등이 왜곡될 수 있어 정확도가 떨어질 수 있음	-작업환경평가자는 현재와 동일하게 유지 -필요시 작업환경평가지 의사 방문 실시
		-수가가 작업환경평가(150,000원), 사업장방문료, -현장 작업환경평가지 병원내 직업능력평가보다 전체적인 시간이 많이 소요됨 *직영병원 ‘정밀직무분석료’를 직장복귀지원 수가로 전환·신설됨	-작업환경평가 항목시 현장작업능력을 포함한 시간을 고려하여 수가 보완 필요
▼			
작업환경 개선 현장 지도	-작업환경의학과 전문의(전공의), 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	-항목이 단순화되어 있어 현장에 맞는 지도가 어려움	-작업환경개선현장지도 항목이 단순화되어 있어 실제적인 현장지도가 될 수 있도록 항목 보완이 필요로 됨
▼			
직업복귀소견서	-작업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)	-재활의학과전문의(전공의)가 주로 직업복귀소견서 작성 -협진의뢰시 작업환경의학과 전문의(전공의) 작성	-재활의학과전문의(전공의)가 의뢰할 경우 작업환경의학과전문의(전공의)가 협진이 실시됨에 따라, 재활의학과와 작업환경의학과 직업복귀소견서 필수

직업복귀지원 프로그램 운영 개선방안

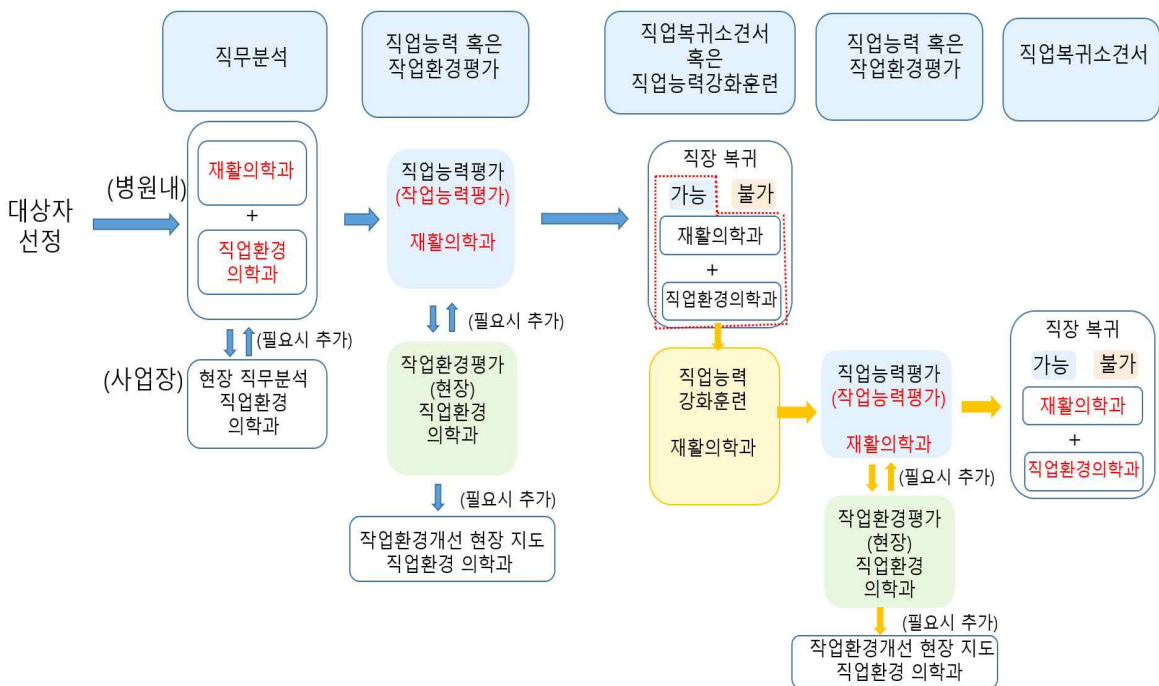
제2절

- 직장복귀지원 프로그램 흐름에서 제시한 실시자 불명확을 중심으로 실시자를 명확화하여 흐름을 제시함
- 직장복귀를 위한 작업능력 뿐만 아니라 작업환경, 현장 업무능력 등의 평가가 필요로 되어 이를 반영할 수 있는 실시자를 명확화함

구분	실시자		내용
	현재	수정(안)	
직무분석	-직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)	-재활의학과와 직업환경의학과 (두 직종 모두 실시, 작업 능력과 환경에 대한 분석)	-현재 재활의학과 주도로 시행되고 있어, 기능뿐만 아니라 작업환경에 따른 직무분석 필수적으로 필요함 -직무분석시 직업환경의학과에서 향후 작업환경평가(현장) 필요여부 기재 -직무분석 단계에서 제시된 작업환경평가가 필요여부에 따라, 작업환경평가 실시되도록 함 (직무분석의 경우 재활의학과 의뢰에 따라 직업환경의학과 시행하거나 하지 않음. 또한 작업환경평가도 재활의학과 의뢰에 따라 결정됨에 따라, 직무분석시 직업환경의학과와의 진단에 따라 실시되도록 직무분석 종합결과에 추가)
직업능력평가	-직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의) -작업치료사	-재활의학과 전문의(전공의) -작업치료사	-직업능력평가 내용을 고려하여 재활의학과 전문의(전공의)로 제한함
작업환경평가	-직업환경의학과 전문의(전공의), 산업위생관리산업기사, 인간공학기사	-현행 유지	-직무분석단계에서 직업환경의학과에서는 현장 작업환경평가를 의뢰할 수 있도록 함
직업복귀소견서	-직업환경의학과 전문의(전공의) 또는 재활의학과 전문의(전공의)	-재활의학과와 직업환경의학과 (두 직종 모두 실시, 작업 능력과 환경에 대한 직업복귀소견서 작성)	-재활의학과에서 의뢰하지 않은 경우 직업환경의학과와 작업환경에 대한 부분이 고려되지 않을 수 있음 -따라서 기능적 측면과 현장 작업을 고려한 재활의학과와 직업환경의학과에서 소견서 제출



[그림 6-1] 현재 업무 프로세스



[그림 6-2] 개선 업무 프로세스

직업능력 평가방법 및 도구 다양화

제3절

1. 직업능력 평가 장비

□ 직업능력평가 장비 종류

- BALTIMORE THERAPEUTIC EQUIPMENT : PrimusRS, Eval-Tech, Simulator II
- Ergokit
- Ergos Work Simulator
- Blankenship FCE
- WorkWell Systems

1) BALTIMORE THERAPEUTIC EQUIPMENT

(1) PrimusRS

- 평가와 치료에 적용
- 상/하지 측정 기능
- 1초당 4500도 각속도 측정기능(등장성)
- 기능적인 해부학 사진 내장 기능
- 터치 스크린과 이동, 고정이 가능한 전용의자
- 등장, 등속, 지속적 수동운동, 정적, 동적 작용 측정



평가 항목

1. 최대 근력(힘) 측정
(Lift Max Capacity Test)
(Isometric Test)
(Isokinetic Test)
2. 운동량(work) 측정
(Max Endurance Test)
(Max Lift repetitive Test)
3. 파워(power) 측정
(Max Power Test)
(Torque and Speed Test)

훈련 항목

1. 최대근력 향상 프로그램
(예, 최대 근력 80%로 근력 운동 시작)
2. 운동량 향상 프로그램
(예, 최대 근력 30%로 근지구력 훈련)
3. 운동시 파워 향상 프로그램
(최대 근력의 50%로 파워 훈련)

<https://www.btetechnologies.com/>



The BTE System



Updating the evidence on Functional Capacity Evaluation - Stijn De Baets

(2) Eval-Tech

- 근골격계 질환 관련 평가 및 치료 장비
- 작업시뮬레이션 가능



가동 범위 측정



구부리기



대각선 가동범위



무릎 꿇기



Lifting 능력



누르기 능력



들어올리기



한팔 Lifting



(3) Simulator II : Functional upper extremity rehab

- 기능평가 및 재활
- 상지 재활
- 심장 및 폐 재활
- 최대 및 반복 들기 테스트
- 노력 테스트
- 노인병 및 신경 재활



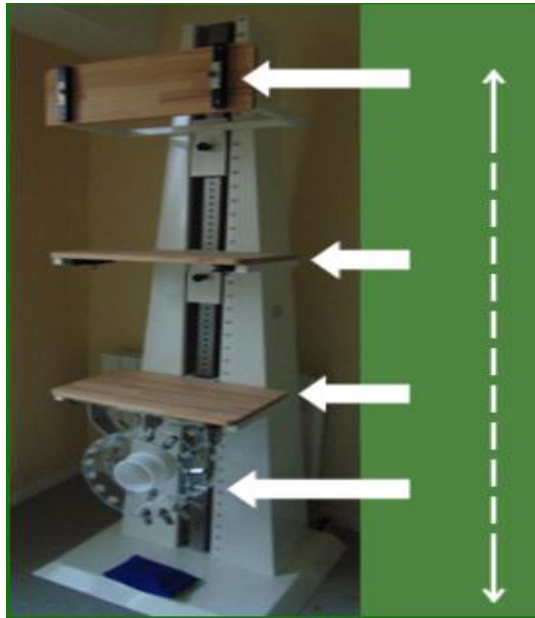


2) Ergokit

- 네덜란드 ‘Ergo control’ 에서 판매
- 작업능력평가로 검증된 도구임(Gouttebarga 등, 2005⁷⁾, Gouttebarga 등, 2006⁸⁾)
- 55개의 표준화된 물리적 측정 항목으로 구성됨
- 작업능력요구에 따른 작업자의 최대 용량, 손 지구력, 요구되는 자세 등을 측정함
- 앉기, 서기, 걷기, 오르기, 계단오르기, 구부리기, 무릎꿇기, 웅크리기, 칠하기, 높은곳으로 손빨기, 낮은 것으로 손빨기, 우세한 손 쥐기, 비우세한 손 쥐기, 우세한 손가락 작업, 비우세한 손가락 작업

7) Gouttebarga V, Wind H, Kuijer PP, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Intra- and interrater reliability of the Ergo-Kit functional capacity evaluation method in adults without musculoskeletal complaints. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:2354-2360.

8) Gouttebarga V, Wind H, Kuijer PP, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Reliability and agreement of 5 Ergo-Kit functional capacity evaluation lifting tests in subjects with low back pain. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1365-70.



상호 교환 및 높이조절이 가능



Fig. 1. Test of manual handling of loads.



상자



2.5kg, 5kg



균형 측정, 10cm, 20cm



악력 측정



누르는 힘 측정



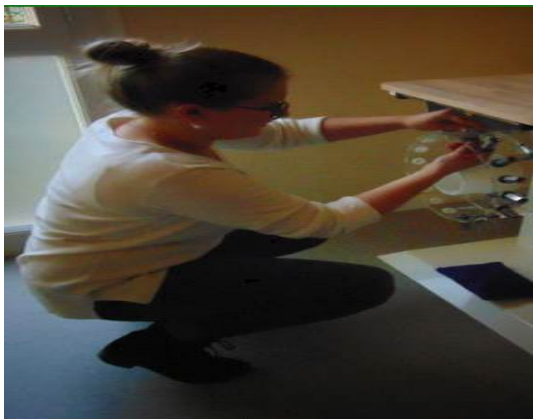
지구력: 한손이용



지구력 : 양손이용하여 손을 뺀어



지구력: 양손을 머리위로 올려



웅크린자세



무릎꿇는 자세



구부린 자세



앉은 자세



허리 위쪽으로 물건 옮기기



단층 물건 들기



변형된 물건 들기



당기는 힘



쥐는 힘



균형감

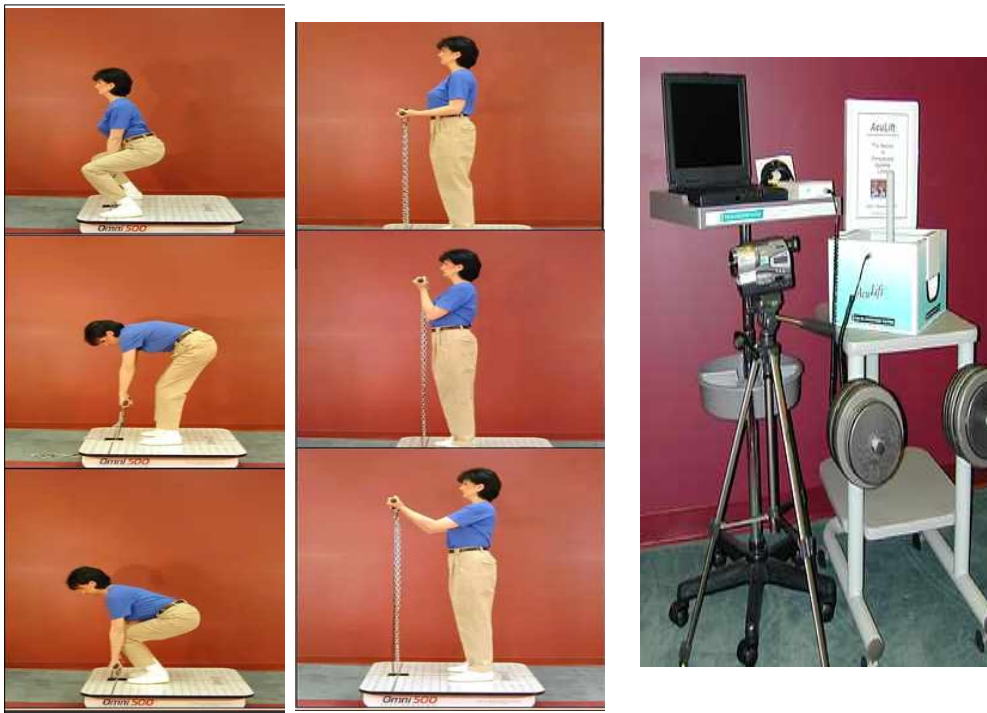
3) Ergos Work Simulator

- 네덜란드 ‘Ergo control’ 에서 판매
- 고도화된 작업 수행능력 평가
- 정확한 기능 능력 평가
- ERGOS 작업 시뮬레이터는 컴퓨터화된(Windows NT 운영 체제, USB 인터페이스, 터치 스크린 및 네트워크) 관련 테스트 구성 요소를 사용하여 작업 수행과 관련된 물리적 및 기능적 능력 측정
- 원격 마스터 스테이션 컴퓨터에 연결된 3대의 온라인 컴퓨터가 ERGOS 시스템 제어
- 세 개의 별도 테스트 장치로 구성된 전체 시스템은 다음과 같은 작업 수행 영역 측정
 - 정적 및 동적 근력: 밀기, 당기기, 들기 및 나르기, 일련의 반복적인 들기, 옮기기
 - 전신 가동 범위: 서기 및 걷기 허용 오차, 구부리기, 웅크리기, 무릎 꿇기, 머리 위로 뻗기, 앞으로 뻗기, 통합적 몸 회전 및 자재 취급 및 걷기 활동 통합
 - 앉은 작업 허용 오차: 상지 기능으로 손 뻗기, 조작하기, 손가락 움직임, 움직임 범위, 손목 굴곡, 신전, 손 악력, 손가락 굴곡, 손목 회진/외전



4) Blankenship FCE

- Quest Medical Group은 Blankenship 브랜드를 소유하고 있으며 Blankenship FCE를 완료하는 데 필요한 모든 소프트웨어와 하드웨어를 제공
- Blankenship FCE 시스템은 1980년대에 개발됨
- AMA, 2009, Guides to the Evaluation of Functional ability에서 인증을 받음
- AcuLift는 전산화된 센서와 동기화된 비디오를 활용하여 실제 물리적 과부하, 통증 또는 리프팅에 대한 두려움이 자재 취급에 영향을 미치기 시작하는 시기를 정확하게 식별을 전산화함
- 들기(리프트) 스테이션에 물리적으로 연결되지 않은 유일한 컴퓨터 들기(리프팅) 도구로, 들기(리프팅) 역학을 평가할 수 있음



다리, 몸통, 바닥 들기

팔 들기, 가까이 높이 들기, 멀리 높이 들기

장비	내용	가격	
		달러	한화(1,340원)
Myorom	악력, 척추 기울기 측정, 정적 강도 등	\$ 10,300	13,802,000
System Interface	심박수, 악력, 정적 강도, 디지털 근력 매칭, 근력 측정	\$ 13,200	17,688,000
AcuLift	실시간 비디오로 들기의 시간, 힘 곡선 제공, 근골격계 과부하가 시작되는 시기, 노력, 통증,	\$ 14,700	19,698,000

	두려움/불안 등 파악		
Premier System	정적 측정, 밀고 당기기, 들기 등	\$ 39,800	53,332,000
대형 들기 장소		\$ 3,950	5,293,000
들기 장소		\$ 2,850	3,819,000
들기 박스 세트		\$ 680	911,200
작업상자		\$ 228	305,520
머리 위 들기 박스		\$ 245	328,300
밀기/당기기		\$ 875	1,172,500
			116,349,520

5) WorkWell Systems

- 이전 Isernhagen Work Systems (IWS)로 알려짐
- 현재 독일 재활센터에서 가장 일반적으로 사용되는 FCE 도구 임
- 들기, 올라가서 들기, 옮기기 등



2. 직업능력 평가시 작업 시뮬레이션 및 직업능력 평가

☐ 직업 시뮬레이터를 포함한 직업능력 평가 장비

- ☐ BALTIMORE THERAPEUTIC EQUIPMENT : PrimusRS, Eval-Tech, Simulator II
- ☐ Ergos Work Simulator

☐ 직업 시뮬레이터를 포함하지 않은 직업능력 평가 장비

- ☐ Ergokit
- ☐ Blankenship FCE
- ☐ WorkWell Systems

☐ 직업 시뮬레이터를 포함하지 않은 직업능력 평가 장비의 신뢰성 및 타당성

- ☐ WorkWell Systems의 경우 체계적 문헌고찰을 통해 중량 취급 및 근력 측정은 신뢰성이 높은 것으로 나타남⁹⁾
 - 중량 취급 및 근력 : 낮은 위치에서 들기, 높이 들기, 짧은 거리 옮기기, 긴 거리 옮기기, 긴 거리 옮기기(오른손, 왼손), 정적으로 밀기, 정적으로 당기기, 역동적으로 밀기, 역동적으로 당기기, 오른쪽 악력, 왼쪽 악력)
 - 자세 및 이동 : 머리위로 작업, 서서 앞으로 구부리기, 앉아서 앞으로 구부리기, 무릎 꿇기, 칠하기, 웅크리기, 역동적 스쿼트, 좌/우 서서 반복 회전, 좌/우 안장서 반복 회전, 앉은 자세, 서서 버티기
 - 운동 : 걷기, 계단오르기, 사다리 오르기
 - 균형 : 균형
 - 손 협응 : 오른손 협응, 왼손 협응
- ☐ Ergokit는 근골격계 질환 혹은 다른 질환을 가지고 있는 환자를 대상으로 작업 능력 평가를 위해 중량 취급, 몸으로부터 팔의 자세, 반복 작업을 평가한 결과 직업능력 평가를 다차원에서 실시할 수 있는 도구로 신뢰성이 높게 나타남¹⁰⁾
 - 직업 복귀를 지원하는데 매우 유용함
 - Ergokit와 Ergos Work Simulator의 역동적 하부와 상부 들기를 비교한 결과 Ergos Work Simulator보다 Ergokit가 역동적 하부와 상부를 측정하는데 신뢰성이 더 높게 나타남¹¹⁾

9) Bieniek & Bethge. The reliability of WorkWell Systems Functional Capacity Evaluation: a systematic review BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:106

10) Caron 등(2015). Interest of the Ergo-Kit1 for the clinical practice of the occupational physician. A study of 149 patients recruited in a rehabilitation program. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 58, 289-297

11) Rustenburg 등(2004). The concurrent validity of the ERGOS Work Simulator and the Ergo-Kit with

- Blankenship FCE는 Guides to the Evaluation of Functional ability(AMA, 2009)로 측정되고 있음

- 소프트웨어를 통해 센서와 비디오로 기능 측정에 도움을 주고 있음

□ 직업능력평가 장비 다양화

- 현재 Eval-Tech(BALTIMORE THERAPEUTIC EQUIPMENT) 장비만 적용하고 있으나, 향후 다양하게 PrimusRS, Simulator II, Ergos Work Simulator를 추가하여 작업시뮬레이터를 적용하여 직업능력평가를 다양화할 수 있음
- 또한 현재 Eval-Tech(BALTIMORE THERAPEUTIC EQUIPMENT) 장비를 반드시 적용하는 것으로 규정하고 있으나, 작업 시뮬레이터를 포함하지 않은 Ergokit, Blankenship FCE, WorkWell Systems을 이용하여 직업능력평가를 실시할 수 있음
- 궁극적으로 산재 근로자의 손상 정도에 따라 직업능력평가가 실시될 수 있도록 작업 시뮬레이터뿐만 아니라 기구를 통한 직업능력평가 만으로도 측정할 수 있도록 평가 장비의 범위를 넓게 다양하게 실시하는 것이 필요로 됨

respect to maximum lifting capacity. Journal of Occupational Rehabilitation, 14(2), 107-118.

3. 직업능력 평가 방법 다양화

□ 현재 직업능력 평가 항목

- 재활의학과 전문의(전공의) 처방으로 작업치료사가 장비(EvalTech 등)를 활용하여 전반적 신체기능 1) 민첩성평가(사이드 스텝), 2) 평형성 평가(눈감고 외발서기), 3) 유연성 평가(앞으로 숙이기, 능동적 하지 직거상, 지구력평가(최대하 계단오르내리기), 모의작업 동작평가 1) 물건 들어올리기, 2) 제자리에서 밀기/당기기, 3) 카트 밀기/당기기, 4) 두 손으로 물건 옮기기, 5) 한 손으로 물건 옮기기, 6) 어깨에 물건 올려 옮기기, 7) 등 뒤로 물건 옮기기, 작업자세 및 작업장 이동(앉기, 서기, 눕기, 앞으로 손 뻗기, 어깨위로 손 뻗기, 무릎 꿇기, 웅크리기, 허리 회전하여 작업, 어깨 숙이기, 쳐다보기, 쪼그리고 앉기, 한발로 균형잡기) 측정을 하고 있음

□ 현재 직업능력 평가 소요 시간

- 2013년 산재보험 재활수가 효과성 분석 및 활용방안 연구에서 직업능력평가 소요시간을 4시간으로 산정하였으며, 세부적으로 작업능력평가 2시간, 이외 재활상담 및 신체기능 평가, 보고 등 2시간으로 총 4시간을 소요시간으로 산정함
- 직업능력평가 항목을 산재 근로자의 손상 정도에 따라 필요한 항목만 측정할 수 있도록 2018년 1월~2020년 12월까지 근로복지공단 소속 인천, 안산, 창원, 대구, 순천, 대전, 동해 등 7개 병원에서 직업능력평가를 실시한 산재환자를 대상으로 측정한 항목의 빈도를 반영 단축형을 제안함
- 작업능력평가 2시간의 평가를 단축형은 상하지 손상 환자를 고려하여 현재 2시간에서 1시간으로 단축할 수 있는 항목과 상지 혹은 하지 손상 환자를 고려한 30분으로 제안함

□ 직업능력 평가 항목 단축형

- 직업능력 평가는 5개 영역 기본정보, 통증, 신체기능평가, 직무수행 능력평가, 직업복귀 준비도를 평가함

영역	항목	내용	세부내용
1. 기본 정보			
2. 통증			
3. 신체기능 평가	가. 손상부위 신체기능 (별도검사)		
	나. 전반적 신체기능	1) 민첩성 평가: 사이드 스텝	
		2) 평형성 평가: 눈감고 외발서기	
		3) 유연성 평가(상병상태에 따라 선택 평가)	가) 앞으로 숙이기 나) 능동적 하지 직거상

		4) 지구력 평가: 최대하 계단오르 내리기*	
4. 직무수행 능력 평가	가. 모의작업 동작 평가	1) 물건 들어올리기	
		2) 제자리에서 밀기/당기기	
		3) 카트 밀기/당기기	
		4) 두 손으로 물건 옮기기	
		5) 한 손으로 물건 옮기기	
		6) 어깨에 물건 올려 옮기기	
		7) 등 뒤로 물건 옮기기	
	나. 작업 자세 및 작업장 이동	앉기	
		서기	
		눕기	
		앞으로 손 뻗기	
		어깨위로 손 뻗기	
		무릎 꿇기	
		웅크리기	
		허리 회전하여 작업	
		어깨 숙이기	
		쳐다보기(아래→위)	
		쳐다보기(위→아래)	
		쪼그리고 앉기	
		한발로 균형잡기	
		작업	
		걸기	
		기어오르기(사다리 이용하기)	
		기기(기어가기)	
		계단 오르기	
5. 직업복귀 준비도			

- 노동희 등(2021)이 산재환자의 업종별 직업능력평가 세부항목 분석을 한국표준산업분류를 중심으로 분석한 결과를 고려함
- 2018년 1월~2020년 12월까지 근로복지공단 소속 인천, 안산, 창원, 대구, 순천, 대전, 동해 등 7개 병원에서 직업능력평가를 실시한 산재환자를 대상으로 함
 - 산재환자의 업종별 직업능력평가 세부항목 수행 빈도를 분석하기 위해 전자의무기록을 이용함
 - 직업능력평가 주요 장비로 EVAL-TECH(BTE, Inc. Hanover, MD) 사용
 - 직업능력평가 세부항목은 미국 노동부에서 발행한 Dictionary of Occupational Titles (D.O.T)에서 정의된 내용을 바탕으로 근력(들기, 옮기기, 밀기·당기기), 자세유지평가(서서 앞으로 손 뻗기, 어깨 위로 손 뻗기, 허리 구부리기, 무릎 꿇기, 쪼그려 앉기, 앉은 자세 유지, 사다리 작업), 작업장 이동(걸기, 계단 오르기, 기어가기, 사다리 오르기)으로 구성(U. S. Department of Labor, 2021). 기타 평가로 대상자의 진단명 또는 손상부위에 따라 수부근력평가, 관절가동범위, 등척성 평가, 수부기능평가, 인지 및

시지각 평가 포함

- 분석대상자는 총 2,145명이었으며, 제조업 692명, 건설업 642명, 전문·기술업 308명, 시설 관리 및 서비스업 263명, 운송업 169명, 보건업 및 사회복지서비스업 71명이었음
- 분석결과 직업능력평가 5개 항목 중 직무수행 능력 평가 모의작업 동작평가, 작업 자세 및 작업장 이동 평가시 최소 1%에서 최대 86.2% 측정되고 있었음
- 이는 직무수행 능력 평가 항목 중 상병상태 및 원직복귀 업무에 따라 특성을 반영하여 현장에서 측정하고 있었음
- 직무수행능력 평가를 노동회 등(2021)의 직업능력평가 다빈도 항목을 고려하여 최소 측정 항목 비율을 선정함
- 직무수행능력평가 24항목 중 약 30% 이상 다빈도 측정 항목은 10개 항목이었음. 따라서 24개 항목 중 50%를 기준으로 단축형 평가 항목을 개발함
- 노동회 등(2021)의 직업능력 평가 항목 빈도

항목	내용	명	%
물건들어올리기	바닥에서 허리높이	1,850	86.2
	허리에서 어깨높이	1,838	85.7
	바닥에서 어깨높이	1,155	53.8
옮기기	평지·경사로, 계단	1,823	85.0
밀기와 당기기	어깨	215	10.0
	허리	1,286	60.0
	무릎	110	5.10
작업 자세	앞으로 손 뻗기	1,337	62.3
	어깨위로 손 뻗기	1,168	54.5
	웅크리기	1,534	71.5
	무릎 꿇기	153	7.1
	쫓그리고 앉기	1,282	59.8
	허리 회전하여 작업	664	31.0
	서기	194	9.0
	사다리	21	1.0
작업장 이동	걸기	1,267	59.1
	계단	931	43.4
	기어오르기(사다리이용)	261	12.2
	기기(기어가기)	33	1.5
기타	악력(근력)	1,105	51.5
	수부기능평가	261	12.2
	관절가동범위	517	24.1
	등척성평가	696	32.4
	인지 및 시지각 평가	39	1.8

- 2018년 1월~2020년 12월 직업능력평가를 실시한 산재환자의 평가 항목을 분석한 결과 전반적 신체 기능 5개 항목 중 평가되지 않음에 따라, 단축형 항목에 민첩성 평가와 평형성 평가 2개 항목을 포함함

- 직무수행평가 중 가. 모의작업동작평가 7개 항목은 물건들어올리기, 밀기와 당기기, 옮기기가 주로 3개 항목이 평가되었음
- 직무수행평가 중 나. 작업 자세 14개 항목은 앞으로 손 뻗기, 어깨위로 손 뻗기, 웅크리기, 쪼그리고 앉기, 허리 회전하여 작업 5개 항목이 주로 평가되었음
- 직무수행평가 중 다. 작업장 이동 4개 항목은 걷기, 계단오르기 2개 항목이 주로 평가되었음
- 1시간형 단축형 직업능력평가는 30개 항목 중 다빈도로 측정되는 12개 항목으로 구성함(민첩성 평가, 평형성 평가, 물건들어올리기, 밀기와 당기기, 옮기기, 손 뻗기, 어깨위로 손 뻗기, 웅크리기, 쪼그리고 앉기, 허리 회전하여 작업, 걷기, 계단오르기)
- 30분형 단축형 직업능력평가는 상지 혹은 하지 손상 산재환자로 상지 손상의 경우 30개 항목 중 상지 부위에 해당하는 6개 항목(유연성-앞으로 숙이기, 물건 들어올리기, 제자리에서 밀기/당기기, 한 손으로 물건 옮기기, 앞으로 손 뻗기, 어깨위로 손 뻗기)으로 구성하였음

구분	현행	노동희	1시간	0.5시간	
				상지	하지
1. 기본정보		○	○	○	○
2. 통증평가		○	○	○	○
3. 신체기능평가					
가. 손상부위 신체기능	관절가동범위		○	○	○
	근력	○	○	○	○
	수부악력		○	○	
	손동작		○	○	
	수부 기민성 평가 등		○		
나. 전반적 신체 기능	1)민첩성 평가(사이드 스텝)		○		○
	2)평형성 평가(눈감고 외발서기)		○		○
	3)유연성평가(상병상태에 따라 선택평가)				
	① 앞으로 숙이기			○	
	② 능동적 하지 직거상				○
	4)지구력평가(최대하 계단오르내리기)				
4. 직무수행능력 평가					
가. 모의작업동작 평가	1)물건 들어올리기	○	○	○	
	2)제자리에서 밀기/당기기	○	○	○	
	3)카트 밀기/당기기				
	4)두 손으로 물건 옮기기				
	5)한 손으로 물건 옮기기	○	○	○	
	6)어깨에 물건 올려 옮기기				
	7)등 뒤로 물건 옮기기				
나. 작업 자세	1)앉기				○
	2)서기				○
	3)눕기				
	4)앞으로 손 뻗기	○	○	○	
	5)어깨위로 손 뻗기	○	○	○	
	6)무릎 꿇기				
	7)웅크리기	○	○		○
	8)허리 회전하여 작업	○	○		
	9)어깨 숙이기				
	10)쳐다보기(아래->위)				
	11)쳐다보기(위->아래)				
	12)쪼그리고 앉기	○	○		○
	13)한발로 균형잡기				
	14) 작업				
다. 작업장 이동	1)걸기	○	○		○
	2)기어오르기(사다리이용하기)				
	3)기기(기어가기)				
	4)계단 오르기	○	○		○
5. 직업복귀 준비 도		○	○	○	○

- 하지 손상 산재환자는 하지 부위에 해당하는 9개 항목(민첩성 평가, 평형성 평가, 유연성-능동적 하지 직거상, 앉기, 서기, 웅크리기, 쪼그리고 앉기, 걷기, 계단오르기)으로 구성함

□ 1시간 단축형 작업능력평가

나. 전반적 신체기능

1) 민첩성 평가: 사이드 스텝

1회	회	중앙선을 중심으로 어깨너비만큼 양쪽 발을 벌려 선 후 스텝하 이 선을 넘어가도록 한다. 좌, 우 각 선을 통과 시 1회, 20초간 실시
2회	회	
측정결과	회	

2) 평형성 평가: 눈감고 외발서기

들어 올린다 시도	왼쪽	오른쪽	양손을 허리에 위치하고 한발을 바닥에서 고관절과 무릎을 굽혀 15cm정도 들어 올린다. 눈을 뜨거나 딛고 있는 발이 움직였을 때 또는 들었던 다리가 땅에 닿았을 때까지의 시간을 측정한다.
1회	초	초	
2회	초	초	
측정결과	초	초	

4. 직무수행 능력 평가

가. 모의작업 동작 평가

1) 물건 들어올리기(Lift)

평가명	빈도 (가끔/자주)	작업 요구 무게(kg)	최대 평가 무게(kg)	최고 심박수 (bpm)	통증		최대 무게 강도
					부위	정도 전/후	
바닥에서 허리높이						/	
바닥에서 어깨높이						/	
허리에서 어깨높이						/	
()에서 ()높이						/	

통증 정도 (평가 전/평가 후)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

최대 무게 강도	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

☐	불안정한 자세(부적절한 신체 역학)	☐	불편한 증상이나 행동 없음
참고:			

2) 제자리에서 밀기/당기기(Static pull/push)

평가명	손잡이 형태	높이 (cm) 각도 (도)	작업 요구 무게 (kg)	최대 평가 무게(kg)			최고 심박수 (bpm)	COV (%)	통증	
				좌 (kg)	우 (kg)	양측 (kg)			부위	정도 전/후
밀기		/								/
당기기		/								/

☐	불안정한 자세(부적절한 신체 역학)	☐	불편한 증상이나 행동 없음
참고:			

5) 한 손으로 물건 옮기기(Unilateral carry)

평가명		거리(미터)/ 높이(층)	빈도 (가끔/자주)	작업요구 무게(kg)	최대 평가 무게(kg)	최고 심박수 (bpm)	통증정도		최대무 게강도
							부위	정도 전/후	
평지/경사로	좌 / 우							/	
계단	좌 / 우							/	

☐	불안정한 자세(부적절한 신체 역학)	☐	불편한 증상이나 행동 없음
참고:			

나. 작업 자세 및 작업장 이동

작업자세유지	점수 MTM (%)	최고 심박수 (bpm)	평가에 걸린시간 (초)	횟수 (번)	세트 수 (번)	빈도 (가끔/자주)	통증	
							부위	정도 전/후
앞으로 손 뻗기								/
어깨위로 손 뻗기								/
웅크리기								/
허리 회전하여 작업								/
쪼그리고 앉기								/
작업								/

☐	불안정한 자세(부적절한 신체 역학)	☐	불편한 증상이나 행동 없음
참고:			

작업장 이동	거리(미터)	시간(초)	빈도 (가끔/자주)	통증	
				부위	정도 전/후
걸기					/
계단 오르기					/

작업자세유지	점수 MTM (%)	최고 심박수 (bpm)	평가에 걸린시간 (초)	횟수 (번)	세트 수 (번)	빈도 (가끔/자주)	통증	
							부위	정도 전/후
앞으로 손 뻗기								/
어깨위로 손 뻗기								/

☐ 불안정한 자세(부적절한 신체 역학)
 ☐ 불편한 증상이나 행동 없음

참고:

☐ 0.5시간 하지 손상 산재환자 단축형 작업능력평가

나. 전반적 신체기능

1) 민첩성 평가: 사이드 스텝

1회	회	중앙선을 중심으로 어깨너비만큼 양쪽 발을 벌려 선 후 스텝하 이 선을 넘어가도록 한다. 좌, 우 각 선을 통과 시 1회, 20초간 실시
2회	회	
측정결과	회	

2) 평형성 평가: 눈감고 외발서기

들어 올린다 시도	왼쪽	오른쪽	양손을 허리에 위치하고 한발을 바닥에서 고관절과 무릎을 굽혀 15cm정도 들어 올린다. 눈을 뜨거나 딛고 있는 발이 움직였을 때 또는 들었던 다리가 땅에 닿았을 때까지의 시간을 측정한다.
1회	초	초	
2회	초	초	
측정결과	초	초	

3) 유연성 평가(상병상태에 따라 선택 평가)

나) 능동적 하지 직거상

			1. 바르게 누워 머리를 바닥에 대고 팔을 손등 아래로 하여 몸 내려놓는다.
			2. 판을 무릎 아래에 놓는다
			3. 양발은 중립의 자세로 놓고 발바닥은 바닥과 직각을 이루도록 한다.
			4. 전상장골극(ASIS)과 무릎의 관절선 사이의 중간 지점을 찾아 이 지점에 붓을 바닥과 수직이 되게 놓는다.
			5. 머리는 들리지 않고 반대쪽 무릎은 판에 닿은 상태에서 다리 들어 올린다.
			점수 기준
			3점 양쪽 모두 복사뼈가 붓의 위치를 지나감
			2점 한쪽만 복사뼈 붓의 위치를 지나감
			1점 양쪽 모두 복사뼈가 붓의 위치를 지나가지 못함
	통과여부		
	왼쪽	오른쪽	
1회			
2회			
3회			
측정결과			

4. 직무수행 능력 평가

나. 작업 자세 및 작업장 이동

작업자세유지	점수 MTM (%)	최고 심박수 (bpm)	평가에 걸린시간 (초)	횟수 (번)	세트 수 (번)	빈도 (가끔/자주)	통증	
							부위	정도전/후
앉기								/
서기								/
웅크리기								/
쪼그리고 앉기								/

☐	불안정한 자세(부적절한 신체 역학)	☐	불편한 증상이나 행동 없음
참고:			

작업장 이동	거리(미터)	시간(초)	빈도 (가끔/자주)	통증	
				부위	정도 전/후
걸기					/
계단 오르기					/

직업능력평가방법 다양화에 따른 수가 개발

제4절

□ 직업능력평가 수가 현황

- 직업능력평가 수가는 기본 건강보험, 산재보험 등에서 시행되는 행위와 비교하여 개발됨

□ 2013년 직업능력평가 수가 개발 항목

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위		기존 건강보험 유사행위	수가코 드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함
① 재활상담 및 ② 직무분석	치료사/평가 사/사회복지 사 등	재활사회사업(개인 력조사)	MM141	182.45	14,778
		재활사회사업(사회 사업상담)	MM142	115.28	9,338
③ 의학적 평가	재 활 의 학 과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	16,918
		신경학적검사	F6101	211.21	17,108
④ 신체기능평가	치료사/평가 사 등	도수근력검사(전신)	E6612	87.73	7,106
		관절가동범위검사	EX773	103.29	8,366
		일상생활동작검사	EY771	95.74	7,755
		수지기능검사	EX780	126.26	10,227
⑤ 작업능력평가	치료사/평가 사/사회복지 사 등	해당 건강보험/산재보험 행위 없음			
⑥ 평가 결과에 대 한 팀 컨퍼런스	담당인력 전 체	해당 건강보험 행위는 없으나, 산재보험에서 시행중인 시범실시 재활 치료 항목 중 “전문재활치료 팀 회의료” (23,250원)에 준 용이 가능함			
⑦ 평가결과 분석 및 직업복귀소견 서 작성	재 활 의 학 과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	12,261

- 직업능력평가 수가는 ‘Eval Tech’ 이라는 장비를 이용하여 평가가 이루어져야 하고,
환자와 치료사가 1:1로 2시간 정도의 평가 시간을 요함
 - － 약 1,500,000,000원 정도에 달하는 장비 비용을 고려함
 - － 약 2시간의 평가자/치료사의 인건비에 해당하는 금액을 수가에 반영

- 평가 후 보고서를 작성하는 업무 수가에 포함
- 작업능력평가는 250,000원을 제안함
- 평가결과 분석 및 직업복귀소견서 작성 수가는 피검진자와 최종 문진이 필요로 되어, 진찰료(재진)에 준하는 시간과 노력이 들어갈 것으로 판단함
 - 직업복귀소견서는 환자에 대한 진찰, 문진 시간과는 별도로 재활의학과 의사가 별도로 작성을 해야하는 항목이며, 한 산업근로자의 직장복귀 문제가 있는 만큼 작성하는 의사입장에서도 부담이 되고 신중을 기해야하는 작업
 - 후유장애 산정을 위한 ‘후유장애진단서’ 작성에 비교할 수 있는 정도의 업무량이 있을 것으로 판단
 - 후유장애진단서는 건강보험 비급여 항목이며, 의료기관에 따라 10~20만원 정도에서 그 금액이 책정되어 있어 그 중간 정도에서 수가를 책정함이 타당할 것임
 - 직장복귀소견서 수가는 150,000원을 제안함

□ 2013년 제시한 직업능력평가 수가

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위		기존 건강보험 유사행위	수가코 드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함
① 재활상담 및 ② 직무분석	치료사/평가 사/사회복지 사 등	재활사회사업(개인 력조사)	MM141	182.45	14,778
		재활사회사업(사회 사업상담)	MM142	115.28	9,338
③ 의학적 평가	재활의학과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	16,918
		신경학적검사	F6101	211.21	17,108
④ 신체기능평가	치료사/평가 사 등	도수근력검사(전신)	E6612	87.73	7,106
		관절가동범위검사	EX773	103.29	8,366
		일상생활동작검사	EY771	95.74	7,755
		수지기능검사	EX780	126.26	10,227
⑤ 작업능력평가	치료사/평가 사/사회복지 사 등				250,000
⑥ 평가 결과에 대 한 팀 컨퍼런스	담당인력 전 체				23,250
⑦ 평가결과 분석 및 직업복귀소견 서 작성	재활의학과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	12,261
	재활의학과 전문의	직장복귀소견서			150,000
계					527,107

□ 직업능력평가지 기본 평가

○ 재활상담, 신체기능평가, 평가 결과에 대한 팀 컨퍼런스 2시간 소요 배정

- 직업능력평가는 Eval Tech 장비를 이용하여 2시간으로 배정
- 총 4시간 직업능력평가 시간 삼정

○ 기본 평가 항목

- 신체기능 평가인 도수근력검사(전신), 관절가동범위검사, 일상생활동작검사, 수지기능 검사를 통해 상지 및 하지 관절 검사와 근력 검사를 통해 기본적인 관절 범위와 근력 평가로 능동적 움직임이 가능한지 평가를 실시함
- 손과 관련해서 외형적인 이상여부와 악력 측정을 통해 손의 근력 평가로 손의 능력을 평가함
- 기본 평가 항목은 기본적인 운동 범위와 능력을 평가하여 직무수행 능력 평가를 통해 직무와 관련된 능력을 추가적으로 평가할 수 있는 기반을 마련하고 있음. 따라서 기본 평가 항목을 통해서도 직무수행 능력을 어느 정도 파악할 수 있음

① 재활사회사업(개인력조사) 행위 정의

1. 환자 또는 가족면담을 통한 사정을 한다.
 2. 자원체계 조사 및 정보수집을 한다.
 - 1) 의료적 상황 평가
 - 진단명, 의료적문제, 수술여부, 치료경과, 치료계획, 인지기능 등
 - 2) 심리사회적 평가
 - ① 인구학적 특성 - 연령, 학력, 종교, 직업, 결혼상태 등
 - ② 심리적상태
 - ③ 가족관계
 - ④ 경제력
 - ⑤ 물리적환경(주거환경 및 가옥구조)
 - ⑥ 클라이언트 개인(육구, 대처능력, 사회복지문제)
 3. 개입목표 및 개입활동 계획 수립한다.
 4. 기록 및 Answer 작성을 한다.
- * 소요시간 : 40-80분
-

② 재활사회사업(사회사업상담) 행위 정의

1. 개별면담, 가족면담을 한다.
 - 1) 개별면담
 - 환자상담/가족상담
 - 퇴원에 대한 불안감 다루기
 - 퇴원에 방해되는 요인확인
 - need파악
 - 퇴원이후 생활계획 하기
 - 2) 가족면담
 - ① 환자 및 가족이 환자의 신체적 상태를 수용하도록 한다.
 - ② 입원기간 중 가족들이 환자보호에 필요한 적절한 역할을 하고 협조하도록 한다.
 - ③ 퇴원에 필요한 심리적 환경적 보호계획을 가지고 퇴원상황에 대해 상담을 한다.
 2. 이용가능한 자원체계 소개 및 연결을 한다.
-

-
- 1) 장애인제도 및 보험에 관한 정보
 - 2) 지역사회 자원 소개 및 연결
 - 3) 장애인 단체안내
 3. 직업재활 및 교육재활에 관한 상담을 한다.
 4. 경제력 평가 및 경제적 지원활동을 한다.
 5. 퇴원계획을 한다.
 - * 소요시간 : 160-320분
-

③ 신경학적검사 행위 정의

-
1. 다음 사항에 대해 차례대로 검진하고 신경학적 결손 여부를 알아낸다.
 - 1) 각성 상태, 지남력 및 인지장애 검사
 - 2) 안면신경 검사
 - 3) 운동장애 검사
 - 4) 감각장애 검사
 - 5) 반사
 - 6) 소뇌장애 검사
 - 7) 보행장애 검사
 - 8) 경동맥 잡음 검사
 - 9) 경부강직 검사
 - * 소요시간 : 25-35분
-

- 도수근력검사(전신) 행위 정의

-
1. 환자를 양와위로 취한게 한 후 상지의 견관절 굴근, 주관절 굴근, 완관절에 대한 근력 검사를 시행하여 중력과 저항을 이기는지 검사한다.
 2. 이후 하지의 고관절 굴근, 슬관절 신근, 족관절의 검사를 하여 위의 능력을 본다. 이 후 환자를 복와위로 하여 견관절 신근, 주관절 신근, 하지에서 고관절 신근, 슬관절 굴근을 검사하여 중력과 저항을 극복하는지 관찰하고 환자를 옆으로 눕혀 중력을 제거한 상태에서 각 관절이 능동적으로 움직이는지 관찰한다.
 3. 만일 움직임이 없으면 근육의 수축상태를 먼저 파악한 후 등급을 기술한다.
 - * 중력, 저항, 관절운동범위에 따라서 6단계로 기술한다.
 - * 예를 들면 다음의 사례를 이용하여 등급을 구분한다
 - * 5 Normal : 중력과 충분한 저항 하에 능동적 정상관절 운동
 - * 4 Good : 중력과 어느정도 저항 하에 능동적 정상관절 운동
 - * 3 Fair : 중력을 이기고 능동적 관절운동
 - * 2 Poor : 중력제거 상태에서 능동적 관절운동
 - * 1 Trace : 근수축은 가능하나 능동적 관절운동은 불가능
 - * 0 Zero : 근수축의 증거 거의 없음
 - * 이상의 등급을 바탕으로 상지, 하지의 검사를 실시한다.
 - * 소요시간 : 26.67~53분
-

④ 관절가동범위검사 행위 정의

-
- * 환자를 해부학적 자세로 둔 후 각도계의 중심을 관절 중심에 일치시킨 후 수동 또는 능동적 관절운동 범위를 측정함.
 1. 수동적 관절 가동력 측정
 - 환자를 충분히 이완시킨 후 모든 평면의 관절의 움직임 정도를 측각도계를 이용하여 관절의 움직임 정도를 측정한다.
 2. 능동적 관절 가동력 측정
-

- 측정자의 보조 없이 가능한 관절의 가동력을 측정한다.

⑤ 수지기능검사 행위 정의

-
1. 환자에게 검사의 취지를 설명한다.
 2. 환자를 안정된 상태에서 책상위에 손을 올려 놓고 외형적인 이상여부를 관찰 기록한다.
 3. 악력 측정계를 사용하여 장악력을 측정하고, 악력 측정계를 사용하여 손의 악력을 측정한다.
 4. 여러도구들을 이용하여 손의 기민성을 측정한다.
-

□ Eval Tech 장비를 이용한 직업능력평가 수가 현황

- 직업능력평가 수가는 Eval Tech 장비를 이용한 작업능력평가 259,242원과 재활상담, 의학적 평가, 신체기능평가, 팀컨퍼런스, 평가결과분석을 포함한 200,758원으로 전체 수가의 43.6%를 차지하고 있음
- Eval Tech 장비를 이용한 작업능력평가 2시간과 이외 평가 2시간을 포함한 총 4시간의 수가가 460,000원임
- 단축형 작업능력평가 항목을 이용하여 1시간 측정시 이외 평가 2시간을 포함한 총 3시간의 수가는 2시간 작업능력평가의 1/2 수준인 129,621원으로 총 3시간의 수가 330,379원(작업능력평가 2시간의 71.8% 수준임)
- 상지 혹은 하지 손상 산재환자의 경우 단축형 작업능력평가 항목을 이용하여 0.5시간 측정시 이외 평가 2시간을 포함한 총 2.5시간의 수가는 2시간 작업능력평가의 1/4 수준인 64,810원으로 총 2.5시간의 수가 265,568원(작업능력평가 2시간의 57.7% 수준임)

□ 직업능력평가 수가 중 신체기능평가

- 신체기능평가는 도수근력검사 21,838원, 관절가동범위 22,637원, 일상생활동작검사 17,739원, 수지기능검사 22,163원으로 총 84,377원이었음
- 신체기능평가 수가 84,377원은 재활의료기관 3단계 시범사업 통합재활기능평가료 중추신경계 88,007원, 근골격계 56,039원, 비사용 증후군 78,390원과 비교하였을때 중추신경계 평가 수준의 95.8%로 고난이도의 평가 수가임
- 재활의료기관 수가 3단계 시범사업(2022.12)의 경우 통합재활기능평가료
 - (1) 중추신경계의 경우 간이정신진단검사, 도수근력검사, 버그 균형검사, 기본적 일상생활능력
 - (2) 근골격계의 경우 도수근력검사, 관절가동범위검사, 버그 균형검사, 기본적 일상생활능력
 - (3) 비사용 증후군의 경우 기본적 일상생활동작검사, 도수근력검사, 관절가동범위검사, 버그 균형검사

재활의료기관 통합재활기능평가료	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함
가. 중추신경계	920.19	88,007
나. 근골격계	585.94	56,039
다. 비사용 증후군	819.64	78,390

□ Eval Tech 장비를 활용하지 않은 작업능력평가 수가

- Eval Tech 장비를 이용하지 않은 작업능력평가는 실시자 작업치료사의 인건비를 고려하여 산정함

1안) 작업치료사의 인건비는 직장복귀지원 수가 중 이학요법료 신체기능 향상 훈련(30분) 혹은 모의작업 훈련(30분) 수가인 29,280원을 기준으로 2시간, 1시간, 0.5시간으로 시간 당 58,560원임

2안) 작업치료의 인건비는 재활인증 시범사업 수가 중 동적체평형검사의 경우 30분 이상 평형기능 검사기구를 이용하여 지각 조절 및 운동조절검사를 실시한 경우 32,870원으로 산정하고 있음. 따라서 32,870원을 기준으로 2시간, 1시간, 0.5시간으로 시간 당 65,740원으로 산정함

3안) 2023년 실시되고 있는 장기요양 재택의료센터 시범사업 지침에 근거하여 방문진료로 산정시 간호사, 물리치료사, 작업치료사의 상대가치점수를 350.69점을 적용하여 작업치료사의 인건비를 대체함. 30분을 기준으로 산정된 수가로 병원 20% 종별가산을 적용했을 때 시간 당 67,079원임

- Eval Tech 장비를 이용하지 않은 작업능력평가 수가 1안

- 1안의 경우 작업능력평가 시 작업치료사 인건비만 반영할 경우 2시간 117,120원, 1시간 58,560원, 0.5시간 29,280원임
- 총 작업능력평가 비용은 4시간 317,878원, 3시간 258,318원, 2.5시간 230,038원임

- Eval Tech 장비를 이용하지 않은 작업능력평가 수가 2안

- 작업능력평가 2시간 수가는 131,480원, 이외 신체기능평가 등 2시간 수가는 200,758원으로 총 4시간 수가는 332,238원, 작업능력평가 1시간 수가로 총 3시간 수가는 266,498원, 작업능력평가 0.5시간 총 2.5시간은 233,628원임

- Eval Tech 장비를 이용하지 않은 작업능력평가 수가 3안

- 작업능력평가 2시간 수가는 134,160원, 이외 신체기능평가 등 2시간 수가는 200,758원으로 총 4시간 수가는 334,918원, 작업능력평가 1시간 수가로 총 3시간 수가는 267,837원, 작업능력평가 0.5시간 총 2.5시간은 234,297원임

□ 인건비에 따른 Eval Tech 장비 원가 보존

- Eval Tech 장비 2시간 측정 기준으로 감가상각 10년, 장비 운영비(운영경비=전기료 등 장비 가동을 위한 실 경비, 산정 불가능 시 비용의 10%로 산정)¹²⁾
 - － Eval Tech 장비 1억 5천과 장비 운영비 1천 5백만원을 10년간 사용시 총 비용은 1억 6천 5백만원이며, 연간 1천 650만원임
- Eval Tech 장비를 이용한 2시간 작업능력평가 259,242원을 기준으로 1안) 58,560원일 경우, 장비 비용은 142,122원으로 연간 116회 운영시 장비의 원가를 보존할 수 있음
 - － 2안) 65,740원은 장비 비용이 127,762원으로 장비 운영이 129회되어야 하며, 3안) 67,079원일 경우 장비 비용은 125,084원으로 연간 132회 운영이 필요로 됨
 - － 2022년 기준으로 총 1,764건의 직업능력평가가 실시되어, 10개 소속 병원을 기준으로 평균 176건이 실시되었음. 이는 현재 안으로 제시하고 있는 인건비 기준 내에서 원가를 보존할 수 있는 상황임

Eval Tech*	장비비	장비 운영비
	1억 5천만원	1천 5백만원
	1억 6천 5백만원	

*10년 감가상각

구분	시간 당 인건비		
	(1안) 58,560원	(2) 65,740원	(3) 67,079원
2시간 인건비	117,120	131,480	134,158
2시간 Eval Tech 비용	142,122	127,762	125,084
Eval Tech 1년 운영	116	129	132

12) 연구장비 이용료 산정 원칙과 사례(2012). 국가연구시설장비진흥센터.

□ Eval Tech을 이용한 직업능력평가 수가 안

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위	실사자	기존 건강보험 유사행위	수가코드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함		
					총 4시간 (작업능력평가 2시간)	총3시간 (작업능력평가 1시간)	총 2.5시간 (작업능력평가 0.5시간)
① 재활상담 및 ② 직무분석	치료사/평가사/사회 복지사 등	재활사회사업(개인력조 사)	MM141	198.42	18,977		
		재활사회사업(사회사업 상담)		121.62	11,632		
③ 의학적 평가	재활의학과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	19,975		
		신경학적검사	F6101	293.50	28,070		
④ 신체기능평가	치료사/평가사 등	도수근력검사(전신)	E6612	228.34	21,838		
		관절가동범위검사	EX773	236.69	22,637		
		일상생활동작검사	EY771	185.48	17,739		
		수지기능검사	EX780	231.73	22,163		
⑤ 작업능력평가	치료사/평가사/사회 복지사 등				259,242 (2시간)	129,621 (1시간)	64,810 (0.5시간)
⑥ 평가 결과에 대한 팀 컨퍼런스	담당인력 전체				23,250		
⑦ 평가결과 분석 및 직 업복귀소견서 작성	재활의학과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	14,477		
	재활의학과 전문의	직장복귀소견서		별도산정			
계					460,000	330,379	265,568

*병원 79.7원

□ 1안) Eval Tech 장비를 이용하지 않은 직업능력평가 수가 : 시간 당 인건비 58,560원

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위		기존 건강보험 유사행위	수가코 드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%중별가산 포함		
					작업능력평가 2시간	작업능력평가 1시간	작업능력평가 0.5시간
① 재활상담 및	치료사	재활사회사업(개인력조사)	MM141	198.42	18,977		
② 직무분석		재활사회사업(사회사업상담)		121.62	11,632		
③ 의학적 평가	재활의학과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	19,975		
		신경학적검사	F6101	293.50	28,070		
④ 신체기능평가	치료사	도수근력검사(전신)	E6612	228.34	21,838		
		관절가동범위검사	EX773	236.69	22,637		
		일상생활동작검사	EY771	185.48	17,739		
		수지기능검사	EX780	231.73	22,163		
⑤ 작업능력평가	치료사				117,120 (2시간)	58,560 (1시간)	29,280 (0.5시간)
⑥ 평가 결과에 대한 팀 컨퍼런스	담당인력 전체				23,250		
⑦ 평가결과 분석 및 직업복귀소견서 작성	재활의학과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	14,477		
	재활의학과 전문의	직장복귀소견서			별도 산정		
계					317,878	259,318	230,038

* 29,280원 : 직장복귀지원 수가 중 이학요법료 신체기능 향상 훈련(30분) 혹은 모의작업 훈련(30분) 수가 적용

□ 2안) Eval Tech 장비를 이용하지 않은 직업능력평가 수가 : 시간 당 인건비 65,740원

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위		기존 건강보험 유사행위	수가코 드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함		
					작업능력평가 2시간	작업능력평가 1시간	작업능력평가 0.5시간
① 재활상담 및	치료사/평가사/사회복지사 등	재활사회사업(개인력조사)	MM141	198.42	18,977		
② 직무분석		재활사회사업(사회사업상담)		121.62	11,632		
③ 의학적 평가	재활의학과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	19,975		
		신경학적검사	F6101	293.50	28,070		
④ 신체기능평가	치료사/평가사 등	도수근력검사(전신)	E6612	228.34	21,838		
		관절가동범위검사	EX773	236.69	22,637		
		일상생활동작검사	EY771	185.48	17,739		
		수지기능검사	EX780	231.73	22,163		
⑤ 작업능력평가	치료사				131,480 (2시간)	65,740 (1시간)	32,870 (0.5시간)
⑥ 평가 결과에 대한 팀 컨퍼런스	담당인력 전체				23,250		
⑦ 평가결과 분석 및 직업 복귀 소견서 작성	재활의학과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	14,477		
	재활의학과 전문의	직장복귀소견서			별도 산정		
계					332,238	266,498	233,628

*350.69 : 상대가치점수 - 장기요양 재택의료센터 시범사업 지침에 근거하여 방문진료로 산정시 간호사, 물리치료사, 작업치료사의 상대가치점수를 적용하여 작업치료사의 인건비(30분)를 대체함

□ 3안) Eval Tech 장비를 이용하지 않은 직업능력평가 수가 : 시간 당 인건비 67,079원

작업능력평가에 따른 직업복귀소견서 작성을 위한 행위		기존 건강보험 유사행위	수가코드	상대가치점수 (건보)	병원금액(원) ~20%종별가산 포함		
					작업능력평가 2시간	작업능력평가 1시간	작업능력평가 0.5시간
① 재활상담 및	치료사/평가사/사회복지사 등	재활사회사업(개인력조사)	MM141	198.42	18,977		
② 직무분석		재활사회사업(사회사업상담)		121.62	11,632		
③ 의학적 평가	재활의학과 전문의	진찰료(초진)	AA155	208.86	19,975		
		신경학적검사	F6101	293.50	28,070		
④ 신체기능평가	치료사/평가사 등	도수근력검사(전신)	E6612	228.34	21,838		
		관절가동범위검사	EX773	236.69	22,637		
		일상생활동작검사	EY771	185.48	17,739		
		수지기능검사	EX780	231.73	22,163		
⑤ 작업능력평가	치료사			350.69*	134,160	67,079	33,539
⑥ 평가 결과에 대한 팀 컨퍼런스	담당인력 전체				23,250	23,250	23,250
⑦ 평가결과 분석 및 직업복귀소견서 작성	재활의학과 전문의	진찰료(재진)	AA255	151.37	14,477		
	재활의학과 전문의	직장복귀소견서			별도 산정		
계					334,918	267,837	234,297

*350.69 : 상대가치점수 - 장기요양 재택의료센터 시범사업 지침에 근거하여 방문진료로 산정시 간호사, 물리치료사, 작업치료사의 상대가치점수를 적용하여 작업치료사의 인건비(30분)를 대체함

직장복지지원 의료기관 지정기준 변경 방안

제5절

□ 직장복지지원 의료기관 지정기준 완화

- 기본기준, 인력, 시설장비 기준 중 직업능력평가를 위한 시설·장비의 경우 ① 직업재활 치료실(직업능력 평가실)을 갖추고, 직무수행 능력평가(모의작업 동작평가, 작업자세유지, 작업장이동)가 가능한 장비 보유하도록 하고 있음
 - － 직업능력평가장비 예시 : Baltimore Therapeutic Equipment (BTE), Ergo-Kit(EK), ERGOS Work Simulator, Isernhagen Work-system(IWS), Physical work performance evaluation(PWPE) 등
- 직업능력평가를 위한 시설·장비의 중 직무수행 능력평가가 가능한 장비를 구비하지 않은 경우도 신체기능 평가 장비, 작업치료장비, 직업재활치료장비, 전문재활치료장비를 갖춘 경우 치료뿐만 아니라 평가도 함께 실시할 수 있어 이에 대한 기준을 완화하는 것이 필요로 됨
 - － 신체기능 평가장비 : Goniometer, handheld dynamometer, Box and block test, Purdue pegboard test, Hand dynamometer, Pinch gauge, Two point discriminator
 - － 작업치료장비 : 수부 및 상지의 관절운동범위, 근력/근조절력, 고유수용감각 등 호전을 위한 훈련도구, putty, 손목 내전/외전 휠, digiti flexor, power web 등
 - － 직업재활치료장비 : 신체기능 향상 훈련(근력, 유연성, 지구력, 민첩성, 균형 등 향상), 모의작업 훈련(선반작업대, 발판 작업대, 경사로 발판, 카트, 리프트 박스, 훈련용 사다리, 높이조절 수납 앵글랙, 공구함 세트, 안전모 세트, 안전화, 중량원판, Multiple Work Tool, 볼트너트조이기 선반, 평균대, 코너 계단, 당기기용 밧줄)
 - － 전문 재활치료장비 : 보행패턴 또는 하지 장비, 수부장비, 척추장비 등

□ 직장복지지원 추가산정 기준 변경 안

- 기본직무 분석 : 실시자를 직업환경의학과와 재활의학과가 모두 실시하도록 함
- 직업능력평가 : 재활의학과 단독으로 실시하도록 변경하고, 명칭을 직업능력평가로 변경
- 직업복지소견서 : 실시자를 직업환경의학과와 재활의학과가 모두 실시하도록 함
- 직업능력평가를 재활의학과로 지정하고, 기본직무분석과 직업복지소견서를 재활의학과와 직업환경의학과가 모두 실시하여 직업능력과 현장 작업환경을 모두 고려할 수 있도록 함

□ 현재 직장복귀지원 의료기관 지정기준(80점 이상)

평가영역	조사항목	항목별 배정기준	배점
기본기준	행정처분	산재보험 의료기관으로서 직장복귀지원 의료기관 지정 신청을 한 날 이전 1년 동안 「의료법」에 따른 업무정지 이상의 행정처분을 받지 않았을 것	공통조건
인력	전문의 수	- 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 한 분야에 한정되어 2명 이상 재직 : 10점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 및 재활의학과 전문의가 각 분야별로 1명씩 2명 이상 재직 : 20점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 2명 미만 : 필수 지정기준 미충족	20
시설 장비 기준	기본재활치료실	- 물리(전기)·운동·작업치료실을 모두 갖추고 있는 경우 인정: 20점 - 미보유 치료실이 있는 경우: 필수 지정기준 미충족	20
	직업능력평가를 위한 시설장비	- 배점기준 : ①, ② 조건 모두 충족 시 인정 : 30점 ① 직업재활치료실(직업능력 평가실)을 갖추고, 직무수행 능력평가(모의작업 동작평가, 작업자세유지, 작업장이동)가 가능한 장비 보유 · 직업능력평가장비 예시 : Baltimore Therapeutic Equipment (BTE), Ergo-Kit(EK), ERGOS Work Simulator, Isernhagen Work-system(IWS), Physical work performance evaluation(PWPE) 등 ② 아래 신체기능 평가가 가능한 장비 모두 보유 · 신체기능 평가장비 : Goniometer, handheld dynamometer, Box and block test, Purdue pegboard test, Hand dynamometer, Pinch gauge, Two point discriminator - 위 ①, ② 조건 미충족 사항이 있는 경우 : 필수 지정기준 미충족	30
	기본 재 활 장 비	배정기준	아래 기본재활장비를 모두 구비시 15점
		물리(전기) 치료장비	아래 기본재활장비 중 미구비 장비가 있는 경우 : 0점 - 적외선 치료기, 초음파 치료기, 냉 치료기, 전기자극 치료기(EST), 경피적신경 자극 치료기(TENS),레이저 치료기, 공기압 치료기, 온습포, 간섭파 치료기
		운동치료장비	- 상지·하지 에르고미터, 치료용 볼·매트·계단·ROLL, 평행봉, 경사대, 어깨회전기, 보바스테이블, 트레드 밀, 등속성운동기기, 압박치료기, Exercise skate
		작업치료장비	- 주부 및 상지의 관절운동범위, 근력/근조절력, 고유수용감각 등 호전을 위한 훈련도구 · putty, 손목 내전/외전 휠, digiti flexor, power web 등 - 과제지향/반복 훈련을 위한 도구들 · 각종 페그보드(다생상 비드 페그보드, 집게형 페그보드, 원통형 페그보드, 줄 끼우기 페그보드, 다이아몬드 페그보드 등), 콘 쌓기, 구슬 끼우기, 감각볼, 나무토막 카드 동전 등
		직업재활 치료장비	- 신체기능 향상 훈련(근력, 유연성, 지구력, 민첩성, 균형 등 향상) · 땅콩볼, 밸런스 트레이너, 밸런스 패드, 짐볼, 매트, 폼 롤러, 푸쉬업 블록, 웨이트세트 (아령, 케틀벨, 바벨, 파워백 등),트레드 밀(경사적용 및 심박수 체크 가능한 장비), 스텝박스 탄력밴드, 바이크(안장 및 핸들높이와 심박수 체크 가능한 장비), 짐스틱, 중량원판, 메디슨 볼 - 모의작업 훈련 · 선반작업대, 발판 작업대, 경사로 발판, 카드, 리프트 박스, 훈련용 사다리, 높이조절 수납 앵글랙, 공구함 세트, 안전모 세트, 안전화, 중량원판, Multiple Work Tool, 볼트 너트조이기 선반, 평균대, 코너 계단, 당기기용 밧줄
	전문 재활치료장비	- 보행패턴 또는 하지 장비를 보유한 경우 : 5점 · 보행패턴 장비: Zebis FDM-T,RS SCAN 등 계열 장비 중 보유 · 하지장비 : 공압식 운동장비 - 수부장비를 보유한 경우 : 5점 (라파엘, E-link 등 계열 장비 중 보유장비가 있는 경우) - 척추장비를 보유한 경우 : 5점 (3D 뉴튼, 후버(Huber) 등 계열 장비중 보유장비가 있는 경우)	15
합 계			100
가 산 점 (5점)	지역별 분포기준	지리적 여건 및 교통편 등을 고려, 소속기관 관내 산재환자가 이용 가능한 직장복귀지원 의료기관이 없는 경우	5
	직장복귀지원 수요 판단기준	[2023년 이후부터 가점 적용] 전년도 소속기관에 화신된 직업복귀소견서 기준, 의뢰일~화신일 까지 평균기간이 3개월 이상 소요 시 직장복귀지원 의료기관에 대한 수요가 있는 경우로 인정	5

□ 직장복귀지원 의료기관 지정기준 완화 방안(80점 이상)

○ 직업능력평가를 위한 시설, 장비기준 개선으로 특정 장비 없이도 지정 가능하도록 개선

평가영역	조사항목	항목별 배정기준	배점
기본기준	행정처분	산재보험 의료기관으로서 직장복귀지원 의료기관 지정 신청을 한 달 이전 1년 동안 「의료법」에 따른 업무정지 이상의 행정처분을 받지 않았을 것	공통조건
인력	전문의 수	- 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 한 분야에 한정되어 2명 이상 재직 : 10점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 및 재활의학과 전문의가 각 분야별로 1명씩 2명 이상 재직 : 20점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 2명 미만 : 필수 지정기준 미충족	20
	기본재활치료실	- 물리(전기)·운동·작업치료실을 모두 갖추고 있는 경우 인정: 20점 - 미보유 치료실이 있는 경우 : 필수 지정기준 미충족	20
	직업능력평가를 위한 시설·장비	- 배점기준 : ① 10점, ② 20점 ① 직업재활치료실(직업능력 평가실)을 갖추고, 직무수행 능력평가(모의작업 동작평가, 작업자세유지, 작업장이동)가 가능한 장비 보유 · 직업능력평가장비 예시 : Baltimore Therapeutic Equipment (BTE), Ergo-Kit(EK), ERGOS Work Simulator, Isernhagen Work-system(WS), Physical work performance evaluation(PWPE) 등 ② 아래 신체기능 평가가 가능한 장비 모두 보유 · 신체기능 평가장비 : Goniometer, handheld dynamometer, Box and block test, Purdue pegboard test, Hand dynamometer, Pinch gauge, Two point discriminator	30
시설 장비 기준	기본 재 활 장 비	배정기준	아래 기본재활장비를 모두 구비시 15점 아래 기본재활장비 중 미구비 장비가 있는 경우 : 0점
		물리(전기) 치료장비	- 적외선 치료기, 초음파 치료기, 냉 치료기, 전기자극 치료기(EST), 경파적신경 자극 치료기(TENS), 레이저 치료기, 공기압 치료기, 온습포, 간섭파 치료기
		운동치료장비	- 상지·하지 에르고미터, 치료용 볼·매트·계단·ROLL, 평행봉, 경사대, 어깨회전기, 보바스테이블, 트레드 밀, 등속성운동기기, 압박치료기, Exercise skate
		작업치료장비	- 수부 및 상지의 관절운동범위, 근력/근조절력, 고유수용감각 등 호전을 위한 훈련도구 · putty, 손목 내전/외전 휠, digiti flexor, power web 등 - 과제지향/반복 훈련을 위한 도구들 · 각종 페그보드(다상상 비드 페그보드, 집게형 페그보드, 원통형 페그보드, 줄 끼우기 페그보드, 다이아몬드 페그보드 등), 콘 쌓기, 구슬 끼우기, 감각볼, 나무토막, 카드, 동전 등
		직업재활 치료장비	- 신체기능 향상 훈련(근력, 유연성, 지구력, 민첩성, 균형 등 향상) · 땅콩볼, 밸런스 트레이너, 밸런스 패드, 짐볼, 매트, 폼 롤러, 푸쉬업 블록, 웨이트세트 (아령, 케틀벨, 바벨, 파워백 등), 트레드 밀(경사적용 및 심박수 체크 가능한 장비), 스텝박스·탄력밴드, 바이크(안장 및 핸들높이와 심박수 체크 가능한 장비), 짐스틱, 중량원판, 메디슨 볼 - 모의작업 훈련 · 선반작업대, 발판 작업대, 경사로 발판, 카드, 리프트 박스, 훈련용 사다리, 높이조절 수납 앵글랙, 공구함 세트, 안전모 세트, 안전화, 중량원판, Multiple Work Tool, 볼트 너트조이기 선반, 평균대, 코너 계단, 당기기용 밧줄
	전문 재활치료장비	- 보행패턴 또는 하지 장비를 보유한 경우 : 5점 · 보행패턴 장비: Zebis FDM-T, RS SCAN 등 계열 장비 중 보유 · 하지장비 : 공압식 운동장비 - 수부장비를 보유한 경우 : 5점 (리파엘, E-link 등 계열 장비 중 보유장비가 있는 경우) - 척추장비를 보유한 경우 : 5점 (3D 뉴튼, 후버(Huber) 등 계열 장비중 보유장비가 있는 경우)	15
합 계			100
가 산 점 (5점)	지역별 분포기준	지리적 여건 및 교통편 등을 고려, 소속기관 관내 산재환자가 이용 가능한 직장복귀지원 의료기관이 없는 경우	5
	직장복귀지원 수요 판단기준	[2023년 이후부터 가점 적용] 전년도 소속기관에 회신된 직장복귀소견서 기준 의뢰일~회신일 까지 평균기간이 3개월 이상 소요 시 직장복귀지원 의료기관에 대한 수요가 있는 경우로 인정	5

□ 직장복귀지원 수가산정 기준 변경 안

항목	산정기준	변경 선정기준
기본 직무 분석	- 직장복귀 지원을 목적으로 <u>직업환경의학과(전공의)</u> 또는 <u>재활의학과 전문의(전공의)</u>의 처방에 따라 물리치료사, 작업치료사, 산업위생관리산업기사(또는 인간공학기사)가 실시한 경우 산정 - 직장복귀가 필요한 산재근로자에 대하여 직무 수행 시 제한이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하고 그 결과를 일정한 서식 (별지 제1호 서식)에 따라 작성·비치한 경우 산정	- 직장복귀 지원을 목적으로 <u>직업환경의학과(전공의)</u>와 <u>재활의학과 전문의(전공의)</u>의 처방에 따라 물리치료사, 작업치료사, 산업위생관리산업기사(또는 인간공학기사)가 실시한 경우 산정 - 좌동
직업능력 평가	- 직장복귀 여부 판단 또는 직무수행을 위한 직업능력 평가가 필요한 산재근로자에 대하여 <u>재활의학과 전문의(전공의)</u> 또는 <u>직업환경의학과 전문의(전공의)</u> 처방에 따라 해당 의료기관에 상근하는 작업치료사가 실시한 경우 산정 - 직무수행 능력(모의작업 동작, 작업 자세 및 작업장 이동) 등에 대한 평가가 가능한 장비를 이용하여 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제2호 서식)에 따라 작성·비치한 경우 산정 - 직업능력 강화 훈련 참여자는 전후 평가 실시	- 직업능력평가를 작업능력평가로 명칭 변경 - 직장복귀 여부 판단 또는 직무수행을 위한 직업능력 평가가 필요한 산재근로자에 대하여 <u>재활의학과 전문의(전공의)</u> 처방에 따라 해당 의료기관에 상근하는 작업치료사가 실시한 경우 산정 - 직무수행 능력(모의작업 동작, 작업 자세 및 작업장 이동) 등에 대한 평가가 가능한 장비 또는 도구를 이용하여 실시하고 그 결과를 일정한 서식(별지 제2호, 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호 서식)에 따라 작성·비치한 경우 산정 - 직업능력 강화 훈련 참여자는 전후 평가 실시
직업복귀 소견서	- 직무분석 및 직업능력 평가 결과를 반영하여 직업복귀 소견을 일정한 서식(별지 제3호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정하되, 그 결과를 공단에 제출하여야 함 - 서로 다른 전문과목 전문의가 협의진료를 통해 소견서를 작성한 경우에는 전문과목별로 수수료를 각각 산정 - 직업능력 강화 훈련에 참여한 경우 직업복귀소견서 작성은 최대 2회까지 산정	- 직무분석 및 직업능력 평가 결과를 반영하여 직업복귀 소견을 <u>직업환경의학과(전공의)</u>와 <u>재활의학과 전문의(전공의)</u>가 일정한 서식(별지 제3호 서식)에 따라 작성·비치한 경우에 산정하되, 그 결과를 공단에 제출하여야 함 - 직업능력 강화 훈련에 참여한 경우 직업복귀소견서 작성은 최대 2회까지 산정

제 7 장

사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화 방안



사업주 및 근로자 지원제도 개선방향

제1절

1. 사업주 지원제도 개선방향

- 사업주에 대한 대체인력지원 및 직장복귀지원금 지급대상을 확대하고 금액을 인상하는 조치가 필요함
 - 현재 사업주 직장복귀계획서 제출에 따른 대체인력지원금과 직장복귀지원제도 등 사업주 지원제도는 충분한 수준이 아님
 - 대체인력지원금의 경우 대상과 기간, 금액을 모두 확대하고 대체인력 고용이 어려운 서비스 업종 등에 대해서는 사회보험료를 지원하여 대체인력 고용이 용이하도록 할 필요가 있음
 - 직장복귀지원금의 경우 지원대상과 기간, 금액을 확대 필요함. 또한, 직장복귀지원금을 6개월 이상 고용을 유지한 경우에 지원하고 있어서 지원금을 조기에 지원할 수 있도록 개선함으로써 지원의 실효성을 높일 필요가 있음

< 표 7-1 > 사업주 지원제도와 개선방향

현재 지원제도	개선방향
▪ (대체인력지원금) 산재근로자가 요양으로 취업하지 못한 기간에 대체인력을 신규로 채용한 사업주에게 월 60만원 범위 내 최대 6개월까지 지원 ▪ (직장복귀지원제도) 사업주가 산재근로자(장해 12급 이상자/예정자)를 복귀시켜 6개월 이상 고용을 유지한 경우 · (직장복귀지원금) 40~80만원(최대12개월)까지 직장복귀지원금 지원 · (직장적응훈련비) 직장적응훈련(직접 또는 위탁훈련)을 실시하는 경우에는 월 최대 45만원(3개월)범위 내에서 그 비용 지원 · (재활운동비) 신체 능력회복 지원 위한 재활운동비를 월15만원(3개월) 지원	▪ 대체인력지원금 확대 · 대상 : 50인 미만→300인 미만 · 기간 : 최대 6개월 이내→1년 이내 · 금액 : 최대 월60만원 이내→월 80만원 이내 · 서비스 업종 대체인력 고용시 사회보험가입 어려움 →대체인력 고용보험 및 산재보험료 지원 ▪ 직장복귀지원제도 개선 · 지원대상 : 장해 12급 이상→장해 14급 이상 · 지원기간 : 최대 12개월→24개월 · 지원금액 : 최대 월80만원 이내→월100만원이내 · 지원요건 완화 : 장애인의무고용사업주와 무관하게 고용유지 사업주 지급(현재는 의무고용률 초과한 사업장만 지급) ▪ 직장적응훈련비 확대 · 최대 3개월 →6개월로 확대(월 45만원) ▪ 고용이상 고용을 유지한 경우가 아니더라도 선지급(직장복귀후 1개월이 지나면 청구·지급 가능토록 개선)

- 사업주 직장복귀계획서 제출에 따른 대체인력지원 및 직장복귀지원을 인센티브 형태로 운영하는 것이 필요함
 - 직장복귀계획서 제출과 사업주 지원제도가 무관하게 운영되고 있어서 계획서를 제출한 경우와 제출하지 않은 경우에 지원제도나 수준에서 차이가 없음
 - 직장복귀계획서 제출제도 조기정착 및 활성화를 위해서는 제출제도와 지원의 연계성 확보가 필요함
 - 예컨대, 대체인력지원과 직장복귀지원제도에 있어서 계획서를 제출한 경우에 금액과 기간, 대상을 확대하는 방안을 추진할 필요가 있음

- 직무전환 비용 지원이 필요함
 - 산재근로자가 장애로 인해 원직무수행이 어려워 직무 전환 후 원직장 복귀하는 경우 사업주에게 직무전환에 소요되는 비용을 보전하는 제도 마련이 필요함
 - 예컨대, 직무전환에 소요되는 훈련비와 사업주에 대한 훈련장려금 등을 지급할 수 있을 것임

- 작업환경 개선 및 보조공학기기 지원이 필요함
 - 직장복귀계획서 제출 사업장 중 작업환경 개선이 필요한 경우, 해당 비용 직접 또는 연계 지원을 강화하고, 근로자에게 필요한 보조공학기기 지원이 필요함
 - 현재 작업환경개선 비용을 안전보건공단에서 지원하고 있는 프로그램을 연계하고 있는데, 연말에 해주고 있어서 시의 적절하게 지원되지 못하고 있으며, 품목도 안 맞아서 할 수 없는 상황임
 - ※ (안전보건공단) 클린사업장(작업환경개선비 등), (장애인고용공단) 보조공학기기 지원→ ‘예산부족, 지원대상 및 품목 제한 등’ 으로 연계에 제한적임
 - ※ 유관기관(안전보건공단, 장애인고용공단) 외 외부자원 (기업등) 연계 적극 검토 및 별도 수시/상시 작업환경 개선제도 운영 필요

- 산재근로자 요양정보 제공과 직장복귀소견서 설명 활성화를 통해서 사업주가 이러한 정보를 활용하여 근로자 복귀계획을 수립할 수 있도록 해야 함
 - 사업주가 산재근로자를 조기에 복귀시키기 위해서는 산재근로자의 요양상황에 대한 이해가 필요하며, 직장복귀소견서 내용에 대한 설명과 안내 필요함. 그러나 사업주에게 해당 정보제공이 충분히 이루어지지 못하고 있음
 - 소속기관과 병원에서는 사업주에게 지속적으로 근로자의 요양정보를 제공하여 근로자의 직장복귀를 차질없이 준비할 수 있도록 하고, 직장복귀소견서 발급시 해당 내용을 충분히 설명하여 근로자가 산재 이후에 직장복귀 가능성이 어느 정도인지 확신할 수 있도록 함. 특히, 직장복귀소견서에 대해서는 소속병원의 의료전문가(지원기관 의사 또는 산재

간호사) 설명지원이 필요함

□ 직장복귀계획서 제출제도와 관련 지원제도에 대한 홍보를 강화해야 함

- 현재 직장복귀계획서 제출제도에 대한 사업주의 인식이 매우 낮고 필요성을 충분히 인지하지 못하고 있는 상황으로 산재발생 초기부터 사업주에 대하여 계획서 제출제도와 관련 사업주 지원제도를 안내하고 홍보해야 함
 - － 고객 중심 맞춤 홍보 필요. 즉, 고객욕구에 따른 필요정보 제공 위주 타겟 홍보
 - － 고객이 추천된 사회복지서비스를 적시에 이용하도록 홍보

구분	요양초기	요양 중	요양종결
산재근로자 사업주	사업주 직장복귀계획서, 사업주 지원제도, 재활치료, 심리상담 등	재활보조기구, 직업복귀소견서, 재활스포츠, 직업능력강화훈련 등	원직복귀지원(대체인력 등), 타직장복귀지원(직업훈련 등)

- － 대중교통수단, 온라인 등을 활용한 다양한 홍보
- － 사업주 직장복귀계획서 제출 사업장 및 산재노동자 경품 이벤트
- － 공단 내·외사업과 연계한 홍보 추진

2. 근로자 지원제도 개선방향

- ☐ 직장복귀가 적절하게 이루어지 못하는 이유가 근로자에게도 있는 만큼 이를 예방하고 직장복귀를 촉진시킬 수 있는 산재근로자에 대한 지원도 필요함
- ☐ 산재근로자 출퇴근 관련 이동지원 또는 차량개조 지원이 필요함
 - 산재근로자가 요양종료 후 직장에 복귀하더라도 출퇴근 이동이 불편한 경우 고용상태를 지속하여 유지하기 어려운 상황이 발생할 가능성이 높음
 - 산재근로자의 신체기능 상태를 고려하여 출퇴근 교통수단을 활용할 수 있는 교통비를 지원하거나 신체기능에 적합한 형태로 차량개조를 지원함
- ☐ 직장복귀특진에 따른 인센티브 지원이 필요함
 - 산재근로자의 경우 가능한 요양기간을 충분히 유지함으로써 충분한 치료를 받기를 원하는 경우가 대부분임. 일부의 경우 장기간 요양함으로써 직장복귀가 어려워지는 경우가 발생하기도 함
 - 일반적으로 직업복귀소견서 발급을 위해 산재근로자가 지정된 의료기관에서 가서 특진을 받는 것을 쉽게 생각하는 근로자는 많지 않을 것으로 판단되어 특진을 하는 근로자에게도 적절한 보상이 필요함
 - 산재근로자가 조기에 직장복귀에 필요한 기능을 회복할 수 있도록 직장복귀특진을 적절한 시기에 받을 수 있는 유인수단이 필요함. 따라서 직장복귀특진을 통해 직장복귀에 대한 의지를 가진 산재근로자에게 인센티브를 제공할 필요가 있음
- ☐ 산재근로자 조기 직장복귀 촉진을 위한 수당을 지원함
 - 선진국(독일, 프랑스 등)은 요양기간 중 조기 원직복귀한 경우 휴업급여를 일괄 지급하거나, 복귀촉진수당 등을 운영하고 있음
 - 산재근로자가 조기복귀에 대한 욕구가 강하고, 사업주의 조기복귀 요청이 있는 경우 산재근로자가 원직에 조기복귀할 수 있도록 조기복귀에 따른 잔여기간 휴업급여 지급 또는 복귀 촉진 수당을 신설하여 운영함
- ☐ 산재근로자에게 고용유지지원금 지원
 - 현재 6개월 이상 고용을 유지한 경우 사업주에게 직장복귀지원금을 지급하고 있지만, 근로자에 대한 지원은 없음. 그러나, 고용유지가 되지 않는 이유는 사업주 의지와 함께 근로자의 지속 근로에 대한 의지도 중요함
 - 따라서 사업주에 대한 지원과 마찬가지로 원직 또는 타직에 복귀하여 6개월 이상 지속 고용되어 근무하는 경우 근로자에게도 고용유지 지원금을 지원하는 것이 필요함

사업주 직장복귀계획서 제출제도 의무화 방안

제2절

- 산재보험법 개정을 통한 사업주 직장복귀계획서 제출 의무화(원직복귀의무화) 추진이 필요함
 - 독일, 덴마크 등 주요 국가들은 원직복귀 의무화를 전제로 법과 제도를 운영하고 있음. 즉, 이들 국가들은 일정기간 이내에 직장복귀계획을 수립하거나 직장복귀관리를 통하여 원직장에 복귀하는 것을 당연히 여기고 있음
 - 우리나라 직장복귀계획서 제출제도는 도입 초기이기는 하지만 전체 직장복귀계획서 제출대상의 약 10%만이 직장복귀계획서를 제출하고 있는 것의 주요 원인은 직장복귀계획서 제출이 권고수준에 머물러 있기 때문임. 따라서 국제적인 수준에 맞추고 제출제도를 활성화하기 위해서는 제출제도를 의무화하여 원직복귀율을 높이는 것이 필요
- 제출제도 의무화는 단계적 추진이 필요함
 - 권고수준으로 운영되고 있는 현재 제출제도를 의무조항으로 변경하고 사업주와 근로자에 대한 패널티까지 부과하는 급격한 변화는 바람직하지 않으며 단계적 의무화를 추진하는 것이 바람직함
 - (단기 : 패널티 없는 의무제도로 운영) 사업주 직장복귀계획서 제출제도를 의무조항으로 개정하되 미이행시 패널티는 부여하지 않고, 이해관계자와 협력조정을 통하여 계획서를 제출하고 원직복귀를 위해 노력하도록 적극적으로 지원함
 - 패널티 없는 의무조항으로 개정
 - 이해관계자 협력의무조항 법제화
 - 요양 중 직장복귀를 위한 특진(작업능력강화 프로그램 참여 등) 의무화
 - (중기 : 미이행시 패널티 부여) 사업주 직장복귀계획서 제출제도 의무화 관련 패널티를 일부 부여하는 규정을 마련함
 - 요양중 산재근로자 직무수행능력 평가결과, 원직복귀가 가능하다는 의학적 소견이 있는 경우에는 사업주는 원직복귀 의무화하고 이를 위반시 패널티를 부여함
 - 산재근로자도 복귀 거부시 휴업급여를 제한하는 방식의 원직복귀 의무제도를 운영함

사업주 직장복귀계획서 제출제도 활성화 방안

제3절

□ 산재근로자 원직복귀의 중요성

- 산재근로자의 원직복귀는 산재근로자와 부양되는 가족의 생활보장이라는 산재보험의 사회보험적 측면이나 재해 이전의 상태로의 원상회복이라는 손해배상적 측면 모두에 부합하는 가장 적극적인 조치로서 산재보험 재활의 목적을 가장 잘 실현할 수 있는 방법
- 즉, 원직복귀를 통해 산재근로자는 산재발생 이전의 사회적 역할로 돌아가 본래의 생활을 할 수 있게 되고, 사업주는 다양한 재활서비스를 통해 산재근로자의 부족한 노동능력을 보전 받음으로써 자신의 근로자를 되찾음과 동시에 기업의 사회적 책임을 다 할 수 있게 됨

□ 주치의 직업복귀소견서의 실효성 강화

- 사업주 직업복귀계획서가 실효성 있게 작용하기 위하여 선행되어야 할 개입은 제외국과 같이 주치의의 직업복귀 가능 여부에 대한 소견. 즉, 주치의 소견에 의해 사업주는 산재근로자를 복귀시켜야하고, 산재근로자 역시 원직장에 복귀해야 하는 것임
- 원직복귀의무제도 도입 시 산재근로자 입장에서는 주치의의 소견에 의해 본인의 작업능력을 객관적으로 인지하게 되어 재활에 대한 자신감을 가지고 원직장으로 복귀할 수 있기 때문에 성공적인 재활과 안정된 직업생활을 다시 시작할 수 있는 장점이 있음. 사업주 입장에서는 주치의 직업복귀 소견에 의해 산재근로자의 작업능력에 대해 신뢰를 가진 상태에서 산재근로자를 수용할 수 있음
- 산재근로자 주치의가 직업복귀가 가능하다는 소견 등 구체적인 의학정보를 사업주에게 충분히 제공할 필요가 있음. 뉴질랜드 산재보상기관인 ACC(Accident Compensation Corporation)에 따르면 사업주는 ① 직무수행불능으로 인식되는 경우, ② 주치의와 사업주 간 의사소통과 정보전달이 안될 경우, ③ 재해 전 직무로 복귀할 수 있는 가능성이 제한적이라고 판단되는 경우 산재근로자 직업복귀를 거부할 가능성이 높다고 함.

□ 원직복귀를 위한 사업주 및 근로자 지원 활성화

- 사업주 직업복귀계획서 제출제도 활성화를 위해서는 제도의무화와 더불어 중요한 부분이 지원제도의 현실화임
 - 이는 원직복귀에 필요한 산재근로자에 대한 임금보존과 작업시설변경 등 사업주의 추가비용이 보존됨으로써 산재근로자를 원직복귀시키는 것이 곧 사업적으로 이익이 된다는 것임
 - 구체적으로 사업주 지원제도인 직장복귀지원금, 대체인력지원제도, 직장적응훈련비용 등 지원제도를 현실화하여야 하며, 작업환경개조 지원을 통하여 산재근로자가 원직에 복귀하여 근무할 수 있는 여건을 마련해 주어야 함. 현재, 산업안전보건공단의 clean사업장 사업 및 한국장애인고용촉진공단의 작업환경개조 지원사업이 있지만 시의성이 부족한 한계가 있음. 이를 개선하거나 별도의 제도를 마련하기 위한 노력이 필요
- 직장복귀지원 의료기관 확대를 통한 접근성 강화
- 직업복귀소견서 발급 업무의 원활한 수행을 위해 직장복귀지원 의료기관 확대가 필요함. 현재 직장복귀지원 의료기관은 공단 소속병원 10개소가 지정되어 있으며 산재보험 재할인증의료기관 등 민간의료기관으로 확대 필요
- 사업주 직업복귀계획서 제출제도 홍보와 인식 제고
- 사업주에 대한 계획서 제출제도에 대한 홍보가 충분히 이루어지지 않고 있는 것으로 나타남. 제도정착을 위하여 지속적인 안내와 홍보노력을 강화해야 함. 특히, 사업주를 대상으로는 원직복귀 활성화를 위한 지원제도에 대한 홍보와 안내를 보다 충실히 해야 함
- 원직복귀 사업주의 민사상책임면제 제도 도입검토
- 원직복귀의무화제도 도입을 위해 원직복귀한 산재근로자에 대한 사업주의 민사상책임면제 제도를 도입하는 것을 검토할 필요가 있음. 현재 산재보험법 제80조(다른 보상이나 배상과의 관계)에 의해 산재보험급여 금액한도에서 손해배상 책임이 면제되거나 산재보험 급여 금액한도를 초과한 부분에 대해서는 별도의 보상(근로기준법 제87조)을 하도록 되어 있음
 - 일부 사업주와 산재근로자 사이에서는 산재보험급여 금액한도를 초과한 부분에 대한 보상문제로 인해 다툼이 일어나 감정적 문제 등으로 산재근로자가 원직복귀를 하지 못하는 상황이 발생하고 있고, 또 진료비 본인부담금이나 산재후유증상에 따른 추가 진료비가 존재할 경우 역시 사업주가 부담하게 됨으로 인해 사업주의 불만이 야기되고 있음

- 산재보상 수준이 점점 높아지고 있는 현실에서는 민사상 손해배상금액은 크지 않기 때문에 산재근로자에게 실익이 많지 않다고 보여짐
- 독일은 산재보험제도를 통해 배상이 이루어질 경우 사업주의 민사상책임을 면제시켜줌으로써 사업주와 산재근로자간의 분쟁을 제도적으로 방지하고 있음.
- 따라서 근로기준법 제87조를 개정하여 산업재해보상보험에 의한 보상이 이루어지고 산재근로자를 원직장에 복귀시킨 사업주에 한해 해당 산재근로자에 대한 보상책임을 면제시켜주는 조항을 삽입함으로써 사업주 부담과 산재근로자 복귀문제를 동시에 해결할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있음. 이러한 노력은 사업주와 산재근로자 간의 불필요한 다툼문제를 해결하여 산재근로자가 원직복귀를 하지 못하는 상황을 방지할 수 있고, 부가적으로 산재보험과 건강보험간의 진료비 부담문제를 해결하는데도 도움을 줄 수 있게 될 것임. 이로 인해 사업주는 산재보험료 이상의 재정적 지출이 발생하지 않음으로써 산재보험에 대한 신뢰도를 한층 더 높일 수 있는 계기가 마련될 수 있을 것임.

□ 산재보험법에 원직복귀를 위한 협력의무제도 도입

- 산재근로자 원직복귀의무제도에 대해 사업주 의무부분만을 강조하는 것으로 오해할 수 있으나 앞에서 살펴본 외국의 원직복귀의무제도에서는 산재근로자의 의무 역시 강조되고 있음. 독일에서는 산재근로자의 직업복귀를 위한 직업재활프로그램 참여를 의무화(사회법전 제1권 제 64조)하여 이러한 협력의무를 이행하지 않은 산재근로자는 직업재활훈련 청구권상실과 보험급여의 불이익을 감수해야 함. 그리고 미국의 많은 주에서는 산재장애인이 직업재활을 수용하지 않으면 임금대체급여액(wage replacement benefits)을 감액 함으로써 요양 기간을 줄이고 근로를 유인하고 있다. 프랑스에서는 사업주뿐만 아니라 근로자 역시 주치의의 담당권고를 받아들이도록 하고 있음
- 산재보험제도를 담당하는 고용노동부 또는 근로복지공단의 의무 역시 강조될 필요가 있음. 캐나다 온타리오주는 사업장 안전과 보험에 관한 법률 제40조(직업복귀에 대한 협력의무)에 의해 사업주의무(제1항), 근로자의무(제2항), WSIB9(제5항)의 의무 조항을 둬으로써 산재근로자의 직업복귀를 위해 사업주와 근로자 그리고 정부의 협력을 강조. 이에, 산재보험법상 산재근로자 원직복귀의무제도를 도입함에 있어 사업주, 근로자, 고용노동부(근로복지공단) 3자의 협력의무를 토대로 구성할 필요가 있음

<표 7-2> 캐나다 사업장 안전과 보험에 관한 법률(WSIA) 제40조

제 40조 직업복귀에 대한 협력의 의무

- 제1항(사업주의 의무): 사업주는 소속 근로자가 재해를 입은 경우 치료기간 동안에 소속 근로자와의 연락을 유지하고(제1호), 재해발생 이후 근로자의 노동능력을 감안하여 재해발생전 소득수준을 회복하기에 충분한 업무를 제공해야 한다(제2호).
 - 제2항(근로자의 의무): 근로자는 재해를 입은 경우 치료기간 동안에 소속 사업주와의 연락을 유지하고(제1호), 사업주가 근로자에게 노동능력을 감안한 재해발생 전 소득수준을 회복하기에 충분한 업무를 제공하는 것에 협력해야 한다(제2호).
 - 제5항(WSIB)의 지원: WSIB는 근로자가 직업복귀하는 일련의 과정을 점점하거나, 사업주와 근로자가 업무복귀에 대한 협력의 의무를 이행하는지 여부, 근로자의 업무복귀를 위하여 기타 지원이 필요한지 여부를 결정하기 위해 수시로 사업주와 근로자에게 연락할 수 있다(출처: 근로복지공단b(2007))
-

□ 원직복귀를 위한 기타 지원제도

- 원직복귀 거부 사업주의 경우 산재근로자 본인의 복귀의지 부족을 제외하고는 장애 인용 시설 및 편의시설 부족과 산재재발우려에 대한 어려움을 가장 많이 느끼고 있음. 2차 상해에 대한 사업주들의 우려를 불식시키기 위해 산재보험제도에서 산재장애인 직업복귀 시 해당근로자가 2차상해가 발생하더라도 개별실적요율에 반영시키지 않도록 하는 것을 검토할 필요가 있음

참고문헌

- 근로복지공단(2023), ‘사업주 직장복귀계획서 제출제도’ 소속기관 업무처리 매뉴얼, 근로복지공단, 2023.1
- 근로복지공단(2022), 산재노동자 일터 복귀를 위한 사업주 참여제도 도입, 언론보도자료 (2022.3.18.)
- 근로복지공단(2022), 직장복귀지원 의료기관 요양급여 산정기준 개선(안), 2022.4
- 근로복지공단(2021), ‘사업주 직장복귀계획서 제출제도’ 사업운영계획(안), 근로복지공단, 2021.11
- 원소영·윤조덕(2019), 원직장 복귀계획서 제도 운영실태 및 발전방안 연구, 근로복지공단 근로복지연구원
- 이승욱·김선규(2014), 산재근로자 원직복귀의무제도 도입논의와 과제, 지체중복건강장애 연구, 제57권 2호 : 71-91(21pages)
- 김미옥 외(2020), 제5차 재활중기계획에 대한 평가 및 개선방안 연구, 고용노동부·전북대학교 산학협력단
- 정성원 외(2022), 제6차 재활중기계획수립에 관한 연구, 우석대학교 산학협력단
- * 관련 규정
- 직장복귀 의료기관 요양급여 산정기준(2022.4.17.)
- 직장복귀 의료기관 요양급여 항목별 행위정의

[붙임 1] 직장복귀계획서 제출서식

산업재해보상보험
사업주 직장복귀계획서

접수일자		접수번호		처리기간	7 일
사업장	사업장명	사업자등록번호 (관리번호)	- - (- - -)	전화번호 (휴대전화)	- - (- - -)
	사업장주소			이메일	
	담당자명			전화번호 (휴대전화)	- - (- - -)
	팩스번호				
산재근로 자	성명		생년월일		재해일자
원직 복귀 계획	※ 근로기준법 제23조에 의거 사용자는 업무상 부상 또는 질병으로 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고를 하지 못하도록 정하고 있습니다.				
	소속 산재근로자 직장복귀 계획		☐ 복귀 예정 ☐ 복귀 미정 ☐ 기타(자진 퇴사 등)		
	복귀 미정 또는 기타 선택 사유				
	복귀직무 유형		☐ 원래 직무 ☐ 직무변경 ☐ 기타()		

■ 사업주 지원제도 상담 안내

직업복귀 소견서 발급	☐ 발급 희망 ☐ 발급 비희망 ※ 요양 중인 산재근로자의 직업복귀소견서(직무분석 및 직업능력평가 결과를 반영한 의학적 소견서)를 무료 발급하고 필요시 작업능력강화 훈련(신체기능향상 훈련, 모의작업 훈련 등) 제공				
대체인력 지원금	대체인력채용여부	☐ 채용함 ☐ 채용 예정 ☐ 채용 안함			
	지원금 제도 안내	☐ 상담 희망 ☐ 상담 비희망 ※ 재해발생 월의 말일 기준 상시근로자 수 50인 미만 사업장은 산재근로자가 요양으로 취업하지 못한 기간에 대체인력을 신규로 채용한 경우 사업주에게 월 60만원 범위 내 최대 6개월까지 지원			
직장복귀 지원제도	직장복귀지원금	☐ 상담 희망 ☐ 상담 비희망			
	직장적응훈련비	☐ 상담 희망 ☐ 상담 비희망			
	재활운동비	☐ 상담 희망 ☐ 상담 비희망			
	※ 사업주가 산재근로자(장해 12급 이상자/예정자)를 복귀시켜 6개월이상 고용을 유지한 경우 - 산재 장해등급에 따라 직장복귀지원금을 월 45~80만원(최대12개월)까지 지원 - 직장적응훈련(직접 또는 위탁훈련)을 실시하는 경우 월 최대 45만원(3개월)범위 내에서 지원 - 신체능력회복 위한 자체 시설 또는 외부 스포츠시설에서 재활운동 실시 시 월 15만원(3개월) 지원				

위와 같이 우리 회사 소속 산재근로자에 대한 직장복귀 계획을 제출하며, 필요한 사업주지원 상담을 신청합니다.

년 월 일

제출자(사업주) (서명 또는 인)

※ 근로자의 개인정보 및 민간정보 제공동의 및 사업주의 직업복귀 소견서 발급 희망에 대하여는 본 계획서 접수 전, 후 공단에서 산재근로자 동의 절차가 별도 진행됩니다.

❖ **산재근로자** 원직장복귀! 근로복지공단이 지원해 드립니다 ❖

1 | 사업주 직장복귀계획서 제출제도

- ☐ (직장복귀계획서 제출) 사업주는 소속 **산재근로자**의 직장복귀 후 수행하게 될 직무를 공단에 제출
 - ☐ (**산재근로자**) 공단은 **산재근로자**에게 직장복귀에 필요한 재활서비스(**집중재활치료·작업능력강화훈련·직장동료 화합프로그램, 사업주상담, 심리상담** 등)를 지원
 - ☐ (**사업주**) 사업주지원제도(대체인력지원금, 직장복귀지원금, 직장적응훈련비, 재활운동비 등)를 연계·안내하고 필요시 직장복귀소견서 발급 등을 지원
- ※ 산재근로자의 요양기간 및 보험급여지급내역을 제증명발급신청을 통해 받아 보실 수 있습니다.

2 | 대체인력지원금

- ☐ (지원대상) **산재근로자**의 치료기간 중 **대체인력을 고용한 상시근로자 50인 미만 사업주**
 - (**산재근로자**) 산재장해등급이 있거나 2개월 이상 산재로 치료받은 자로 고용단절 없이 복귀 후 30일 이상 고용 유지
 - (대체인력) **산재근로자** 재해일 이후 신규로 채용되어 30일 이상 고용 유지
- * 제외사항: 사업장의 산재보험료 체납, 지원기간 내 경영상 해고로 근로자를 이직시키는 경우(대체인력 보다 나중에 고용된 근로자 제외), 대체인력의 고용보험 또는 산재보험 미가입, 해당 대체인력 기준 타 법령에 의한 지원금 수령 등
- ☐ (지원 금액/기간) 사업주가 대체인력에게 지급한 임금액의 50% 범위(월 60만원 이내/최대 6개월)내 지원
- ☐ (신청기한) **산재근로자** 원직장 복귀한 날부터 30일이 지난날의 다음날부터 2년 이내 청구
- ☐ (제출서류) 신청서, **산재근로자** 및 대체인력 임금관련 서류

3 | 직장복귀지원금 등

직장복귀지원금

- ☐ (지원대상) 산재장해인(1~12급)을 원직복귀시켜 고용을 유지하고 있는 모든 사업주
- ☐ (지급요건) 요양종결일(또는 직장복귀일)부터 6개월 이상 고용유지하고 그에 따른 임금 지급
- * 제외: 장애인 의무고용 사업주로서 의무고용률 미초과, 타 법령에 의한 지원금 수령(일부 차액지급 가능)
- ☐ (지원금액/기간) 고용노동부장관 고시금액 범위내에서 사업주가 실제 지급한 임금액(최대 12개월)

제1급 ~ 제3급	제4급 ~ 제9급	제10급 ~ 제12급
월 80만원(최대 960만원)	월 60만원(최대 720만원)	월 45만원(최대 540만원)

- ☐ (청구/제출서류) 산재장해인이 원직복귀한 날부터 1개월이 지난 시점(청구서·임금대장 등)

직장적응훈련비 · 재활운동비

- ☐ (지급대상) 원직복귀한 산재장해인(1~12급)에게 **적응훈련 또는 재활운동을 실시한 사업주**
- ☐ (지급요건) ①(적응훈련비)요양종결일(또는 직장복귀일) 직전 3개월부터 요양종결일(또는 직장복귀일) 이후 6개월 이내 시작 ②(재활운동비)요양종결일(또는 직장복귀일) 이후 6개월 이내 시작
- * 요양 중 직장적응훈련의 경우에는 직장적응훈련 신청서 제출
- ☐ (지원금액/기간) 고용노동부장관 고시금액 범위내에서 사업주가 부담한 비용(최대 3개월)

직장적응훈련비*	재활운동비
월 45만원 (최대 135만원)	월 15만원 (최대 45만원)

* 직접(현장) 훈련의 경우에는 지급기준 및 요건에 따라 차등 지급

- ☐ (청구/제출서류) 직장적응훈련 또는 재활운동이 끝난 날부터 1개월이 지난 시점(청구서·소요비용 증빙서류 등)

※ 문의 : 근로복지공단 대표전화 ☎ 1588-0075 또는 사업장 소재지(본사 포함) 관할 지역본부(지사)

[붙임 2] 직장복귀지원 의료기관 지정기준 (배점합계 80점이상인 경우 인정)

평가영역	조사항목	항목별 배정기준	배점
기본기준	행정처분	산재보험 의료기관으로서 직장복귀지원 의료기관 지정 신청을 한 날 이전 1년 동안 「의료법」에 따른 업무정지 이상의 행정처분을 받지 않았을 것	공통조건
인력	전문의 수	- 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 한 분야에 한정되어 2명 이상 재직 : 10점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 및 재활의학과 전문의가 각 분야별로 1명씩 2명 이상 재직 : 20점 - 공단이 제공하는 산재보험 교육을 이수한 직업환경의학과 또는 재활의학과 전문의가 2명미만 : 필수 지정기준 미충족	20
시설 장비 기준	기본재활치료실	- 물리(전기)·운동·작업치료실을 모두 갖추고 있는 경우 인정: 20점 - 미보유 치료실이 있는 경우 : 필수 지정기준 미충족	20
	작업능력평가 장비	- 배점기준 : ①,② 조건 모두 충족시 인정 : 30점 ① 직업재활치료실(작업능력평가실)을 갖추고, 직무수행 능력평가(모의작업 동작평가, 작업자세유지, 작업장이동)가 가능한 장비 보유 * 작업능력평가장비 예시 : Baltimore Therapeutic Equipment (BTE), Ergo-Kit(EK), ERGOS Work Simulator, Isernhagen Work-system(IWS), Physical work performance evaluation(PWPE) 등 ② 아래 신체기능 평가가 가능한 장비 모두 보유 · 신체기능 평가장비 : Goniometer, handheld dynamometer, Box and block test, Purdue pegboard test, Hand dynamometer, Pinch gauge, Two point discriminator - 위 ①,② 조건 미충족 사항이 있는 경우 : 필수 지정기준 미충족	30
	기본 재활 장비	배정기준	아래 기본재활장비를 모두 구비시 15점 아래 기본재활장비 중 미구비 장비가 있는 경우 : 0점
		물리(전기)치료장비	- 적외선 치료기, 초음파 치료기, 냉 치료기, 전기자극 치료기(EST), 경피적신경자극 치료기(TENS),레이저 치료기, 공기압 치료기, 온습포, 간섭파 치료기
		운동치료장비	- 상지·하지 에르고미터, 치료용 볼·매트·계단·ROLL, 평행봉, 경사대, 어깨회전기, 보바스 테이블, 트레드 밀, 등속성운동기기, 압박치료기, Exercise skate
		작업치료장비	- 수부 및 상지의 관절운동범위, 근력/근조절력, 고유수용감각 등 훈련을 위한 훈련도구 · putty, 손목 내전/외전 휠, digiti flexor, power web 등 - 과제지향/반복 훈련을 위한 도구들 · 각종 페그보드(다생상 비드 페그보드, 집게형 페그보드, 원통형 페그보드, 줄 끼우기 페그보드, 다이아몬드 페그보드 등), 콘 찢기, 구슬 끼우기, 감각볼, 나무토막, 카드, 동전 등
		직업재활치료장비	- 신체기능향상(근력, 유연성, 지구력, 민첩성, 균형 등 향상) · 덩굴볼, 밸런스 트레이너, 밸런스 패드, 짐볼, 매트, 폼 롤러, 푸쉬업 블록, 웨이트세트(아령, 케틀벨, 바벨, 파워백 등),트레드 밀(경사적용 및 심박수 체크 가능한 장비), 스텝박스, 탄력밴드, 바이크(안장 및 핸들높이와 심박수 체크 가능한 장비), 짐스틱, 중량원판, 메디슨 볼 - 모의작업훈련 · 선반작업대, 발판 작업대, 경사로 발판, 카트, 리프트 박스, 훈련용 사다리, 높이조절 수납 앵글랙, 공구함 세트, 안전모 세트, 안전화, 중량원판, Multiple Work Tool, 볼트너트조이기 선반, 평균대, 코너 계단, 당기기용 밧줄
		전문 재활치료장비	- 보행패턴 및 하지 장비를 보유한 경우 : 5점 · 보행패턴 장비: Zebri FDM-T,RS SCAN 등 계열 장비 중 보유 · 하지장비 : 공압식 운동장비 - 수부장비를 보유한 경우 : 5점 (라파엘, E-link 등 계열 장비 중 보유장비가 있는 경우) - 척추장비를 보유한 경우 : 5점 (3D 뉴튼, 후버(Huber) 등 계열 장비중 보유장비가 있는 경우)
	합 계		100
가 산 점 (5점)	지역별 분포기준	지리적 여건 및 교통편 등을 고려, 소속기관 관내 산재환자가 이용 가능한 직장복귀지원 의료기관이 없는 경우	5
	직장복귀지원 수요 판단기준	[2023년 이후부터 가점 적용] 전년도 소속기관에 회신된 직장복귀수요조사 기준, 의뢰일~회신일 까지 평균기간이 3개월 이상 소요 시 직장복귀지원 의료기관에 대한 수요가 있는 경우로 인정	5

기초 상담(안)

※ 서식 명칭은 소속병원 영양급여 산정기준 서식 목록을 감안하여 변경될 수 있음

성명		성별	☐ 남 ☐ 여	생년월일	
주소			연락처		
재해일자			실시일자		
상병명					

1. 대상자			
상담방법	☐ 전화상담		
대상자	☐ 산재환자 ☐ 사업주 또는 관계자 ☐ 기타 ※ 가족 상담 시 기록 _____		
수술유무	☐ 예 (수술부위 _____ 수술명 _____) ☐ 아니오	수술일자	_____ . _____ . _____
2. 직업정보 등 세부 상담내용			
직종	☐ 단순 노무 종사자 ☐ 건설업 종사자 ☐ 제조업 종사자 ☐ 유통업(_____) ☐ 사무직(_____) ☐ 전문직(_____) ☐ 기능직(_____) ☐ 기타(_____)		
고용형태	☐ 정규직 ☐ 임시직 ☐ 일용직 ☐ 기타(_____)		
사업장 규모 및 특징	※ 어떤 회사인지?		
직업목귀 의사	☐ 유(복귀유형: _____) ☐ 무		
주요 상담 및 애로사항	※ 통증으로 인한 우울, 도보에 대한 욕구, 원직복귀, 회사, 동료와의 애로사항 등 기재		
3. 서비스 제공			
특별 진찰	정보 제공	☐ 예 ☐ 아니오	직업복귀소견서 제출 정보 제공 ☐ 예 ☐ 아니오
	희망여부	☐ 희망 ☐ 비희망	전원희망 여부 ☐ 희망 ☐ 비희망
4. 상담자			
상담자 직종 (해당항목 √ 표기)	☐ 간호사 ☐ 산재관리간호사		
위와 같이 상담을 실시하였음을 확인합니다. 년 월 일 근로복지공단 _____ 병원 성명 _____ (서명)			

- 163 -